



Procedimientos de Actuación Extrahospitalaria para Equipos de Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAE)



Elaborado por: Grupo trabajo SVAE	Revisado por: Unidad de Calidad	Aprobado por: Director Gerente 061
Fecha de la versión: 07/01/2025	Versión: 1.0	Fecha última revisión: 03/01/2025
Ámbito aplicación: Gerencia 061	Tipo de documento: Procedimiento	Fecha de aprobación: 07/01/2025
Ubicación en la INTRANET: Protocolos y procedimientos de las bases/ específicos SVAE	Fecha publicación: 07/01/2025	Fecha próxima revisión: julio de 2025



Procedimientos de Actuación Extrahospitalaria para Equipos de Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAE)

COORDINACIÓN Y REDACCIÓN:

Maside Mielgo, Eva.

AUTORES:

Equipo Trabajo SVAE: Maside Mielgo, Eva; Correa Martín, Carmen; Cánovas Martínez, Carolina; Sánchez Corbalán, J. Lorenzo; Sánchez Martínez, Sonia; González Uceda, Inés M.

ASESORAMIENTO Y VALIDACIÓN:

Gómez Sánchez, Remedios; López Rodríguez, Trinidad.

REVISORES:

Unidad Calidad Gerencia 061: Alonso Fernández, Rosario; García Pastor, Evaristo; García Méndez, Juan A.

Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia
C/Escultor José Sánchez Lozano7,
2ªPlanta - 30005 Murcia



Puesto y firma:
Director Gerente 061.
D. Francisco Celdrán Gil
(Documento firmado electrónicamente al margen)

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de Murcia. Asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en <http://10.181.8.6/intranet/>



ÍNDICE

0. Fundamentos de los procedimientos SVAE.....	3
1. Procedimiento General de Actuación SVAE.....	5
2. Atención ante una Parada Cardiorrespiratoria.....	15
3. Atención al Paciente con Trauma Grave.....	21
4. Atención al Paciente con Síndrome Coronario Agudo.....	28
5. Atención al Paciente con ICTUS.....	34
6. Atención al Paciente con Dolor Agudo.....	43
7. Atención al Paciente con Cuadro Sincopal.....	51
8. Atención al Paciente con Convulsiones.....	57
9. Atención al Paciente con Alteración de la Glucemia.....	63
10. Atención al Paciente Agitado.....	70
11. Atención al Paciente con Disnea.....	75
12. Atención al Paciente Intoxicado.....	80
13. Atención al Paciente Quemado.....	85
14. Procedimiento toma de muestras en Covid-19 por unidades SVAE.....	92
15. Procedimiento toma de muestras MPOX por unidades SVAE.....	97
ANEXOS	
Anexo 1. Revisión visual de mochilas de circulatorio y respiratorio.....	104
Anexo 2. Fichas de Guía farmacológica 061.....	110



0. FUNDAMENTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS SVAE

0.1 Introducción

El Soporte Vital Avanzado Enfermero (SVAE) constituye una pieza fundamental en la cadena de atención sanitaria urgente y emergente, desempeñando un papel crucial en la estabilización y tratamiento inicial de pacientes en el ámbito extrahospitalario. Los procedimientos descritos tienen como objetivo principal estandarizar las intervenciones de los equipos SVAE, garantizando una atención homogénea, eficaz y centrada en el paciente, bajo los principios de calidad, seguridad y humanización de la asistencia.

0.2 Objetivo General

Proveer un marco de referencia que facilite la toma de decisiones clínicas y operativas en el entorno extrahospitalario, promoviendo buenas prácticas y fortaleciendo la coordinación entre los equipos de SVAE y el resto del sistema de emergencias sanitarias.

0.3 Principios Fundamentales

- 1. Seguridad del paciente:** La atención prestada debe minimizar los riesgos inherentes al entorno extrahospitalario y priorizar siempre el bienestar y la seguridad del paciente.
- 2. Actuación basada en la evidencia:** Los procedimientos descritos se fundamentan en la mejor evidencia científica disponible y en las recomendaciones de sociedades científicas nacionales e internacionales.
- 3. Humanización de la atención:** El cuidado prestado por los equipos SVAE debe contemplar el respeto a la dignidad, los valores y las necesidades individuales del paciente y sus familiares.
- 4. Interdisciplinariedad y trabajo en equipo:** Fomentar una colaboración eficaz entre los diferentes profesionales implicados en la atención extrahospitalaria, desde la intervención inicial hasta la derivación a otros niveles asistenciales.
- 5. Adaptabilidad al entorno:** Reconocer la singularidad del entorno extrahospitalario, desarrollando estrategias flexibles y ajustadas a las particularidades de cada situación.



0.4 Alcance

Estos procedimientos están dirigidos a los profesionales que integran los equipos de SVAE, así como a otros actores del sistema de emergencias médicas que interactúan con estos equipos. Incluyen protocolos y procedimientos específicos, para garantizar la adecuada coordinación entre las distintas unidades operativas y optimizar el uso de los recursos disponibles. Asimismo, establecen pautas de comunicación, integración y respuesta ante situaciones críticas o de alta complejidad, fomentando la colaboración interdisciplinar y la mejora continua en la calidad asistencial.

0.5 Justificación

La creación de procedimientos específicos para SVAE responde a la necesidad de:

- Optimizar los recursos disponibles. Proporcionar herramientas que permitan a los equipos actuar de manera eficiente, maximizando el impacto de sus intervenciones.
- Reducir la variabilidad clínica. Establecer un marco común que garantice la uniformidad en la práctica asistencial.
- Aumentar la satisfacción del paciente y su familia. Mejorar la percepción de la calidad del servicio a través de una atención más estructurada y centrada en el usuario.
- Responder a la creciente demanda asistencial. Adaptarse a las nuevas necesidades del sistema sanitario y a las exigencias de la población atendida.



1. PROCEDIMIENTO GENERAL DE ACTUACIÓN SVAE

1.1 Introducción

Las unidades de Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAE) desempeñan un papel clave en este proceso. Estas unidades están compuestas por un Enfermero y un Técnico en Emergencias Sanitarias (TES), que trabajan en estrecha colaboración con los Médicos Directivos (MD) y los Enfermeros Directivos (ED) del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias de Murcia (CCU).

Los equipos SVAE pueden realizar una primera valoración in situ con el objetivo de:

- Resolver la situación en el lugar.
- Activar los recursos necesarios.
- Prestar la primera asistencia mientras llega un segundo recurso si precisa.

Todo esto se lleva a cabo bajo las directrices y supervisión del Médico Directivo del CCU. Durante la intervención, los equipos SVAE transmiten los datos relevantes y los resultados de las pruebas realizadas, permitiendo al MD valorar, prescribir y, junto con enfermería, establecer las actuaciones y el plan de cuidados en función de las necesidades del paciente.

Esta intervención puede realizarse como primer interviniente o como apoyo a otras unidades, como las Unidades Móviles de Emergencia (UME) o los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP).

1.2 Definición

Las unidades de Soporte Vital Avanzado de Enfermería están integradas por un enfermero y un Técnico en Emergencias Sanitarias. Estas unidades operan bajo la supervisión y colaboración continua de los Médicos Directivos (MD) y Enfermeros Directivos (ED) de la sala del Centro Coordinador de Urgencias.



1.3 Objetivos

1. **Identificar y tratar signos de alarma** que presente el paciente, siguiendo las indicaciones del Médico Directivo del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias (CCU).
2. **Realizar una valoración integral** del paciente y de la situación para determinar la necesidad de activar un segundo recurso.
3. **Recabar datos clínicos y pruebas complementarias** que permitan, en colaboración con el Médico Directivo del CCU, alcanzar un diagnóstico preciso.
4. **Prestar los cuidados necesarios** durante el episodio de enfermedad, evitando demoras y eliminando intervenciones intermedias que no aporten valor añadido.
5. **Garantizar la continuidad asistencial** en la transferencia del paciente a otras unidades o recursos asistenciales, como UME, SUAP, Atención Primaria o atención hospitalaria.
6. **Actuar como unidad de apoyo**, realizando las intervenciones indicadas por la unidad responsable en coordinación con el CCU.

1.4 Ámbito de Aplicación

Pacientes adultos y pediátricos del ámbito extrahospitalario en la Región de Murcia que, según los protocolos de activación de emergencias, son susceptibles de recibir Soporte Vital Avanzado Enfermero (SVAE).

Ámbito de actuación:

El lugar de intervención de las unidades SVAE incluye, entre otros:

- Vía pública
- Domicilios particulares
- Otros escenarios específicos que se determinen según la situación.

Destino del paciente:

El destino será determinado por el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias (CCU), en función de la valoración realizada, y podrá incluir:

- Atención in situ
- Transferencia a otra unidad asistencial
- Derivación al hospital de referencia o al más cercano
- Otros destinos específicos según las necesidades del paciente y la situación clínica.



1.5 Materiales

En todas las unidades SVAE, las dotaciones están completamente estandarizadas, lo que garantiza uniformidad en los recursos disponibles y minimiza errores en la atención. Para las intervenciones, cada unidad dispone:

- Monitor y parches desfibrilación
- Ampulario con medicación
- Mochila de Circulatorio
- Mochila de Respiratorio

Todo el material está organizado de manera idéntica en cada unidad, con los mismos contenidos y ubicaciones dentro de las mochilas, lo que facilita el acceso rápido en situaciones críticas, simplifica las revisiones y asegura que el personal de nueva incorporación se adapte más fácilmente al sistema. Antes de cada guardia, se realiza una revisión exhaustiva de las mochilas y del material de las ambulancias, verificando que todo esté completo, en buen estado y en su lugar correspondiente. (Anexo 1)

1.6 Plan de Actuación

La primera atención sigue tres componentes básicos:

1. **Proteger:** Garantizar la seguridad del equipo asistencial, el paciente, la escena y terceras personas. Es fundamental tomar las medidas necesarias para minimizar riesgos.
2. **Alertar:** Solicitar recursos adicionales en caso necesario (por ejemplo, policía, bomberos, etc.).
3. **Socorrer:** Iniciar la actuación directa con el paciente.

Valoración de la Seguridad de la Escena

Antes de intervenir, se debe evaluar la seguridad del entorno. Si la escena no es segura, es imprescindible notificarlo al CCU y actuar únicamente cuando se haya restablecido la seguridad, empleando el equipo de protección adecuado para cada situación.

En esta fase inicial, se llevará a cabo una valoración de la escena para identificar los hechos ocurridos, determinar el mecanismo lesional y obtener una impresión general sobre la gravedad del paciente.

Valoración Primaria

Una vez valorada la seguridad de la escena y la impresión inicial del paciente, se procede a la valoración primaria. Este paso tiene como objetivo identificar y tratar de manera



inmediata los síntomas que representen un riesgo vital, siguiendo el enfoque estructurado de la regla mnemotécnica XABCDE: (Ver punto 1.8)

- **X Exanguinación Masiva:** Identificar y controlar hemorragias masivas externas.
- **A (Vía Aérea):** Estado de alerta y permeabilidad de la vía aérea.
- **B (Respiración):** Valoración de la respiración.
- **C (Circulación):** Control de la circulación y manejo de hemorragias.
- **D (Disfunción Neurológica):** Evaluación de la función neurológica.
- **E (Exposición):** Exposición y control de factores ambientales.

Si es necesario, se llevarán a cabo maniobras críticas y salvadoras, en constante comunicación con el Enfermero Directivo (ED) y el Médico Directivo (MD), siempre bajo la supervisión de este último.

En caso de **parada cardiorrespiratoria (PCR)**, se actuará conforme al protocolo establecido, recogiendo información relevante cuando la situación lo permita.

Cualquier hallazgo de interés será comunicado de inmediato al MD para su valoración.

Valoración secundaria

La Valoración Secundaria se basa en un análisis más detallado y específico, que incluye la anamnesis, un examen físico sistemático y la monitorización completa de los signos vitales. Su objetivo principal es identificar el problema de salud del paciente, orientar el diagnóstico y garantizar que se mantenga una situación estable y confortable.

1. Recogida de Datos Clínicos:

- Alergias conocidas a medicamentos.
- Antecedentes patológicos y/o de interés.
- Medicación previa del paciente.
- Motivo de la llamada o consulta.

2. Medición de Constantes:

- Toma de Tensión Arterial (TA).
- Medición de glucemia capilar.
- Registro de temperatura corporal.
- Medición de saturación parcial de oxígeno (SpO₂).
- Evaluación de la frecuencia cardíaca (FC).
- Valoración del dolor mediante la escala EVA (Escala Visual Analógica).



Si el MD lo considera necesario:

- Se realizará un **Electrocardiograma (ECG)**.
- La captura del ECG se adjuntará en tiempo real a través de la **APP ECHO**.

Toda la información recopilada será transmitida al Médico Directivo (MD), quien, con el apoyo del equipo SVAE, **establecerá las intervenciones y actuaciones necesarias** para garantizar la mejor atención al paciente.



Protocolo: Algoritmo Activación _ **SVAE 061**

Soporte Vital Avanzado de Enfermería

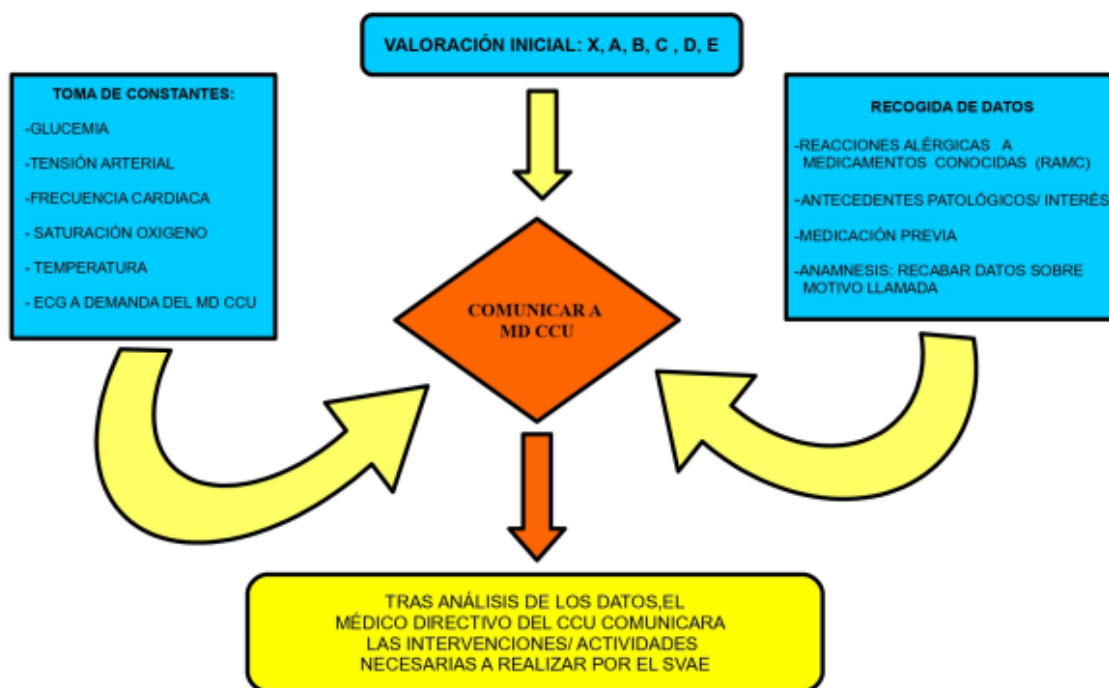
SVAE
Soporte Vital Avanzado de Enfermería

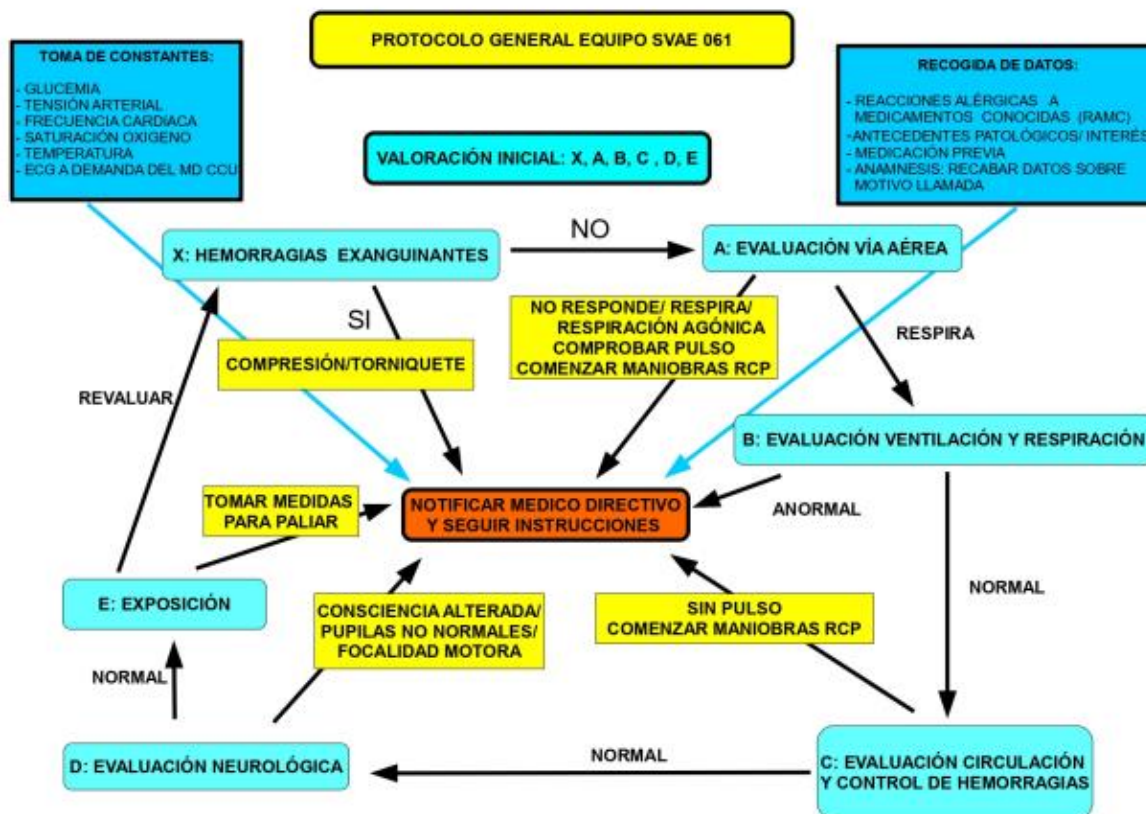
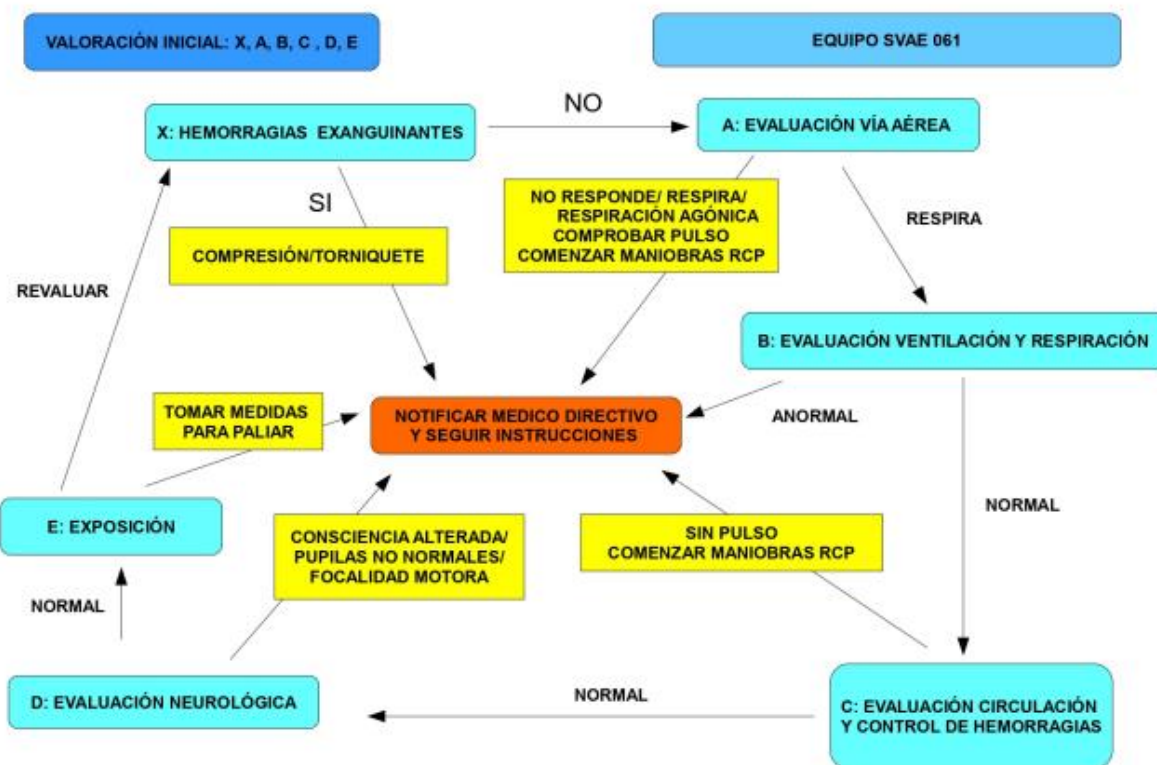


* 061 realizará los traslados a urgencias de hospital de Pacientes Psiquiátricos de H. Román Alberca, que precisen atención medica por patología aguda, en horario de noche entre semana, y los Fines de Semana y Festivos

* En todas aquellas asistencias que impliquen funciones que no sean exclusivamente de enfermería, harán de apoyo a las unidades medicalizadas, estando el SVAE en contacto con el médico del CCU para recibir indicaciones.

ALGORITMO GENERAL DE ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES SVAE 061





1.7 Historia de Cuidados de Enfermería (SVAE)

En la Historia de Cuidados de Enfermería Extrahospitalaria se deben registrar, como mínimo, los siguientes datos:

Servicio
Murciano
de Salud

HISTORIA CUIDADOS ENFERMERÍA

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASISTENCIA

UNIDAD	AÑO	MES	DÍA	NÚMERO ASUNTO	PA	CARGO A TERCEROS	CÓDIGO CONDUCTOR	CÓDIGO TÉCNICO/CELADOR
						SI No		
HORA LLAMADA	HORA IN SITU	HORA HOSPITAL	HORA LIBRE					
Motivo de Consulta				NSS/DNI	Teléfono			
Nombre y Apellido						Sexo V M	Edad	Zona Básica de Salud
Domicilio						Lugar de la Asistencia		

II. ALERGIAS, ANTECEDENTES Y ANAMNESIS

PACIENTE COLABORADOR: ☐ SI ☐ NO

ALERGIAS: ☐ SI ☐ NO ☐ DESCONOCIDAS

ANTECEDENTES DE INTERÉS: ☐ HTA ☐ DM ☐ HLP ☐ C. ISQ ☐ EPOC ☐ I. REN ☐ ACO ☐ ANTICOAGULANTE/ANTIAGREGANTE: _____ ☐ PLURIPATOLÓGICO

☐ POLIMEDICACIÓN ☐ INGRESOS HOSPITALARIOS ÚLTIMO AÑO (3 O MÁS) ☐ TÓXICOS. TIPO: _____ CANTIDAD: _____ ☐ FUMADOR. CIGARROS DÍA Nº: _____

ANTECEDENTES R/C CALIDAD DE VIDA PROCEDE: ☐ SI ☐ NO EJERCICIO FÍSICO: ☐ SI ☐ NO AL MENOS UNA VEZ AL: ☐ MES ☐ SEMANA ☐ CASI TODOS LOS DÍAS

ABVD: ☐ DEPENDIENTE ☐ TOTALMENTE DEPENDIENTE ☐ INDEPENDIENTE

ANAMNESIS:

III. EXPLORACIÓN FÍSICA/PROCEDIMIENTOS

X HEMORRAGIA EXANGUINANTE ☐ SI ☐ NO

A VÍA AÉREA PERMEABLE ☐ SI ☐ NO

B VENTILACIÓN ESPONTÁNEA ☐ SI ☐ NO

C CIRCULACIÓN

Piel

☐ Normal ☐ Cianosis periférica

☐ Pálida ☐ Seca

☐ Fría ☐ Sudorosa ☐ Otros: _____

PULSOS

	Radial	Femoral	Carotídeo	R. CAPILAR
Inicial				<2 sg >2 sg
Final				

N- Normal D- Débil A- Ausente

D NEUROLÓGICO

☐ Consciente ☐ Obrunilado ☐ Estuporoso

☐ Coma - Inconciencia ☐ Focalidad neurológica

☐ Amnesia episodio ☐ Inconciencia previa: _____ min

GLASGOW

PUPILAS

	Derecha	Izquierda
	Ø Reac	Ø Reac
INICIAL	•••	•••
FINAL	•••	•••

OCULAR: ☐ Espontánea (4) ☐ Al sonido (3) ☐ A la presión (2) ☐ Ninguna (1)

VERBAL: ☐ Orientado (5) ☐ Confuso (4) ☐ Inapropiada (3) ☐ Sonidos (2) ☐ Ninguna (1)

MOTORA: ☐ Obedece órdenes (6) ☐ Localiza (5) ☐ Flexión (3) ☐ Extensión (2) ☐ Ninguna (1)

ESCALA DOLOR (EVA)

0 Sin dolor 1 Poco dolor 2 Dolor moderado 3 Dolor fuerte 4 Dolor muy fuerte 5 Dolor extremo

INMOVILIZACIÓN

☐ Mov. Rápida emergencia

☐ Inmov. de cabeza ☐ Retirada casco por E.E

☐ Corsé espinal ☐ Collarín cervical ☐ Dama Elche

☐ Tablero espinal ☐ Camilla Tijera ☐ Colchón vacío

☐ Férula de miembros ☐ Otros: _____

IV. EVOLUCIÓN, CONSTANTES VITALES Y APOYO TERAPEÚTICO

HORA	Frec. Respiratoria	SatO ₂ /EtCO ₂	Pulso (F.C)	Tensión Arterial	Glucemia	Temperatura	MEDICACIÓN Y FLUIDOTERAPIA ADMINISTRADA																								
							Médico prescriptor: ☐ CCU ☐ Asistencial																								
							<table border="1"> <tr> <th>Hora</th> <th>Vía</th> <th>Dosis</th> <th>Medicamento/Fluidoterapia</th> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Hora	Vía	Dosis	Medicamento/Fluidoterapia																				
Hora	Vía	Dosis	Medicamento/Fluidoterapia																												



1.8 Valoración Inicial X-A-B-C-D-E

La evaluación **XABCDE** es un enfoque estructurado y prioritario en emergencias para identificar y tratar problemas vitales de forma inmediata. Cada letra corresponde a una fase crítica de la valoración:

X – Exanguinación Masiva

- Identificar y controlar **hemorragias masivas externas** que comprometan la vida.
- Actuar rápidamente con **torniquetes, compresión directa** o vendajes hemostáticos según sea necesario.

A – Airway (Vía Aérea)

- Evaluar y garantizar la **permeabilidad de la vía aérea**.
- Verificar signos de obstrucción (ronquidos, estridor, cianosis, agitación).
- Realizar maniobras como:
 - Elevación del mentón o tracción mandibular.
 - Aspiración de secreciones.
 - Inserción de dispositivos como cánulas orofaríngeas.

B – Breathing (Respiración)

- Evaluar la **ventilación y oxigenación**:
 - Frecuencia y patrón respiratorio.
 - Saturación de oxígeno (SpO₂).
 - Auscultación de ruidos respiratorios.
- Tratar alteraciones:
 - Administración de **oxígeno suplementario**.
 - Ventilación asistida si es necesario.

C – Circulation (Circulación)

- Evaluar **perfusión y circulación sanguínea**:
 - Frecuencia y ritmo cardíaco.
 - Tensión arterial.
 - Signos de hipoperfusión (piel fría, palidez, relleno capilar prolongado).
- Actuar en caso de shock:
 - Control de hemorragias.
 - Acceso vascular y administración de fluidos si está indicado.



D – Disability (Discapacidad/Estado Neurológico)

- Evaluar el **estado neurológico** utilizando la escala **AVDI**:
A (Alerta), **V** (Respuesta verbal), **D** (Respuesta al dolor), **I** (Inconsciente).
- Valorar **pupilas** (tamaño y reactividad).
- Identificar signos de deterioro neurológico (confusión, coma, convulsiones).

E – Exposure (Exposición)

- **Desvestir completamente** al paciente para buscar lesiones ocultas o signos adicionales.
- Proteger al paciente del **frío** y de factores ambientales para evitar **hipotermia**.

1.8 Bibliografía

1. Procedimiento General de Actuación SVAE. Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de la Región de Murcia. 2022.
2. Atención al trauma grave. María Victoria López Gaitano, Juan Carlos Valverde Oliva. Gerencia de Urgencias y Emergencias Región de Murcia. 03/11/2020.
3. Procedimientos Asistenciales S.V.A. Enfermería. Víctor Casas Benavent, Rómulo Iniesta Roser. SES. Generalitat Valenciana. 2021.
4. Cuidados de Enfermería en la Atención Extrahospitalaria. Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. 2019
5. Protocolo de actuación de los Equipos de Coordinación Avanzada: Trauma Grave. Emergencias Sanitarias 061. Junta de Andalucía. 1 de Agosto de 2011.
6. Manual de Protocolos Asistenciales. Plan Andaluz de Salud Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud. Servicio Andaluz de Salud. 2012



2. ATENCIÓN ANTE UNA PARADA CARDIORRESPIRATORIA

2.1 Definición

La parada cardiorrespiratoria (PCR) es una situación clínica en la que se produce el cese de la circulación y/o la respiración, siendo una condición potencialmente reversible si se actúa con rapidez.

El **Soporte Vital Básico (SVB)** comprende un conjunto de intervenciones dirigidas a restablecer el flujo circulatorio mediante maniobras de reanimación, como el masaje cardíaco, y otras técnicas básicas o instrumentadas. Por otro lado, el **Soporte Vital Avanzado (SVA)** combina el SVB con maniobras invasivas y la administración de fármacos con el objetivo de recuperar la circulación espontánea.

2.2 Objetivos

- Reconocer de manera precoz los signos de alarma y activar los recursos adecuados a la situación.
- Aplicar maniobras de RCP básica y/o avanzada, según corresponda.
- Realizar desfibrilación en caso necesario, siguiendo el protocolo establecido.
- Proporcionar cuidados postresucitación para garantizar la estabilización y el seguimiento del paciente.

2.3 Ámbito de Aplicación

Persona en parada cardiorrespiratoria (PCR) susceptible de recibir Soporte Vital Avanzado Enfermero (SVAE), conforme al protocolo establecido, en el ámbito extrahospitalario.



2.4 Materiales

- Monitor y parches desfibrilación
- Aspirador de secreciones y sondas de aspiración
- Bala de oxígeno portátil
- Respirador más tubuladuras
- Ampulario
- Mochila de Circulatorio
- Mochila de Respiratorio

La revisión se realizará al comenzar la guardia, tanto de las mochilas como del material de las ambulancias.

La responsabilidad de la revisión/reposición y adecuación del material es tanto de enfermería como de TES.

Las incidencias (material en mal estado, sin stock, pérdidas, etc.) se reflejarán en el documento de revisión y serán notificadas al Coordinador/a.

Durante la guardia se repondrá todo el material utilizado, en la cantidad estipulada en este documento.

No se puede cambiar la ubicación y/o número del material.

Es importante el seguimiento de estas normas para mejorar la calidad de nuestro trabajo.

Consultar anexo 1 para la ubicación del material.

2.5 Plan de Actuación

Se debe realizar una evaluación primaria para identificar y abordar problemas que comprometan la vida del paciente (consultar epígrafe 1: Procedimiento General de Actuación SVAE).

A continuación, se implementará el proceso de cuidados específico detallado en el siguiente algoritmo de actuación:



SVA EN PCR EN ADULTOS

Calidad de la RCP

- Comprimir fuerte (al menos 5 cm) y rápido (entre 100 y 120 c.p.m)
- Minimice las interrupciones entre compresiones
- Evitar una ventilación excesiva
- Cambiar de reanimador cada dos minutos o antes si está cansado.

1 Valoración inicial X-A-B-C-D-E

- 2
- Confirmación PCR
 - Comenzar compresiones torácicas 30:2
 - Balón resucitador con fuente de O₂
 - Monitorización con parches

Informar CCU y
solicitar apoyo
UME/SUAP si precisa

¿El ritmo es
desfibrilable?

Sí

No

3 FV/TV sin pulso

10 Asistolia/AESP

Descarga

Adrenalina lo
antes posible

5 2 min de RCP

-Obtener acceso IV/IO

11 2 min de RCP

- Obtener acceso IV/IO
- Administrar adrenalina cada 3 a 5 min
- Considerar la posibilidad de usar un dispositivo de manejo avanzado para vía aérea, sin IOT, y capnografía

¿El ritmo es
desfibrilable?

No

¿El ritmo es
desfibrilable?

Sí

Sí

Descarga

7 2 min de RCP

- Administrar adrenalina cada 3 a 5 min
- Considerar la posibilidad de usar un dispositivo de manejo avanzado para vía aérea y capnografía

¿El ritmo es
desfibrilable?

No

8

Sí

Descarga

9 2 min de RCP

- Administrar amiodarona
- Tratar causas reversibles

13

- Si no existen signos de retorno de la circulación espontánea (RCE) vaya al punto 11 ó 12
- Si existe RCE, realizar actividades posparo cardíaco
- Considerar si es apropiado continuar con la reanimación

¿El ritmo es
desfibrilable?

Sí

No

12 2 min de RCP

-Tratar causas reversibles

Vaya al punto 6 o 7

Energía de descarga para desfibrilación

- Bifásica: recomendación del fabricante (por ejemplo, dosis inicial de 120 a 200J) si se desconoce, usar el valor máximo posible. La segunda carga y posteriores deben ser equivalentes y puede considerarse la administración de valores superiores
- Monofásica: 360J

Farmacoterapia:

- Dosis IV/IO de adrenalina: 1 mg cada 3 a 5 min
- Dosis IV/IO de amiodarona: Primera dosis: bolo de 300mg. Segunda dosis 150 mg.



SVA EN PCR EN PEDIÁTRICA

Calidad de la RCP

- Comprimir fuerte ($\geq 1/3$ del diámetro anteroposterior del tórax) y rápido (entre 100 y 120/min)
- Minimice las interrupciones entre compresiones
- Evitar una ventilación excesiva
- Cambiar de reanimador cada dos minutos o antes si está cansado.
- Si hay vía aérea avanzada, realizar compresiones continuas y ventilación cada 2-3 segundos.

1
Valoración inicial
X-A-B-C-D-E

2
Confirmación PCR
Comenzar 5 ventilaciones de rescate
Iniciar compresiones torácicas 15:2
Balón resucitador con fuente de O_2
Monitorización con parches

Informar CCU y
solicitar apoyo
UME/SUAP si precisa

¿El ritmo es
desfibrilable?

Sí

No

3
FV/TV sin pulso

4



Descarga

5
2 min de RCP

-Obtener acceso IV/IO

¿El ritmo es
desfibrilable?

No

6



Descarga

7
2 min de RCP

-Administrar adrenalina cada 3 a 5 min
-Considerar la posibilidad de usar un dispositivo de manejo avanzado para vía aérea y capnografía

¿El ritmo es
desfibrilable?

No

8



Descarga

9
2 min de RCP

-Administrar amiodarona
-Tratar causas reversibles

Energía de descarga para desfibrilación

- Primera descarga: 2 Julios/kg
- Segunda descarga: 4 Julios/kg
- Descargas posteriores a ≥ 4 Julios/kg con un máximo de 10 Julios/kg o la dosis de adulto.

Farmacoterapia:

- Dosis IV/IO de **adrenalina**: 0.01 mg/kg (0.1 ml/kg en concentración de 0.1 mg/ml). Dosis máxima de un 1 mg.

Repita cada 3 a 5 min.

Si no hay acceso vía IV/IO, puede administrar una dosis endotraqueal 0.1 mg/kg (0.1 ml/kg en concentración de 0.1 mg/ml).

- Dosis IV/IO de **amiodarona**: bolo de 5 mg/kg durante la parada. Hasta tres dosis en FV refractaria o TV sin pulso

10
Asistolia/AESP



Adrenalina lo
antes posible

11
2 min de RCP

-Obtener acceso IV/IO
-Administrar adrenalina cada 3 a 5 min
-Considerar la posibilidad de usar un dispositivo de manejo avanzado para vía aérea, sin IOT, y capnografía

¿El ritmo es
desfibrilable?

Sí

No

12
2 min de RCP

-Tratar causas reversibles

¿El ritmo es
desfibrilable?

No

Sí

- 13
- Si no existen signos de retorno de la circulación espontánea (RCE) vaya al punto 11
 - Si existe RCE, realizar actividades posparo cardiaco

Vaya al punto 8

PROCEDIMIENTO

PARA EQUIPOS SVA



2.6 Historia de Cuidados de Enfermería (SVAE)

En la Historia de Cuidados de Enfermería Extrahospitalaria se deben registrar, como mínimo, los siguientes datos:

V. REGISTRO DE ENFERMERÍA			
Etiquetas diagnóstico NANDA	Resultados NOC	Intervenciones NIC	
☐ 00257 Sd. Fragilidad del anciano ☐ 0802 Signos Vitales ☐ 1912 Caídas ☐ 0208 Movilidad ☐ 2402 Función sensitiva ☐ 1913 Severidad de la lesión física ☐ 6680 Monitorización de los signos vitales ☐ 4420 Acuerdo con el paciente ☐ 5510 Educación para la salud ☐ 7170 Facilitar la presencia de la familia			
☐ 00103 Deterioro de la deglución ☐ 00179 Riesgo de nivel de glucemia inestable ☐ 00002 Desequilibrio nutricional: inferior a las necesidades corporales ☐ 00232 Obesidad ☐ 00233 Sobrepeso ☐ 00134 Náuseas ☐ 1010 Estado de deglución ☐ 2300 Nivel de glucemia ☐ 1404 Estado nutricional ☐ 1618 Control de náuseas y vómitos ☐ 1080 Sondaje nasogástrico. Calibre: _____ ☐ 4035 Muestra de sangre capilar ☐ 2120 Manejo de la hiperglucemia ☐ 2130 Manejo de la hipoglucemia ☐ 1100 Manejo de la nutrición ☐ 1570 Manejo del vómito			
☐ 00016 Deterioro de la eliminación urinaria ☐ 00023 Retención urinaria ☐ 00011 Estreñimiento. ☐ 00013 Diarrea. ☐ 0501 Eliminación intestinal. ☐ 0503 Eliminación urinaria. ☐ 0590 Manejo de la eliminación urinaria ☐ 0580 Sondaje Vesical ☐ 0620 Cuidados de la retención urinaria ☐ 1876 Cuidados del catéter urinario ☐ 0430 Control intestinal			
☐ 00030 Deterioro del intercambio de gases ☐ 00032 Patrón respiratorio ineficaz ☐ 00031 Limpieza ineficaz de vía aérea. ☐ 00039 Riesgo de aspiración. ☐ 0415 Estado respiratorio ☐ 3160 Aspiración de las vías aéreas ☐ 3320 Oxigenoterapia. FIO₂ _____ lts/min: _____ Tipo: _____ ☐ 3302 Manejo de la ventilación mecánica: no invasiva. Modo: _____ FIO₂ _____ PEEP: _____ Trigger: _____ Frec. Resp: _____			
☐ 00029 Disminución del gasto cardíaco ☐ 00267 Riesgo de tensión arterial inestable ☐ 0400 Efectividad de la bomba cardíaca ☐ 0401 Estado circulatorio ☐ 2301 Respuesta a la medicación ☐ 4250 Manejo del shock. ☐ 4040 Cuidados cardíacos. ☐ ECG ☐ Monitor ☐ Cardioversión ☐ Desfibrilador Julios: _____ Choques: _____ ☐ 4162 Manejo de la hipertensión ☐ 4175 Manejo de la hipotensión ☐ 4092 Manejo del marcapasos: temporal Frec: _____ mVolios: _____			
☐ 00051 Deterioro de la comunicación verbal ☐ 00128 Confusión aguda. ☐ 00129 Confusión crónica. ☐ 00146 Ansiedad. ☐ 0902 Comunicación ☐ 0909 Estado neurológico ☐ 1214 Nivel de agitación ☐ 1211 Nivel de ansiedad ☐ 2620 Monitorización neurológica. ☐ 5270 Apoyo emocional. ☐ 4929 Escucha activa			
☐ 00114 Síndrome de estrés del traslado ☐ 0210 Realización de transferencia ☐ 1311 Adaptación al traslado ☐ 8100 Derivación ☐ 7890 Transporte entre instalaciones ☐ 7710 Colaboración con el médico ☐ 7960 Intercambio de información de cuidados de salud			
☐ 00004 Riesgo de infección ☐ 00206 Riesgo de sangrado ☐ 00038 Riesgo de traumatismo físico ☐ 00312 Lesión por presión en el adulto ☐ 00044 Deterioro de la integridad tisular ☐ 00303 Riesgos de caídas en el adulto ☐ 1101 Integridad tisular: piel ☐ 4020 Disminución de la Hemorragia ☐ Torniquete. Hora: _____ ☐ Compresión ☐ 3660 Cuidados de la herida. ☐ 3620 Sutura ☐ 6610 Identificación de riesgos			
☐ 00132 Dolor agudo ☐ 00133 Dolor crónico ☐ 1605 Control del dolor ☐ 2300 Administración de Medicación. ☐ 1410 Manejo del dolor: agudo ☐ 1415 Manejo del dolor: crónico			
☐ 00020 Riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca ☐ 00033 Deterioro de la ventilación espontánea ☐ 0414 Estado cardiopulmonar ☐ 6200 Cuidados de la emergencia ☐ 6140 Manejo de la parada cardiopulmonaria ☐ 6320 Reanimación ☐ 4095 Manejo del desfibrilador ☐ 3140 Manejo de la vía aérea. Tipo: _____			

Se marcará lo que proceda.

2.7 Bibliografía

1. Algoritmos RCP AHA 2020. Versión 5- 03/06/2023.
https://www.urgenciasyemergen.com/sdm_downloads/algoritmos-rcp-aha-2020-adultos-y-pediatria/
2. Algoritmos RCP ERC 2021. Versión 3-03/06/2023.
https://www.urgenciasyemergen.com/sdm_downloads/algoritmos-erc-2021-adultos-y-pediatria/
3. Procedimiento General de Actuación SVAE. Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de la Región de Murcia. 2022.
4. European Resuscitation Council. Guías COVID 19. Traducción del Consejo de Resucitación Español Cardiopulmonar. 2021. <https://semicyuc.org/wp-content/uploads/2021/09/RCP-Guias-ERC-2021-01-Resumen-Traduccion-oficial-CERCP.pdf>
5. Aspectos destacados de 2023. American Heart Association. Focused Update on the Management of Patients With Cardiac Arrest or Life-Threatening Toxicity Due to Poisonin. 2023. https://cpr.heart.org/-/media/CPR-Files/CPR-Guidelines-Files/2023-Toxicology-Updates/Hghlghts_2023FUTox_Spanish_230915.pdf
6. Guía de Actuación Enfermera de Urgencias y Emergencias prehospitalarias. Emergencies mèdiques 061. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. 2015
7. Guía de Actuación Extrahospitalaria para Soporte Vital Avanzado Enfermero. Ediciones CECOVA. Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana. 2023



3. ATENCIÓN AL PACIENTE CON TRAUMA GRAVE

3.1 Definición

La atención al enfermo traumático grave es uno de los pilares fundamentales en la gestión de emergencias prehospitalarias, ya que involucra situaciones en las que el paciente presenta lesiones graves que amenazan su vida. El trauma grave se define como aquel que afecta a uno o más órganos vitales, como huesos mayores o vísceras, y que genera alteraciones en las funciones respiratorias y/o circulatorias, poniendo al paciente en una condición crítica. La rapidez y la calidad de la atención en estos primeros momentos son determinantes para la supervivencia del paciente, ya que el tiempo es un factor crucial.

El trauma puede considerarse una enfermedad en sí misma, ya que se conocen sus factores etiopatogénicos, basados en la cinemática o biomecánica de las lesiones, y las respuestas fisiopatológicas que el cuerpo experimenta ante estas agresiones. En el enfermo traumático, la sintomatología es variada y compleja, y requiere de un diagnóstico preciso, un tratamiento adecuado y una evaluación constante del pronóstico. Asimismo, la prevención de complicaciones y el manejo integral de las lesiones son fundamentales para garantizar una atención eficaz y mejorar las posibilidades de recuperación del paciente. Este enfoque integral en la atención prehospitalaria es esencial para optimizar los resultados en situaciones de trauma grave.

3.2 Objetivos

- Reconocer los signos de alarma que pueda presentar el paciente, tratar y/o estabilizar.
- Recoger datos clínicos y pruebas complementarias para una adecuada atención.
- Prestar cuidados necesarios en el episodio de enfermedad, evitando demoras y pasos intermedios que no aporten valor añadido.
- Garantizar la continuidad de la asistencia hasta la transferencia a otra unidad médica o hospitalaria.

3.3 Ámbito de Aplicación

Pacientes con traumatismos de diversa etiología que precisan atención en el contexto extrahospitalario.



3.4 Materiales

- Monitor y parches desfibrilación
- Aspirador de secreciones y sondas de aspiración
- Bala de oxígeno portátil
- Respirador más tubuladuras
- Material de inmovilización/movilización
- Ampulario
- Mochila de Circulatorio
- Mochila de Respiratorio

Consultar anexo 1 para la ubicación del material.

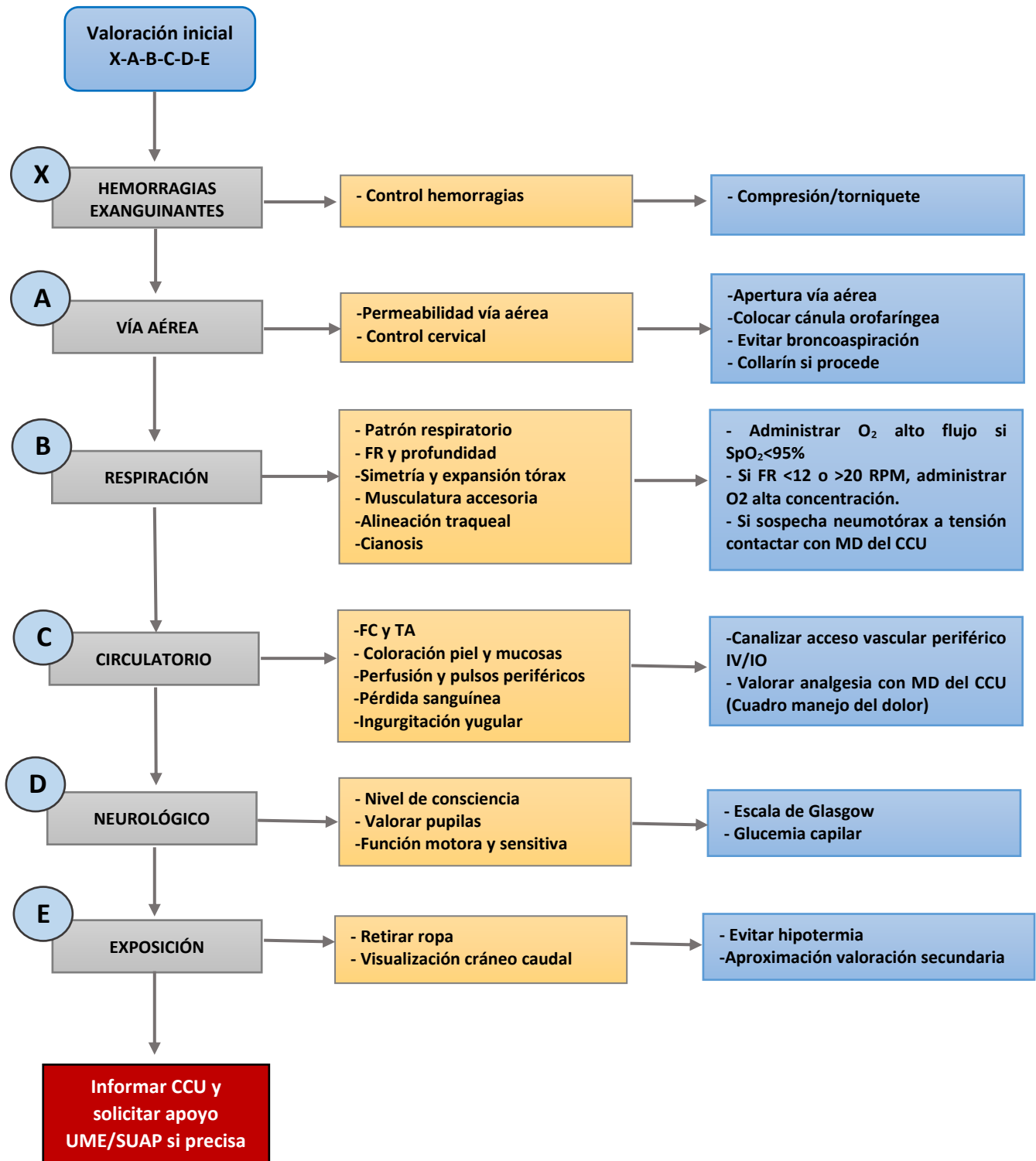
3.5 Plan de Actuación

Realizar una evaluación primaria orientada a identificar y tratar de manera inmediata cualquier problema que represente un riesgo vital (consultar epígrafe 1: Procedimiento General de Actuación SVAE).

Implementar el proceso de cuidados específico descrito a continuación:



VALORACIÓN PRIMARIA AL PACIENTE CON TRAUMA GRAVE



VALORACIÓN SECUNDARIA TRAUMA GRAVE

**EXPLORACIÓN CON INSPECCIÓN, PALPACIÓN, AUSCULTACIÓN, PERCUSIÓN COMPLETA.
REALIZAR EN ZONA SEGURA, LUMINOSA Y AISLADA DE FACTORES EXTERNOS
INFORMAR AL MD DEL CCU DE LOS HALLAZGOS**

CABEZA

Importante identificación y control de hemorragias exanguinantes.

- Explorar; cráneo, huesos cara y pupilas
- No SNG si sospecha lesión base cráneo, si precisa orogástrica.
- No taponar orificios naturales.
- No aplicar un vendaje compresivo a una fractura de cráneo abierta o deprimida, a menos que haya una hemorragia significativa, porque puede agravar la lesión cerebral y provocar aumento de PIC.
- Si lesiones extracción con collar cervical e inmovilizador lateral de la cabeza.
- Importante Glasgow motor y respuesta ocular in situ, predice mejor los daños cerebrales y supervivencia.
 - Glasgow de 8 o menos coma o lesión cerebral grave
 - Glasgow de 9 a 12 lesiones moderadas
 - Glasgow de 13 a 15 lesiones leves
- La dilatación pupilar indica una emergencia neurológica. La hernia uncal por edema cerebral o efecto masa, puede causar compresión del nervio oculomotor.
- Un collarín muy ajustado puede impedir el drenaje venoso de la cabeza, aumentado la PIC

CUELLO

- Pulsos, columna cervical, venas, tráquea línea media.
- Durante la exploración control cervical bimanual, incluida intubación.
- Inmovilización cervical, comprobar tamaño correcto collarín, flexión/extensión con collar y lateral con inmovilizador de cabeza o colchón de vacío.

TÓRAX

- Respiración: frecuencia, profundidad, simetría, enfisema subcutáneo, ruidos respiratorios o ausencia.
- Auscultación pulmonar y cardíaca lesiones, crepitaciones, objetos clavados.
 - Comprobar colocación IOT y fijación, revisar oxigenoterapia y parámetros ventiladores.
 - Fijación de objeto clavado su hubiese. Si precisa encintado torácico durante el rescate, que sea de tipo mochila (haciendo un 8 en la espalda)

ABDOMEN, PELVIS, GENITALES

- Dolor, defensa muscular, lesiones externas, enfisema subcutáneo.
- Lesiones externas: heridas penetrantes, objeto clavado, hematomas.
- Alineación y compresión cintura pélvica muy cautelosa buscando inestabilidad, alineación y enfajado pélvico (inmovilización) y colchón de vacío.
- Si evisceración no reintroducción, apósito húmedo con SF y encima apósito seco. Si objeto clavado, fijación.

EXTREMIDADES

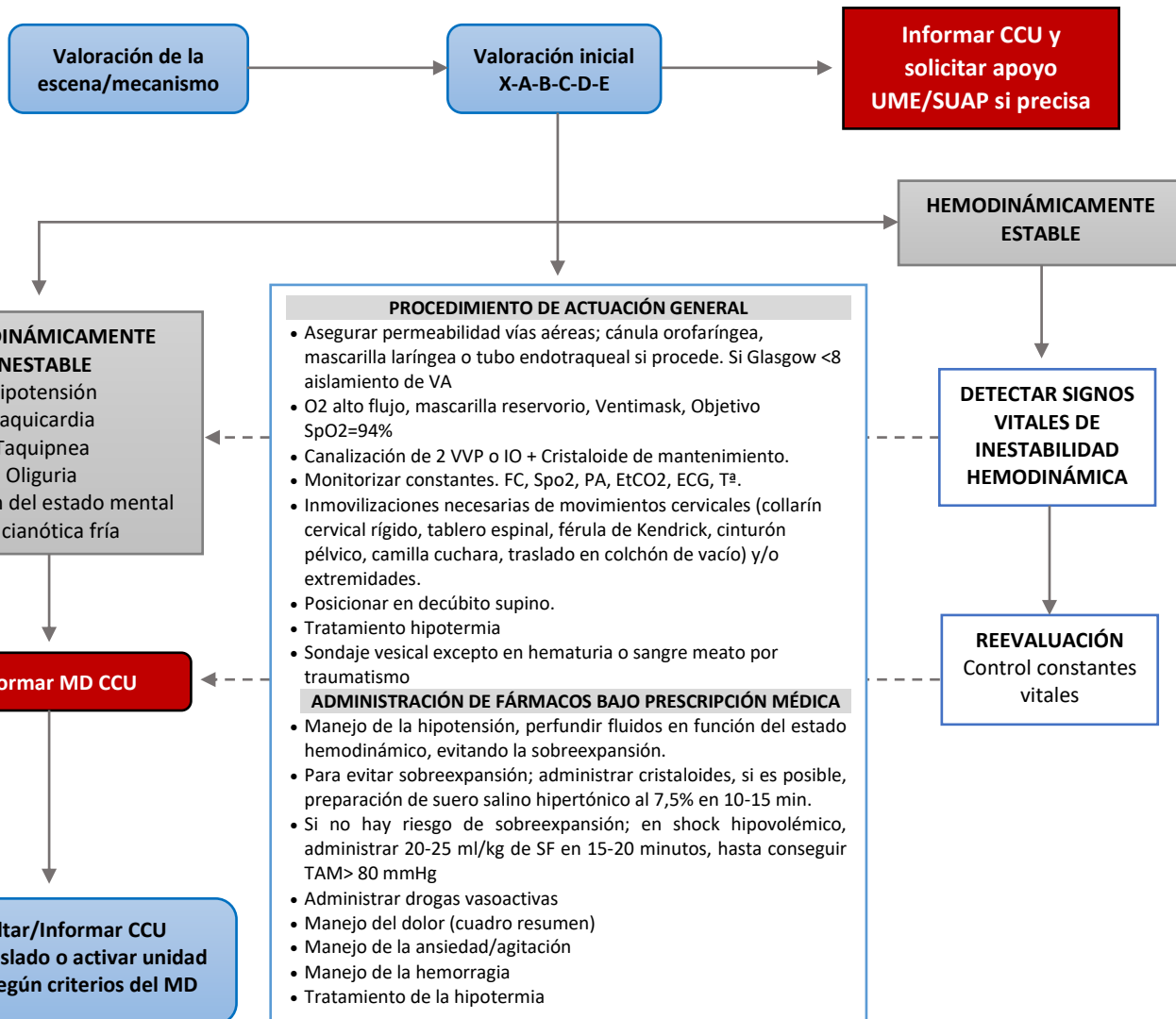
- Lesiones cutáneas y deformidades.
- Pulsos distales, coloración y movilidad comparativa con extremidad sana.
- Valoración antes de alinear y después de inmovilizar.
- lesiones de huesos largos: tracción, alineación e inmovilización.
- Zonas articulares inmovilización en su posición.
- Fracturas abiertas apósito de SF y encima apósito seco.
- Férulas incluyendo articulación distal y proximal.
- Vendales de distal a proximal evitando compresiones vasculares excesivas (protección si es necesario)

ESPALDA

- Realizar las mínimas movilizaciones posibles para poder valorar e inmovilizar.
- Puntos dolorosos, deformidades, hematomas, heridas.
- Movilizaciones en bloque, rescate y recogida con tabla espinal, recogida sobre suelo liso también con cuchara, preparación traslado sobre colchón de vacío.
- Si criterios de inmovilización, ésta debe ser completa de todo el raquis (collarín cervical + colchón + sujeciones)



ATENCIÓN AL PACIENTE CON TRAUMA GRAVE



CUADRO RESUMEN MANEJO DEL DOLOR

EVA >4 dolor leve o leve/moderado

- Medidas analgésicas y de confort
- Paracetamol
- Metamizol

EVA 4-6 dolor moderado grave

- Ketorolaco
- Tramadol

EVA >6 dolor muy intenso.

- Fentanilo
- Cloruro mórfico
- Meperidina

Valorar la administración de metoclopramida u ondansetrón, éste último, para niños <30Kg y personas de edad avanzada con riesgo de discinesia tardía.

Preparación del Suero Salino Hipertónico al 7.5%

- 65ml cloruro sódico al 0.9% + 35 ml de cloruro sódico al 20% = 100 ml cloruro sódico al 7,5 %

Preparación Noradrenalina (ampolla 10mg/10ml)

- Diluir 8 ml de la ampolla (8 mg) en 482 ml de SG5%. Vol. total= 500ml (1ml=16 µg)



3.6 Observaciones

En mujeres gestantes se seguirá el procedimiento estándar establecido para los pacientes adultos, adaptándolo según sea necesario.

Consultar anexo 2 Fichas de Guía Farmacológica 061.

3.7 Historia de Cuidados de Enfermería (SVAE)

En la Historia de Cuidados de Enfermería Extrahospitalaria se deben registrar, como mínimo, los siguientes datos:

V. REGISTRO DE ENFERMERÍA			
Etiquetas diagnóstico NANDA	Resultados NOC	Intervenciones NIC	
☐ 00257 Sd. Fragilidad del anciano ☐ 0802 Signos Vitales ☐ 1912 Caídas ☐ 0208 Movilidad ☐ 2402 Función sensitiva ☐ 1913 Severidad de la lesión física ☐ 00103 Deterioro de la deglución ☐ 00179 Riesgo de nivel de glucemia inestable ☐ 00002 Desequilibrio nutricional: inferior a las necesidades corporales ☐ 00232 Obesidad ☐ 00233 Sobrepeso ☐ 00134 Náuseas ☐ 00016 Deterioro de la eliminación urinaria ☐ 00023 Retención urinaria ☐ 00011 Estreñimiento. ☐ 00013 Diarrea. ☐ 00303 Deterioro del intercambio de gases ☐ 00032 Patrón respiratorio ineficaz ☐ 00031 Limpieza ineficaz de vía aérea. ☐ 00039 Riesgo de aspiración. ☐ 00029 Disminución del gasto cardíaco ☐ 00267 Riesgo de tensión arterial inestable ☐ 00051 Deterioro de la comunicación verbal ☐ 00128 Confusión aguda. ☐ 00129 Confusión crónica. ☐ 00146 Ansiedad. ☐ 00114 Síndrome de estrés del traslado ☐ 00004 Riesgo de infección ☐ 00206 Riesgo de sangrado ☐ 00038 Riesgo de traumatismo físico ☐ 00312 Lesión por presión en el adulto ☐ 00044 Deterioro de la integridad tisular ☐ 00303 Riesgos de caídas en el adulto ☐ 00132 Dolor agudo ☐ 00133 Dolor crónico ☐ 00020 Riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca ☐ 00033 Deterioro de la ventilación espontánea ☐ 0802 Signos Vitales ☐ 1912 Caídas ☐ 0208 Movilidad ☐ 2402 Función sensitiva ☐ 1913 Severidad de la lesión física ☐ 1010 Estado de deglución ☐ 2300 Nivel de glucemia ☐ 1404 Estado nutricional ☐ 1618 Control de náuseas y vómitos ☐ 0501 Eliminación intestinal. ☐ 0503 Eliminación urinaria. ☐ 0415 Estado respiratorio ☐ 0400 Efectividad de la bomba cardíaca. ☐ 0401 Estado circulatorio ☐ 2301 Respuesta a la medicación ☐ 0902 Comunicación ☐ 0909 Estado neurológico ☐ 1214 Nivel de agitación ☐ 1211 Nivel de ansiedad ☐ 0210 Realización de transferencia ☐ 1311 Adaptación al traslado ☐ 1101 Integridad tisular: piel ☐ 1605 Control del dolor ☐ 0414 Estado cardiopulmonar ☐ 6680 Monitorización de los signos vitales ☐ 4420 Acuerdo con el paciente ☐ 5510 Educación para la salud ☐ 7170 Facilitar la presencia de la familia ☐ 1080 Sondaje nasogástrico. Calibre: ____ ☐ 4035 Muestra de sangre capilar ☐ 2120 Manejo de la hiperglucemia ☐ 2130 Manejo de la hipoglucemia ☐ 1100 Manejo de la nutrición ☐ 1570 Manejo del vómito ☐ 0590 Manejo de la eliminación urinaria ☐ 0580 Sondaje Vesical ☐ 0620 Cuidados de la retención urinaria ☐ 1876 Cuidados del catéter urinario ☐ 0430 Control intestinal ☐ 3160 Aspiración de las vías aéreas ☐ 3320 Oxigenoterapia. FIO₂ ____ lts/min: ____ ☐ 3302 Manejo de la ventilación mecánica: no Invasiva. Modo: ____ FIO₂ ____ PEEP: ____ Tigger: ____ Frec. Resp: ____ ☐ 4250 Manejo del shock. ☐ 4040 Cuidados cardíacos. ☐ ECG ☐ Monitor ☐ Cardioversión ☐ Desfibrilador ☐ 4162 Manejo de la hipertensión ☐ 4175 Manejo de la hipotensión ☐ 4092 Manejo del marcapasos: temporal Frec: ____ mVoltios: ____ ☐ 2620 Monitorización neurológica. ☐ 5270 Apoyo emocional. ☐ 4929 Escucha activa ☐ 8100 Derivación ☐ 7890 Transporte entre instalaciones ☐ 7710 Colaboración con el médico ☐ 7960 Intercambio de información de cuidados de salud ☐ 4020 Disminución de la Hemorragia ☐ Torniquete. Hora: ____ ☐ Compresión ☐ 3660 Cuidados de la herida. ☐ 3620 Sutura ☐ 6610 Identificación de riesgos ☐ 2300 Administración de Medicación. ☐ 1410 Manejo del dolor: agudo ☐ 1415 Manejo del dolor: crónico ☐ 6200 Cuidados de la emergencia ☐ 6140 Manejo de la parada cardiopulmonaria ☐ 6320 Reanimación ☐ 4095 Manejo del desfibrilador ☐ 3140 Manejo de la vía aérea. Tipo: ____			

☐ 4235 Flebotomía: vía canalizada. Tipo: ____ Calibre: ____ Localización: ____
 ☐ 7820 Manejo de muestras. Tipo: ____
 ☐ 1380 Aplicación de calor o frío
 ☐ 3900 Regulación de la temperatura
 ☐ 6610 Identificación de riesgos
 ☐ 6364 Traje: centro de urgencias
 ☐ 7140 Apoyo a la familia
 ☐ 6650 Vigilancia
 ☐ 7680 Ayuda a la exploración
 ☐ 8020 Reunión multidisciplinar de cuidados
 ☐ 7910 Consulta
 ☐ 7726 Preceptor: estudiante

Valoración de Enfermería
 Percepción-Manejo de la Salud
 Adherencia al tratamiento: Si ☐ NO ☐
 Ingresos hospitalarios previos: Si ☐ NO ☐
 Hábitos tóxicos: Si ☐ NO ☐
 Nutrición-Metabólico
 Autónomo ☐ Dependiente ☐
 Dieta equilibrada ☐ Disfagia ☐ SNG ☐ PEG ☐
 Problemas digestivos: ____
 Eliminación
 Normal ☐ Incontinencia ☐ Diarrea ☐ Estreñimiento ☐
 Actividad-Ejercicio
 Activo ☐ Sedentario ☐
 Movilidad: Autónomo ☐ Necesita ayuda ☐ Dependiente ☐
 Sueño-Descanso
 Normal ☐ Alterado ☐ Ayudas para dormir ☐
 Cognitivo-Perceptivo
 Consciente: Si ☐ NO ☐ Orientado: Si ☐ NO ☐
 Autopercepción-Autoconcepto
 Conducta: No alterado ☐ Alterado ☐
 Rol-Relaciones
 Mayor Vulnerable ☐ Violencia doméstica ☐
 Ayuda domiciliaria ☐ Menor Vulnerable ☐ Sin Hogar ☐
 Conducta suicida ☐ Riesgo Social ☐ Síndrome Diógenes ☐
 Otros: ____
 Sexualidad y reproducción
 Adaptación tolerancia al estrés
 Valores y creencias



2.8 Bibliografía

1. Procedimiento General de Actuación SVAE. Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de la Región de Murcia. 2022.
2. Guía de Actuación Enfermera de Urgencias y Emergencias prehospitalarias. Emergències mèdiques 061. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.2015
3. Guía de Actuación Extrahospitalaria para Soporte Vital Avanzado Enfermero. Ediciones CECOVA. Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana.2023
4. PHTLS. Soporte Vital Prehospitalario para Traumatismos. Jones & Bartlett Learning. 10ª edición.2023.
5. Advance trauma life support. ATLS. Apoyo Vital Avanzado al Trauma. The Committee on Trauma.2018



4. ATENCIÓN AL PACIENTE CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO

4.1 Definición

El Síndrome Coronario Agudo (SCA) es una condición médica causada por la interrupción del flujo sanguíneo al corazón debido a la formación de un trombo intracoronario, que ocurre como resultado de la erosión o rotura de una placa arteriosclerótica en una arteria coronaria. Este trombo reduce el diámetro de la arteria, limitando la irrigación del músculo cardíaco y causando isquemia miocárdica.

Las manifestaciones clínicas del SCA varían según el grado de obstrucción y daño al miocardio, y pueden incluir:

- Angina estable (menor severidad, sin cambios agudos).
- Angina inestable (isquemia más grave, sin daño irreversible).
- Infarto de miocardio sin elevación del ST (daño miocárdico parcial).
- Infarto de miocardio con elevación del ST (daño miocárdico extenso).
- Muerte súbita cardíaca (complicación extrema).

La gravedad y los síntomas clínicos dependen directamente del grado de obstrucción y la extensión del tejido miocárdico afectado.

4.2 Objetivos

- Monitorización precoz y continua del paciente para favorecer el diagnóstico y tratamiento inmediato de las posibles complicaciones del suceso cardíaco.
- Que el diagnóstico y tratamiento se instaure en el menor tiempo posible.
- Reducir los tiempos de demora desde el primer contacto hasta la perfusión.

4.3 Ámbito de Aplicación

Pacientes con sospecha de padecer un síndrome coronario agudo en el contexto extrahospitalario.



4.4 Materiales

- Monitor y parches desfibrilación
- Ampulario
- Mochila de Circulatorio
- Mochila de Respiratorio
- Otro material que precise para la asistencia.

Consultar anexo 1 para la ubicación del material.

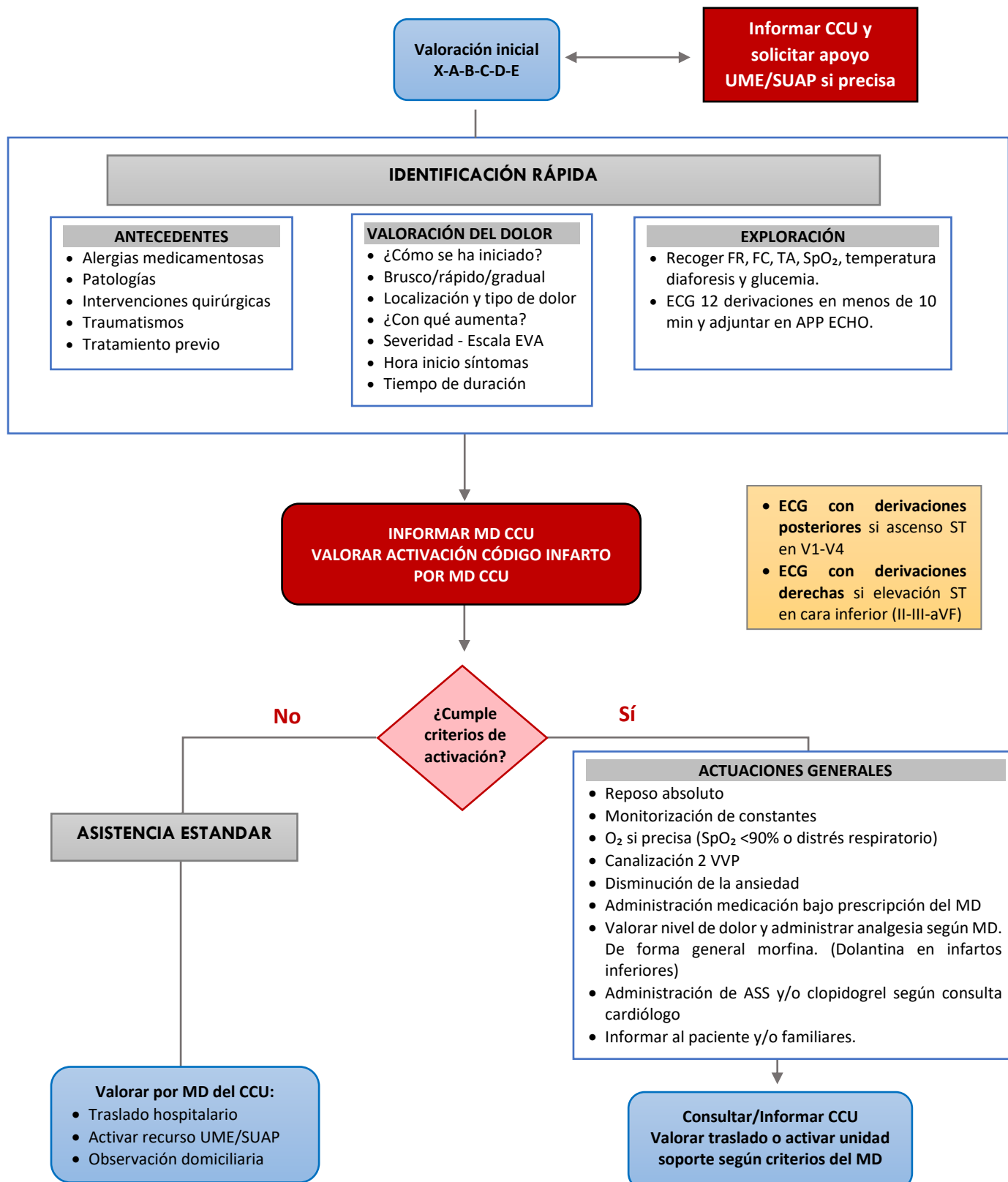
4.5 Plan de Actuación

Realizar una evaluación primaria orientada a identificar y tratar de manera inmediata cualquier problema que represente un riesgo vital (consultar epígrafe 1: Procedimiento General de Actuación SVAE)

Implementar el proceso de cuidados específico descrito a continuación:



ATENCIÓN AL PACIENTE CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO



4.6 Observaciones

¿Cuáles son los síntomas de sospecha diagnóstica del infarto agudo de miocardio (IAM o SCACEST)?

Se sospechará un IAM ante un malestar de 20 minutos o más de duración (dolor, opresión, desgarró, etc.) en la cara anterior del tórax, que puede irradiarse a ambos brazos –preferentemente al izquierdo- a la espalda, al epigastrio, al cuello o a la mandíbula, y puede estar acompañado de síntomas vegetativos – palidez, frialdad, diaforesis, náuseas, vómitos, sensación de muerte inminente- o de otros síntomas o signos, como disnea, palpitaciones, mareo o pérdida de conciencia. Hasta un 30% de pacientes con SCACEST se presenta con síntomas atípicos (náuseas, vómitos, disnea, astenia, palpitaciones, síncope, dolor epigástrico, etc.). Esta presentación es más frecuente en mujeres, ancianos y pacientes diabéticos.



4.7 Historia de Cuidados de Enfermería (SVAE)

En la Historia de Cuidados de Enfermería Extrahospitalaria se deben registrar, como mínimo, los siguientes datos:

V. REGISTRO DE ENFERMERÍA			
Etiquetas diagnóstico NANDA	Resultados NOC	Intervenciones NIC	
☐ 00257 Sd. Fragilidad del anciano	Paciente Frágil ☐ 0802 Signos Vitales ☐ 1912 Caídas ☐ 0208 Movilidad ☐ 2402 Función sensitiva ☐ 1913 Severidad de la lesión física	☐ 6680 Monitorización de los signos vitales ☐ 4420 Acuerdo con el paciente ☐ 5510 Educación para la salud ☐ 7170 Facilitar la presencia de la familia	NIC válidos para varios diagnósticos ☐ 4235 Flebotomía: vía canalizada. Tipo: _____ Calibre: _____ Localización: _____ ☐ 7820 Manejo de muestras. Tipo: _____ ☐ 1380 Aplicación de calor o frío ☐ 3900 Regulación de la temperatura ☐ 6610 Identificación de riesgos ☐ 6364 Triage: centro de urgencias ☐ 7140 Apoyo a la familia ☐ 6650 Vigilancia ☐ 7680 Ayuda a la exploración ☐ 8020 Reunión multidisciplinar de cuidados ☐ 7910 Consulta ☐ 7735 Preceptor: estudiante
☐ 00103 Deterioro de la deglución ☐ 00179 Riesgo de nivel de glucemia inestable ☐ 00002 Desequilibrio nutricional: inferior a las necesidades corporales ☐ 00232 Obesidad ☐ 00233 Sobrepeso ☐ 00134 Náuseas	Nutrición ☐ 1010 Estado de deglución ☐ 2300 Nivel de glucemia ☐ 1404 Estado nutricional ☐ 1618 Control de náuseas y vómitos	☐ 1080 Sondaje nasogástrico. Calibre: _____ ☐ 4035 Muestra de sangre capilar ☐ 2120 Manejo de la hiperglucemia ☐ 2130 Manejo de la hipoglucemia ☐ 1100 Manejo de la nutrición ☐ 1570 Manejo del vómito	Valoración de Enfermería Percepción-Manejo de la Salud Adherencia al tratamiento: Si ☐ NO ☐ Ingresos hospitalarios previos: Si ☐ NO ☐ Hábitos tóxicos: Si ☐ NO ☐ Nutrición-Metabólico Autónomo ☐ Dependiente ☐ Dieta equilibrada ☐ Disfagia ☐ SNG ☐ PEG ☐ Problemas digestivos: _____ Eliminación Normal ☐ Incontinencia ☐ Diarrea ☐ Estreñimiento ☐ Actividad-Ejercicio Activo ☐ Sedentario ☐ Movilidad: Autónomo ☐ Necesita ayuda ☐ Dependiente ☐ Sueño-Descanso Normal ☐ Alterado ☐ Ayudas para dormir ☐ Cognitivo-Perceptivo Consciente: Si ☐ NO ☐ Orientado: Si ☐ NO ☐ Auto percepción-Autoconcepto Conducta: No alterado ☐ Alterado ☐ Rol-Relaciones Mayor Vulnerable ☐ Violencia doméstica ☐ Ayuda domiciliaria ☐ Menor Vulnerable ☐ Sin Hogar ☐ Conducta suicida ☐ Riesgo Social ☐ Síndrome Diógenes ☐ Otros: _____ Sexualidad y reproducción Adaptación tolerancia al estrés Valores y creencias
☐ 00016 Deterioro de la eliminación urinaria ☐ 00023 Retención urinaria ☐ 00011 Estreñimiento. ☐ 00013 Diarrea.	Eliminación ☐ 0501 Eliminación intestinal. ☐ 0503 Eliminación urinaria.	☐ 0590 Manejo de la eliminación urinaria ☐ 0580 Sondaje Vesical Calibre: _____ Débito: _____ ☐ 0620 Cuidados de la retención urinaria ☐ 1876 Cuidados del catéter urinario ☐ 0430 Control intestinal	
☐ 00030 Deterioro del intercambio de gases ☐ 00032 Patrón respiratorio ineficaz ☐ 00031 Limpieza ineficaz de vía aérea. ☐ 00039 Riesgo de aspiración.	Respiratorio ☐ 0415 Estado respiratorio	☐ 3160 Aspiración de las vías aéreas ☐ 3320 Oxigenoterapia. FIO ₂ : _____ lts/min: _____ Tipo: _____ ☐ 3302 Manejo de la ventilación mecánica: no invasiva. Modo: _____ FIO ₂ : _____ PEEP: _____ Trigger: _____ Frec. Resp: _____	
☐ 00029 Disminución del gasto cardíaco ☐ 00267 Riesgo de tensión arterial inestable	Circulatorio ☐ 0400 Efectividad de la bomba cardíaca. ☐ 0401 Estado circulatorio ☐ 2301 Respuesta a la medicación	☐ 4250 Manejo del shock. ☐ 4040 Cuidados cardíacos. ☐ ECG ☐ Monito ☐ Cardioversión ☐ Desfibrilador Julios: _____ Choques: _____ ☐ 4162 Manejo de la hipertensión ☐ 4175 Manejo de la hipotensión ☐ 4092 Manejo del marcapasos: temporal Frec: _____ mVoltios: _____	
☐ 00051 Deterioro de la comunicación verbal ☐ 00128 Confusión aguda. ☐ 00129 Confusión crónica. ☐ 00146 Ansiedad.	Psicológico/Neurológico ☐ 0902 Comunicación ☐ 0909 Estado neurológico ☐ 1214 Nivel de agitación ☐ 1211 Nivel de ansiedad	☐ 2620 Monitorización neurológica. ☐ 5270 Apoyo emocional. ☐ 4929 Escucha activa	
☐ 00114 Síndrome de estrés del traslado	Traslado ☐ 0210 Realización de transferencia ☐ 1311 Adaptación al traslado	☐ 8100 Derivación ☐ 7890 Transporte entre instalaciones ☐ 7710 Colaboración con el médico ☐ 7960 Intercambio de información de cuidados de salud	
☐ 00004 Riesgo de infección ☐ 00206 Riesgo de sangrado ☐ 00038 Riesgo de traumatismo físico ☐ 00312 Lesión por presión en el adulto ☐ 00044 Deterioro de la integridad tisular ☐ 00303 Riesgos de caídas en el adulto	Musculoesquelético ☐ 1101 Integridad tisular: piel	☐ 4020 Disminución de la Hemorragia ☐ Torniquete. Hora: _____ ☐ Compresión ☐ 3660 Cuidados de la herida. ☐ 3620 Sutura ☐ 6610 Identificación de riesgos	
☐ 00132 Dolor agudo ☐ 00133 Dolor crónico	Dolor ☐ 1605 Control del dolor	☐ 2300 Administración de Medicación. ☐ 1410 Manejo del dolor: agudo ☐ 1415 Manejo del dolor: crónico	
☐ 00020 Riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca ☐ 00033 Deterioro de la ventilación espontánea	PCR ☐ 0414 Estado cardiopulmonar	☐ 6200 Cuidados de la emergencia ☐ 6140 Manejo de la parada cardiorrespiratoria ☐ 6320 Reanimación ☐ 4095 Manejo del desfibrilador ☐ 3140 Manejo de la vía aérea. Tipo: _____	

Se marcará lo que proceda.



4.8 Bibliografía

1. Procedimiento General de Actuación SVAE. Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de la Región de Murcia. 2022.
2. Guía de Actuación Enfermera de Urgencias y Emergencias prehospitalarias. Emergencies mèdiques 061. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. 2015
3. Guía de Actuación Extrahospitalaria para Soporte Vital Avanzado Enfermero. Ediciones CECOVA. Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana. 2023
4. Pardo, C, Muñoz, T, Chamorro, C. Monitorización del dolor. Recomendaciones del grupo de trabajo de analgesia y sedación de la SEMICYUC. 2006.
5. Guía farmacoterapéutica de medicamentos utilizados por los servicios de urgencias y emergencias sanitarias 061 de la Región de Murcia. Servicio Murciano de Salud. 2014.
6. Manual de protocolos asistenciales. Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias. PAUE. Servicio Andaluz de Salud. 2012
7. Manual y procedimientos de Enfermería SUMMA 112. Comunidad de Madrid. 2012
8. Casas Benavent, V, Iniesta Roser, R. Procesos asistenciales SVA Enfermería. Servicio de Emergencias Sanitarias. Generalitat Valenciana. 2021
9. Código Infarto. Estrategia Cardiovascular Región de Murcia. Servicio Murciano de Salud. Actualización 2023.



5. ATENCIÓN AL PACIENTE CON ICTUS

5.1 Definición

El ictus, también conocido como accidente cerebrovascular (ACV), es una condición médica que se produce cuando hay una interrupción del flujo sanguíneo al cerebro, lo que provoca daño cerebral. Existen dos tipos principales de ictus:

- Ictus isquémico: Ocurre cuando un vaso sanguíneo que suministra sangre al cerebro se bloquea, generalmente por un coágulo. Este tipo representa aproximadamente el 87% de los casos de ictus.
- Ictus hemorrágico: Se produce cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe, causando sangrado en el tejido cerebral. Esto puede ser resultado de condiciones como la hipertensión arterial o malformaciones vasculares.

Los síntomas del ictus pueden incluir debilidad o entumecimiento en un lado del cuerpo, dificultad para hablar o entender, pérdida súbita de visión, mareos, y dolor de cabeza severo. La asistencia sanitaria inmediata es crucial para minimizar el daño cerebral y mejorar las posibilidades de recuperación.

5.2 Objetivos

- Identificación rápida del ictus como la causa de los síntomas del paciente y descartar las condiciones que podrían simular un ictus.
- Activar Código Ictus, si está indicado
- Proporcionar los cuidados adecuados al paciente en la atención sanitaria y traslado urgente.

5.3 Ámbito de Aplicación

Pacientes que requieran atención sanitaria en un contexto extrahospitalario.



5.4 Materiales

- Monitor y parches desfibrilación
- Ampulario
- Mochila de Circulatorio
- Mochila de Respiratorio
- Otro material que precise para la asistencia.

Consultar anexo 1 para la ubicación del material.

5.5 Plan de Actuación

Realizar una evaluación primaria orientada a identificar y tratar de manera inmediata cualquier problema que represente un riesgo vital (consultar epígrafe 1: Procedimiento General de Actuación SVAE).

Implementar el proceso de cuidados específico descrito a continuación:



ATENCIÓN AL PACIENTE CON ICTUS

Valoración inicial
X-A-B-C-D-E

Informar CCU y
solicitar apoyo
UME/SUAP si precisa

IDENTIFICACIÓN RÁPIDA

ANTECEDENTES

- Alergias medicamentosas
- Patologías
- Antecedentes de ICTUS previos
- Tratamiento previo
- Situación basal/Escala Rankin (mRS)
- Hora de inicio de los síntomas

EXPLORACIÓN

- Recoger FR, FC, TA, saturación O₂, temperatura, estado piel y glucemia.
- Exploración neurológica: Escala NIHSS

CRITERIOS DE ACTIVACIÓN

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN*

Para la activación debe cumplir todos los criterios de inclusión y ninguno de exclusión

*Ver observaciones

Informar MD CCU

No

Sí

¿Cumple
criterios de
activación?

ASISTENCIA
ESTANDAR

ACTIVAR CÓDIGO ICTUS
Mediación a tres: SVAE,
CCU y neurólogo

INTERVENCIONES

ACTUACIONES PREHOSPITALARIAS*

Elevar cabecero
Extracción analítica.
Canalizar dos vías venosas.
Monitorización y electrocardiograma.

TRATAMIENTO PREHOSPITALARIO*

Aplicar tratamiento solo en caso de fiebre, hipo e hiperglucemia, SpO₂ <95, hipertensión y vómitos.

Valorar por MD del CCU:

- Traslado hospitalario
- Activar recurso UME/SUAP
- Observación domiciliaria

Valorar por MD del CCU:

- Traslado urgente hospital útil
- Activar recurso UME/SUAP



5.6 Observaciones

Escala de Rankin modificada (extraída del Protocolo Regional del ICTUS 2021)

	Grado mRS	Notas
0	Ningún síntoma en absoluto	Sin síntomas subjetivos y signos objetivos
1	Sin discapacidad significativa a pesar de los síntomas; capaz de realizar todas las tareas y actividades habituales	A pesar de los síntomas subjetivos o los signos objetivos, no ha habido cambios en la capacidad de la persona para trabajar y realizar las actividades de la vida diaria en comparación con antes del ictus.
2	Discapacidad leve; incapaz de realizar todas las actividades anteriores pero capaz de ocuparse de sus propios asuntos sin ayuda	A pesar de algunas limitaciones en la capacidad de la persona para llevar a cabo sus tareas y actividades habituales en comparación con antes del ictus, puede llevar una vida independiente.
3	Discapacidad moderada; necesita ayuda, pero puede caminar sin ayuda.	La asistencia es fundamental para utilizar el transporte público para desplazarse, pero no para caminar, comer, mantener la higiene diaria habitual, ir al baño, etc.
4	Discapacidad moderadamente grave; incapaz de caminar sin ayuda e incapaz de atender sus propias necesidades corporales sin ayuda	La asistencia es fundamental para caminar, comer, mantener la higiene diaria de rutina, ir al baño, etc., pero no se requiere un cuidado constante
5	Discapacidad grave; postrado en cama, incontinente y que requiere cuidados y atención de enfermería constantes	La asistencia es necesaria en todo momento
6	Muerte	



Escala NIHSS (extraída del Protocolo Regional del ICTUS 2021)

Clasificación	Puntuación NIHSS
<i>Ictus leve</i>	< 5
<i>Ictus moderado</i>	5-16
<i>Ictus grave</i>	17-25
<i>Ictus muy grave</i>	≥ 25

1 A. Nivel de conciencia 0 Alerta 1 Somnoliento 2 Estuporoso 3 Coma	6 A. Motor pierna izquierda 0 No claudica (BM5) 1 Claudica (BM4) 2 Algún esfuerzo contra gravedad (BM3) 3 Sin esfuerzo contra gravedad (BM1-2) 4 Ningún movimiento (BM 0)
1 B. Preguntas 0 Responde ambas correctamente 1 Responde una correctamente 2 Ambas incorrectas	6 B. Motor pierna derecha 0 No claudica (BM5) 1 Claudica (BM4) 2 Algún esfuerzo contra gravedad (BM3) 3 Sin esfuerzo contra gravedad (BM1-2) 4 Ningún movimiento (BM 0)
1 C. Órdenes 0 Realiza ambas correctamente 1 Realiza una correctamente 2 Ambas incorrectas	7. Ataxia de miembros 0 Ausente 1 Presente en una extremidad 2 Presente en dos extremidades
2. Mirada 0 Normal 1 Parálisis parcial de la mirada 2 Desviación oculocefálica	8. Sensibilidad 0 Normal 1 Hipostesia ligera a moderada 2 Hipostesia severa o anestesia
3. Campos visuales 0 Sin déficit campimétrico 1 Cuadrantanopsia 2 Hemianopsia homónima 3 Hemianopsia homónima bilateral, ceguera	9. Lenguaje 0 Normal, sin afasia 1 Afasia leve a moderada 2 Afasia grave, Wernicke, Broca 3 Afasia global o mutismo
4. Parálisis facial 0 Movimientos normales y simétricos 1 Paresia ligera 2 Parálisis parcial 3 Parálisis completa	10. Disartria 0 Articulación normal 1 Ligera a moderada 2 Severa o anartria



5 A. Motor brazo izquierdo	11. Extinción
0 No claudica (BM5)	0 Sin anormalidad
1 Claudica (BM4)	1 Parcial (solo una modalidad afectada)
2 Algún esfuerzo contra gravedad (BM3)	2 Completa (más de una modalidad)
3 Sin esfuerzo contra gravedad (BM1-2)	
4 Ningún movimiento (BM 0)	
5 B. Motor brazo derecho	Apartado adicional, no forma parte de la escala.
0 No claudica (BM5)	Función motora distal miembros superiores.
1 Claudica (BM4)	0: Normal. BM: 5
2 Algún esfuerzo contra gravedad (BM3)	1: Claudica, aunque vence la gravedad. BM: 3-4
3 Sin esfuerzo contra gravedad (BM1-2)	2: No vence la gravedad. BM: 0-2
4 Ningún movimiento (BM 0)	a. Mano izquierda b. Mano derecha

Criterios de inclusión:

- Presencia de alguno de los síntomas/signos de sospecha de ictus.
- Puntuación mayor o igual a 2 en la escala NIHSS.
- Déficit neurológico agudo, que persiste en el momento del diagnóstico y con un tiempo de evolución hasta 24 horas

Criterios de exclusión:

- Más de 24 horas de evolución desde el inicio de los síntomas.
- Paciente con discapacidad previa Puntuación mRS >2 y mala calidad de vida.
- Situación clínica previa de enfermedad grave e irreversible que condicione la esperanza de vida

Actuaciones Prehospitalarias:

- Estabilizar al paciente según ABC (vía aérea, respiración y circulación)
- Colocar la cabeza del paciente en un ángulo entre 15-45º en la camilla de traslado.
- Valorar y registrar los siguientes signos vitales: frecuencia cardiaca (FC), tensión arterial, saturación de oxígeno (SpO₂) y temperatura (T^a). Control cada 15 min si el tiempo de traslado es superior.
- Determinar la glucemia.
- Realizar monitorización cardiaca en todos los pacientes, y electrocardiograma siempre que no retrase el traslado.
- Canalizar vía periférica. Se recomiendan 2 vías siempre que no retrase el traslado inmediato.
- Extraer muestras de sangre para analítica, 3 tubos: hemograma, bioquímica y coagulación, siempre que no retrase el traslado.



- Notificación, 5 minutos antes, al hospital receptor, sobre la llegada inminente de un paciente Código Ictus.

Tratamiento Prehospitalario:

- Oxigenoterapia: administrar solo si $SpO_2 < 95\%$. En algunos casos puede ser necesaria la intubación para restablecer la ventilación adecuada y proteger la vía aérea.
- Glucemia:
 - Tratar de forma inmediata si $< 60\text{mg/dl}$.
 - Tratar con insulina parenteral si la glucemia es $> 200\text{mg/dl}$.
- Hipertensión: no debe tratarse a menos que presente cifras $> 220/120\text{mmHg}$.
- Temperatura: tratar con paracetamol IV si temperatura $> 38^\circ$.
- Si es necesaria, la administración de fluidos se realizará por vía venosa con suero salino isotónico sin dextrosa.
- En caso de náuseas o vómitos se podría administrar metoclopramida 10 mg IV.



5.7 Historia de Cuidados de Enfermería (SVAE)

En la Historia de Cuidados de Enfermería Extrahospitalaria se deben registrar, como mínimo, los siguientes datos:

V. REGISTRO DE ENFERMERÍA		
Etiquetas diagnóstico NANDA	Resultados NOC	Intervenciones NIC
Paciente Frágil		
☐ 00257 Sd. Fragilidad del anciano ☐ 00103 Deterioro de la deglución ☐ 00179 Riesgo de nivel de glucemia inestable ☐ 00002 Desequilibrio nutricional: inferior a las necesidades corporales ☐ 00232 Obesidad ☐ 00233 Sobre peso ☐ 00134 Náuseas	☐ 0802 Signos Vitales ☐ 1912 Cálidas ☐ 0208 Movilidad ☐ 2402 Función sensitiva ☐ 1913 Severidad de la lesión física ☐ 1010 Estado de deglución ☐ 2300 Nivel de glucemia ☐ 1404 Estado nutricional ☐ 1618 Control de náuseas y vómitos	☐ 6680 Monitorización de los signos vitales ☐ 4420 Acuerdo con el paciente ☐ 5510 Educación para la salud ☐ 7170 Facilitar la presencia de la familia ☐ 1080 Sondaje nasogástrico. Calibre: _____ ☐ 4035 Muestra de sangre capilar ☐ 2120 Manejo de la hiperglucemia ☐ 2130 Manejo de la hipoglucemia ☐ 1100 Manejo de la nutrición ☐ 1570 Manejo del vómito
Nutrición		
☐ 4235 Flebotomía: vía canalizada. Tipo: _____ Calibre: _____ Localización: _____ ☐ 7820 Manejo de muestras. Tipo: _____ ☐ 1380 Aplicación de calor o frío ☐ 3900 Regulación de la temperatura ☐ 6610 Identificación de riesgos ☐ 6364 Triaje: centro de urgencias ☐ 7140 Apoyo a la familia ☐ 6650 Vigilancia ☐ 7680 Ayuda a la exploración ☐ 8020 Reunión multidisciplinar de cuidados ☐ 7910 Consulta ☐ 7726 Preceptor: estudiante		
Eliminación		
☐ 00016 Deterioro de la eliminación urinaria ☐ 00023 Retención urinaria ☐ 00011 Estreñimiento ☐ 00013 Diarrea	☐ 0501 Eliminación intestinal ☐ 0503 Eliminación urinaria	☐ 0590 Manejo de la eliminación urinaria ☐ 0580 Sondaje Vesical Calibre: _____ Débito: _____ ☐ 0620 Cuidados de la retención urinaria ☐ 1876 Cuidados del catéter urinario ☐ 0430 Control intestinal
Respiratorio		
☐ 00030 Deterioro del intercambio de gases ☐ 00032 Patrón respiratorio ineficaz ☐ 00031 Limpieza ineficaz de vía aérea ☐ 00039 Riesgo de aspiración	☐ 0415 Estado respiratorio	☐ 3160 Aspiración de las vías aéreas ☐ 3320 Oxigenoterapia. FIO ₂ : _____ lts/min: _____ Tipo: _____ ☐ 3302 Manejo de la ventilación mecánica: no invasiva. Modo: _____ FIO ₂ : _____ PEEP: _____ Tigger: _____ Frec. Resp: _____
Circulatorio		
☐ 00029 Disminución del gasto cardíaco ☐ 00267 Riesgo de tensión arterial inestable	☐ 0400 Efectividad de la bomba cardíaca ☐ 0401 Estado circulatorio ☐ 2301 Respuesta a la medicación	☐ 4250 Manejo del shock ☐ 4040 Cuidados cardíacos. ECG ☐ Monitor ☐ Cardioversión ☐ Desfibrilador Julios: _____ Choques: _____ ☐ 4162 Manejo de la hipertensión ☐ 4175 Manejo de la hipotensión ☐ 4092 Manejo del marcapasos: temporal Frec: _____ mVotios: _____
Psicológico/Neurológico		
☐ 00051 Deterioro de la comunicación verbal ☐ 00128 Confusión aguda. ☐ 00129 Confusión crónica. ☐ 00146 Ansiedad.	☐ 0902 Comunicación ☐ 0909 Estado neurológico ☐ 1214 Nivel de agitación ☐ 1211 Nivel de ansiedad	☐ 2620 Monitorización neurológica. ☐ 5270 Apoyo emocional. ☐ 4929 Escucha activa
Traslado		
☐ 00114 Síndrome de estrés del traslado	☐ 0210 Realización de transferencia ☐ 1311 Adaptación al traslado	☐ 8100 Derivación ☐ 7890 Transporte entre instalaciones ☐ 7710 Colaboración con el médico ☐ 7960 Intercambio de información de cuidados de salud
Musculoesquelético		
☐ 00004 Riesgo de infección ☐ 00206 Riesgo de sangrado ☐ 00038 Riesgo de traumatismo físico ☐ 00312 Lesión por presión en el adulto ☐ 00044 Deterioro de la integridad tisular ☐ 00303 Riesgos de caídas en el adulto	☐ 1101 Integridad tisular: piel	☐ 4020 Disminución de la Hemorragia ☐ Torniquete. Hora: _____ ☐ Compresión ☐ 3660 Cuidados de la herida. ☐ 3620 Sutura ☐ 6610 Identificación de riesgos
Dolor		
☐ 00132 Dolor agudo ☐ 00133 Dolor crónico	☐ 1605 Control del dolor	☐ 2300 Administración de Medicación. ☐ 1410 Manejo del dolor: agudo ☐ 1415 Manejo del dolor: crónico
PCR		
☐ 00020 Riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca ☐ 00033 Deterioro de la ventilación espontánea	☐ 0414 Estado cardiopulmonar	☐ 6200 Cuidados de la emergencia ☐ 6140 Manejo de la parada cardiopulmonar ☐ 6320 Reanimación ☐ 4095 Manejo del desfibrilador ☐ 3140 Manejo de la vía aérea. Tipo: _____

Se marcará lo que proceda.

5.8 Bibliografía

1. Procedimiento General de Actuación SVAE. Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de la Región de Murcia. 2022.
2. Guía de Actuación Enfermera de Urgencias y Emergencias prehospitalarias. Emergencies mèdiques 061. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. 2015
3. Guía de Actuación Extrahospitalaria para Soporte Vital Avanzado Enfermero. Ediciones CECOVA. Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana. 2023
4. Pardo, C, Muñoz, T, Chamorro, C. Monitorización del dolor. Recomendaciones del grupo de trabajo de analgesia y sedación de la SEMICYUC. 2006.
5. Guía farmacoterapéutica de medicamentos utilizados por los servicios de urgencias y emergencias sanitarias 061 de la Región de Murcia. Servicio Murciano de Salud. 2014.
6. Manual de protocolos asistenciales. Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias. PAUE. Servicio Andaluz de Salud. 2012
7. Manual y procedimientos de Enfermería SUMMA 112. Comunidad de Madrid. 2012.
8. Casas Benavent, V, Iniesta Roser, R. Procesos asistenciales SVA Enfermería. Servicio de Emergencias Sanitarias. Generalitat Valenciana. 2021
9. Plan Andaluz de ICTUS. <https://ictus-andalucia.com/wp-content/uploads/2021/06/Unidad-8.-Activacion-del-Codigo-Ictus.pdf>
10. ICTUS Isquémico Agudo. Recomendaciones para su atención. 2021. Servicio Murciano de Salud.
11. Caballero García, MA. Moriche Álvarez, F. Atención Integral del ICTUS en Atención Primaria. Servicio Andaluz de Salud. 2017.



6. ATENCIÓN AL PACIENTE CON DOLOR AGUDO

6.1 Definición

El dolor agudo es una respuesta fisiológica inmediata del cuerpo ante una lesión o daño tisular, cuyo objetivo principal es alertar al organismo sobre un problema o peligro potencial. Este tipo de dolor es de inicio rápido, generalmente intenso y de corta duración. Se localiza de manera específica en el área afectada y es causada por la estimulación de los receptores nociceptivos (sensores de dolor) en la piel, músculos, huesos o vísceras. Se caracteriza por una sensación clara de incomodidad, como ardor, punzadas o presión, dependiendo de la zona afectada. El dolor agudo tiene una función protectora, promoviendo el reposo y evitando que la persona agrave la lesión. Sin embargo, si persiste, puede volverse crónico y afectar la calidad de vida, por lo que se requiere un manejo adecuado para aliviarlo y tratarlo.

6.2 Objetivos

- Garantizar todas las medidas necesarias para aliviar el dolor del paciente, brindándole el mayor confort posible y promoviendo su bienestar físico y emocional.
- Proporcionar un tratamiento analgésico personalizado, adaptado a las necesidades de cada paciente, según la valoración de la escalada del dolor, considerando el dolor como una constante que debe ser monitorizada y gestionada continuamente.
- Asegurar un traslado cómodo y seguro del paciente, en caso de ser necesario, minimizando cualquier factor que pueda aumentar su malestar o sufrimiento durante el proceso.

6.3 Ámbito de Aplicación

Pacientes que requieran atención sanitaria en un contexto extrahospitalario.



6.4 Materiales

- Monitor y parches desfibrilación
- Ampulario
- Mochila de Circulatorio
- Mochila de Respiratorio
- Otro material que precise para la asistencia.

Consultar anexo 1 para la ubicación del material.

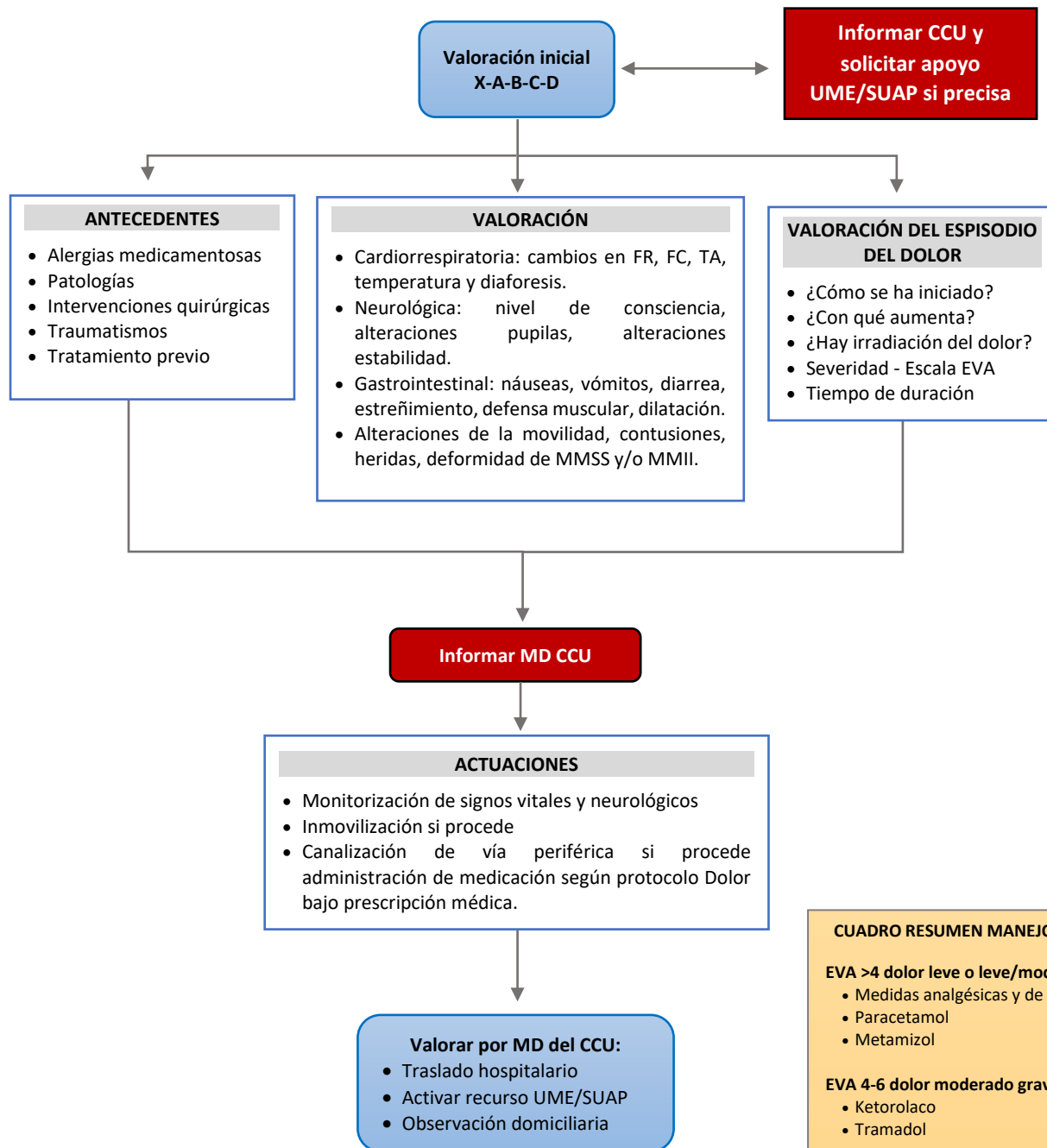
6.5 Plan de Actuación

Realizar una evaluación primaria orientada a identificar y tratar de manera inmediata cualquier problema que represente un riesgo vital (consultar epígrafe 1: Procedimiento General de Actuación SVAE).

Implementar el proceso de cuidados específico descrito a continuación:



ATENCIÓN AL PACIENTE CON DOLOR AGUDO



CUADRO RESUMEN MANEJO DEL DOLOR

EVA >4 dolor leve o leve/moderado

- Medidas analgésicas y de confort
- Paracetamol
- Metamizol

EVA 4-6 dolor moderado grave

- Ketorolaco
- Tramadol

EVA >6 dolor muy intenso.

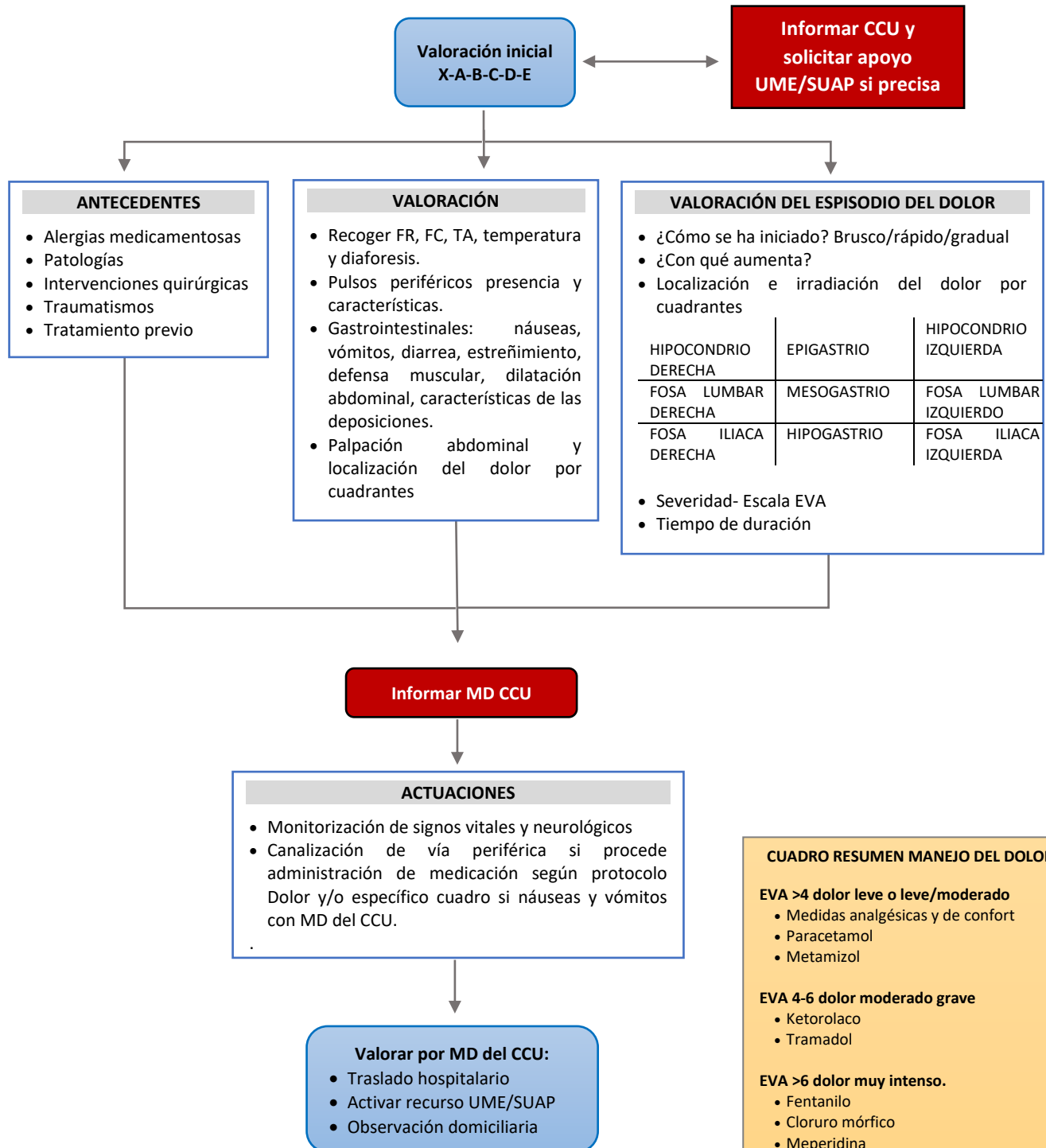
- Fentanilo
- Cloruro mórfico
- Meperidina

Valorar la administración de metoclopramida u ondansetrón, éste último, para niños <30Kg y personas de edad avanzada con riesgo de discinesia tardía.

*Ver fichas completas en Anexo 2



ATENCIÓN AL PACIENTE CON DOLOR ABDOMINAL



CUADRO RESUMEN MANEJO DEL DOLOR

EVA >4 dolor leve o leve/moderado

- Medidas analgésicas y de confort
- Paracetamol
- Metamizol

EVA 4-6 dolor moderado grave

- Ketorolaco
- Tramadol

EVA >6 dolor muy intenso.

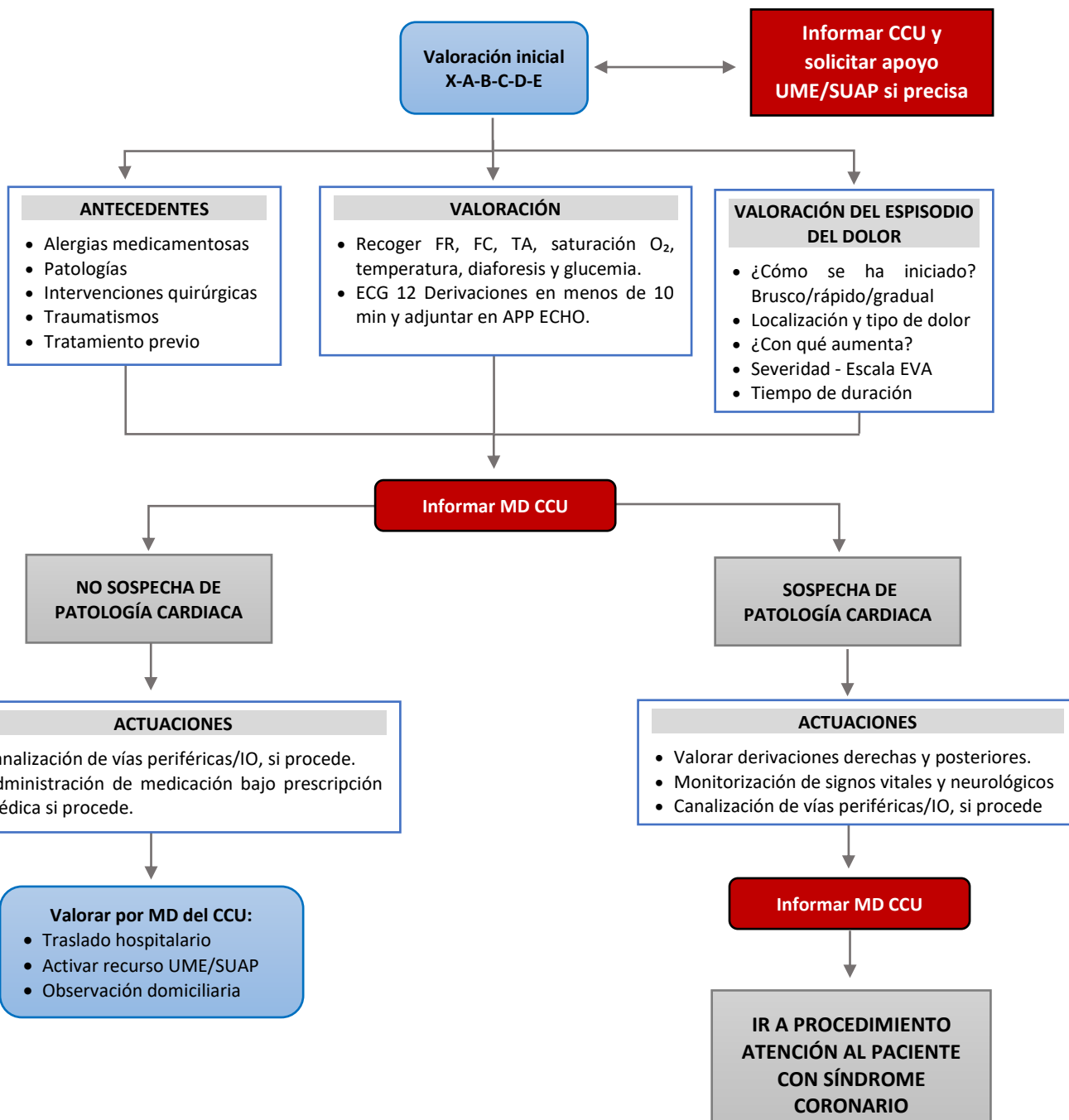
- Fentanilo
- Cloruro mórfico
- Meperidina

Valorar la administración de metoclopramida u ondansetrón, éste último, para niños <30Kg y personas de edad avanzada con riesgo de discinesia tardía.

*Ver fichas completas en Anexo 2



ATENCIÓN AL PACIENTE CON DOLOR TORÁCICO



6.6 Observaciones

Escala Dolor Eva en exploración física/procedimientos.

HISTORIA CUIDADOS ENFERMERÍA

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASISTENCIA

UNIDAD	AÑO	MES	DÍA	NÚMERO ASUNTO	PA	CARGO A TENDIDOS	CÓDIGO CONDUCTOR	CÓDIGO TÉCNICO/CEADOR
HORA LLAMADA	HORA IN SITU	HORA HOSPITAL	HORA LIBRE	Motivo de Consulta	NSS/DNI	Sexo	Edad	Zona Básica de Salud
Nombre y Apellido					Lugar de la Asistencia			

II. ALERGIAS, ANTECEDENTES Y ANAMNESIS

PACIENTE COLABORADOR: ☐ SI ☐ NO

ALERGIAS: ☐ SI ☐ NO ☐ DESCONOCIDAS

ANTECEDENTES DE INTERÉS: HTA ☐ DM ☐ HLP ☐ C. ISQ ☐ EPOC ☐ REN ☐ ACO ☐ ANTICOAGULANTE/ANTIAGREGANTE: _____ ☐ PLURIPATOLÓGICO

POLIMEDICACIÓN ☐ INGRESOS HOSPITALARIOS (ÚLTIMO AÑO (3 O MÁS)) ☐ TÓXICOS TIPO: _____ CANTIDAD: _____ ☐ FUMADOR CIGARROS DÍA Nº: _____

ANTECEDENTES R/C CALIDAD DE VIDA PROCEDE: ☐ SI ☐ NO EJERCICIO FÍSICO: ☐ SI ☐ NO AL MENOS UNA VEZ AL: ☐ MES ☐ SEMANA ☐ CASI TODOS LOS DÍAS

ABVD: ☐ DEPENDIENTE ☐ TOTALMENTE DEPENDIENTE ☐ INDEPENDIENTE

ANAMNESIS:

III. EXPLORACIÓN FÍSICA/PROCEDIMIENTOS

X HEMORRAGIA EXANGUINANTE ☐ SI ☐ NO

A VÍA AEREA PERMEABLE ☐ SI ☐ NO

B VENTILACIÓN ESPONTÁNEA ☐ SI ☐ NO

C CIRCULACIÓN

Piel: ☐ Normal ☐ Cianosis periférica ☐ Pálida ☐ Seca ☐ Fria ☐ Sudorosa ☐ Otros: _____

PULSOS: Radial, Femoral, Carotídeo. R. CAPILAR: <2 sg, >2 sg

D NEUROLÓGICO

☐ Consciente ☐ Obnubilado ☐ Estuporoso ☐ Coma - Inconciencia ☐ Focalidad neurológica ☐ Amnesia episodio ☐ Inconciencia previa: _____ min

GLASGOW:

OCULAR: ☐ Espontánea (4) ☐ Al sonido (3) ☐ A la presión (2) ☐ Ninguna (1)

VERBAL: ☐ Orientado (5) ☐ Confuso (4) ☐ Inapropiada (3) ☐ Sonidos (2) ☐ Ninguna (1)

MOTORA: ☐ Obedece órdenes (6) ☐ Localiza (5) ☐ Flexión (3) ☐ Extensión (2) ☐ Ninguna (1)

ESCALA DOLOR (EVA)

0 Sin dolor 1 Poco dolor 2 Dolor moderado 3 Dolor fuerte 4 Dolor muy fuerte 5 Dolor extremo

IV. EVOLUCIÓN, CONSTANTES VITALES Y ABORDAJE TERAPEUTICO

HORA	Frec. Respiratoria	SatO ₂ /ETCO ₂	Pulso (F.C)	Tensión Arterial	Glucemia	Temperatura

MEDICACIÓN Y FLUIDOTERAPIA ADMINISTRADA

Médico prescriptor: ☐ CCU ☐ Asistencial

Hora	Via	Dosis	Medicamento/Fluidoterapia

NMOVILIZACIÓN ☐ Mov. Rápida emergencia ☐ Inmov. de cabeza ☐ Retirada casco por EE ☐ Corsé espinal ☐ Collarín cervical ☐ Dama Elche ☐ Tablero espinal ☐ Camilla Tijera ☐ Colchón vacío ☐ Férula de miembros ☐ Otros: _____

ESCALA DOLOR (EVA)



Consultar anexo 2. Fichas de Guía Farmacológica del 061.



6.7 Historia de Cuidados de Enfermería (SVAE)

En la Historia de Cuidados de Enfermería Extrahospitalaria se deben registrar, como mínimo, los siguientes datos:

V. REGISTRO DE ENFERMERÍA			
Etiquetas diagnóstico NANDA	Resultados NOC	Intervenciones NIC	
☐ 00257 Sd. Fragilidad del anciano ☐ 0802 Signos Vitales ☐ 1912 Caldas ☐ 0208 Movilidad ☐ 2402 Función sensitiva ☐ 1913 Severidad de la lesión física ☐ 00103 Deterioro de la deglución ☐ 00179 Riesgo de nivel de glucemia inestable ☐ 00002 Desequilibrio nutricional: inferior a las necesidades corporales ☐ 00232 Obesidad ☐ 00233 Sobrepeso ☐ 00134 Náuseas ☐ 00016 Deterioro de la eliminación urinaria ☐ 00023 Retención urinaria ☐ 00011 Estreñimiento. ☐ 00013 Diarrea. ☐ 00030 Deterioro del intercambio de gases ☐ 00032 Patrón respiratorio ineficaz ☐ 00031 Limpieza ineficaz de vía aérea. ☐ 00039 Riesgo de aspiración. ☐ 00029 Disminución del gasto cardíaco ☐ 00267 Riesgo de tensión arterial inestable ☐ 00051 Deterioro de la comunicación verbal ☐ 00128 Confusión aguda. ☐ 00129 Confusión crónica. ☐ 00146 Ansiedad. ☐ 00114 Síndrome de estrés del traslado ☐ 00004 Riesgo de infección ☐ 00206 Riesgo de sangrado ☐ 00038 Riesgo de traumatismo físico ☐ 00312 Lesión por presión en el adulto ☐ 00044 Deterioro de la integridad tisular ☐ 00303 Riesgos de caídas en el adulto. ☐ 00132 Dolor agudo ☐ 00133 Dolor crónico ☐ 00020 Riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca ☐ 00033 Deterioro de la ventilación espontánea ☐ 0802 Signos Vitales ☐ 1912 Caldas ☐ 0208 Movilidad ☐ 2402 Función sensitiva ☐ 1913 Severidad de la lesión física ☐ 1010 Estado de deglución ☐ 2300 Nivel de glucemia ☐ 1404 Estado nutricional ☐ 1618 Control de náuseas y vómitos ☐ 0501 Eliminación intestinal. ☐ 0503 Eliminación urinaria. ☐ 0415 Estado respiratorio ☐ 0400 Efectividad de la bomba cardíaca. ☐ 0401 Estado circulatorio ☐ 2301 Respuesta a la medicación ☐ 0902 Comunicación ☐ 0909 Estado neurológico ☐ 1214 Nivel de agitación ☐ 1211 Nivel de ansiedad ☐ 0210 Realización de transferencia ☐ 1311 Adaptación al traslado ☐ 1101 Integridad tisular: piel ☐ 1605 Control del dolor ☐ 0414 Estado cardiopulmonar ☐ 6680 Monitorización de los signos vitales ☐ 4420 Acuerdo con el paciente ☐ 5510 Educación para la salud ☐ 7170 Facilitar la presencia de la familia ☐ 1080 Sondaje nasogástrico. Calibre: _____ ☐ 4035 Muestra de sangre capilar ☐ 2120 Manejo de la hiperglucemia ☐ 2130 Manejo de la hipoglucemia ☐ 1100 Manejo de la nutrición ☐ 1570 Manejo del vómito ☐ 0590 Manejo de la eliminación urinaria ☐ 0580 Sondaje Vesical Calibre: _____ Débito: _____ ☐ 0620 Cuidados de la retención urinaria ☐ 1876 Cuidados del catéter urinario ☐ 0430 Control intestinal ☐ 3160 Aspiración de las vías aéreas ☐ 3320 Oxigenoterapia. FIO₂: _____ lts/min: _____ Tipo: _____ ☐ 3302 Manejo de la ventilación mecánica: no invasiva. Modo: _____ FIO₂: _____ PEEP: _____ Tigger: _____ Frec. Resp: _____ ☐ 4250 Manejo del shock. ☐ 4040 Cuidados cardíacos. ☐ ECG ☐ Monitor ☐ Cardioversión ☐ Desfibrilador Julios: _____ Choques: _____ ☐ 4162 Manejo de la hipertensión ☐ 4175 Manejo de la hipotensión ☐ 4092 Manejo del marcapasos: temporal Frec: _____ mVoltios: _____ ☐ 2620 Monitorización neurológica. ☐ 5270 Apoyo emocional. ☐ 4929 Escucha activa ☐ 8100 Derivación ☐ 7890 Transporte entre instalaciones ☐ 7710 Colaboración con el médico ☐ 7960 Intercambio de información de cuidados de salud ☐ 4020 Disminución de la Hemorragia ☐ Torniquete. Hora: _____ ☐ Compresión ☐ 3660 Cuidados de la herida. ☐ 3620 Sutura ☐ 6610 Identificación de riesgos ☐ 2300 Administración de Medicación. ☐ 1410 Manejo del dolor: agudo ☐ 1415 Manejo del dolor: crónico ☐ 6200 Cuidados de la emergencia ☐ 6140 Manejo de la parada cardiopulmonar ☐ 6320 Reanimación ☐ 4095 Manejo del desfibrilador ☐ 3140 Manejo de la vía aérea. Tipo: _____			

☐ 4235 Flebotomía: vía canalizada. Tipo: _____
 Calibre: _____ Localización: _____
☐ 7820 Manejo de muestras. Tipo: _____
☐ 1380 Aplicación de calor o frío
☐ 3900 Regulación de la temperatura
☐ 6610 Identificación de riesgos
☐ 6364 Triaje: centro de urgencias
☐ 7140 Apoyo a la familia
☐ 6650 Vigilancia
☐ 7680 Ayuda a la exploración
☐ 8020 Reunión multidisciplinar de cuidados
☐ 7910 Consulta
☐ 7726 Preceptor: estudiante

Valoración de Enfermería
 Percepción-Manejo de la Salud
 Adherencia al tratamiento: Si ☐ NO ☐
 Ingresos hospitalarios previos: Si ☐ NO ☐
 Hábitos tóxicos: Si ☐ NO ☐
 Nutrición-Metabólico
 Autónomo ☐ Dependiente ☐
 Dieta equilibrada ☐ Disfagia ☐ SNG ☐ PEG ☐
 Problemas digestivos: _____
 Eliminación
 Normal ☐ Incontinencia ☐ Diarrea ☐ Estreñimiento ☐
 Actividad-Ejercicio
 Activo ☐ Sedentario ☐
 Movilidad: Autónomo ☐ Necesita ayuda ☐ Dependiente ☐
 Sueño-Descanso
 Normal ☐ Alterado ☐ Ayudas para dormir ☐
 Cognitivo-Perceptivo
 Consciente: Si ☐ NO ☐ Orientado: Si ☐ NO ☐
 Auto percepción-Autoconcepto
 Conducta: No alterado ☐ Alterado ☐
 Rol-Relaciones
 Mayor Vulnerable ☐ Violencia doméstica ☐
 Ayuda domiciliaria ☐ Menor Vulnerable ☐ Sin Hogar ☐
 Conducta suicida ☐ Riesgo Social ☐ Síndrome Diógenes ☐
 Otros: _____
 Sexualidad y reproducción
 Adaptación tolerancia al estrés
 Valores y creencias

Se marcará lo que proceda.

6.8 Bibliografía

1. Procedimiento General de Actuación SVAE. Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de la Región de Murcia. 2022.
2. Guía de Actuación Enfermera de Urgencias y Emergencias prehospitalarias. Emergències mèdiques 061. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. 2015.
3. Guía de Actuación Extrahospitalaria para Soporte Vital Avanzado Enfermero. Ediciones CECOVA. Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana. 2023
4. Pardo, C, Muñoz, T, Chamorro, C. Monitorización del dolor. Recomendaciones del grupo de trabajo de analgesia y sedación de la SEMICYUC. 2006.
5. Guía farmacoterapéutica de medicamentos utilizados por los servicios de urgencias y emergencias sanitarias 061 de la Región de Murcia. Servicio Murciano de Salud. 2014.
6. Manual de protocolos asistenciales. Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias. PAUE. Servicio Andaluz de Salud. 2012
7. Manual y procedimientos de Enfermería SUMMA 112. Comunidad de Madrid. 2012.
8. Casas Benavent, V, Iniesta Roser, R. Procesos asistenciales SVA Enfermería. Servicio de Emergencias Sanitarias. Generalitat Valenciana. 2021



7. ATENCIÓN AL PACIENTE CON CUADRO SINCOPAL

7.1 Definición

El síncope se define como una pérdida transitoria de la consciencia, acompañada de una pérdida temporal del tono muscular. Este evento clínico se caracteriza por un inicio súbito, una duración breve (generalmente de segundos a minutos) y una recuperación espontánea, rápida y completa, sin requerir intervención terapéutica inmediata.

Desde el punto de vista etiológico, el síncope se clasifica en las siguientes categorías principales:

- **Neuromediado:** Incluye causas como el síncope vasovagal, situacional, enfermedad del seno carotídeo y formas atípicas.
- **Ortostático:** Asociado a factores como el uso de ciertos fármacos o la depleción de volumen.
- **Cardiovascular:** Relacionado con disritmias, cardiopatías estructurales y otras alteraciones del sistema cardiovascular.
- **Otras causas:** Como el shock obstructivo, hemorrágico, hipoglucemia, entre otros factores menos comunes.

7.2 Objetivos

- **Confirmar el diagnóstico de síncope:** Establecer si la pérdida de consciencia presentada por el paciente corresponde a un episodio sincopal.
- **Evaluar otras causas de pérdida de consciencia:** Determinar si la pérdida de consciencia ha sido completa y explorar posibles etiologías alternativas no relacionadas con el síncope.
- **Identificar la causa subyacente del síncope:** Diferenciar si el origen es neurológico, cardiovascular o está vinculado a alteraciones como desequilibrios en la tensión arterial o niveles de glucosa.
- **Proporcionar el tratamiento adecuado:** Aplicar medidas terapéuticas específicas según la causa identificada del síncope, garantizando una atención oportuna y efectiva.
- **Registrar información relevante del episodio:** Documentar de forma exhaustiva los datos clínicos y circunstanciales que puedan aportar información valiosa para el diagnóstico y manejo del caso.



7.3 Ámbito de Aplicación

Pacientes adultos y pediátricos que requieran atención sanitaria en un contexto extrahospitalario.

7.4 Materiales

- Monitor y parches desfibrilación
- Ampulario
- Mochila de Circulatorio
- Mochila de Respiratorio
- Otro material que precise para la asistencia.

Consultar anexo 1 para la ubicación del material.

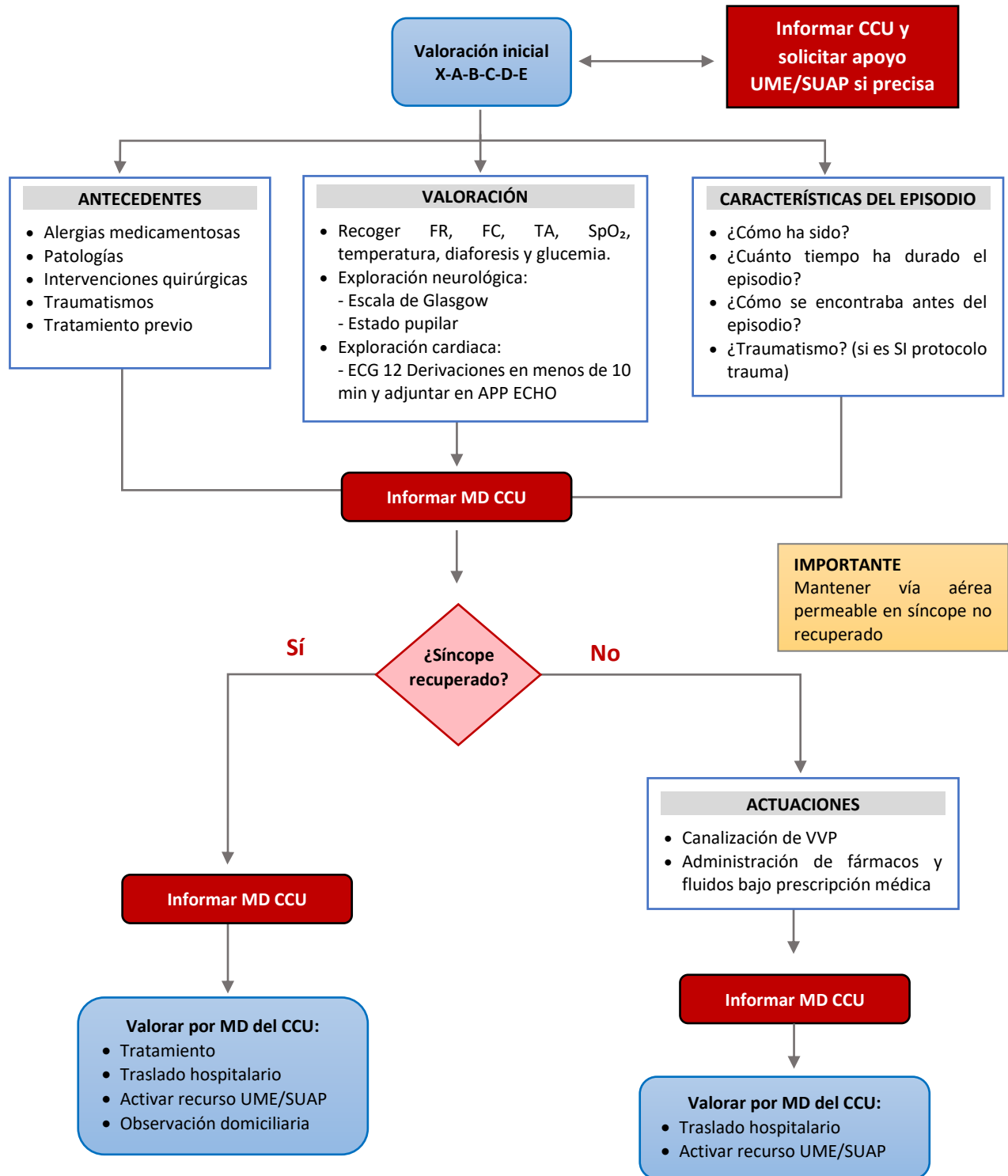
7.5 Plan de Actuación

Realizar una evaluación primaria para identificar y abordar de forma inmediata cualquier problema que represente un riesgo vital (consultar epígrafe 1: Procedimiento General de Actuación SVAE).

A continuación, llevar a cabo el proceso de cuidados específicos descrito en el siguiente algoritmo:



ATENCIÓN AL PACIENTE CON SÍNCOPE



7.6 Observaciones

1. **Pacientes con síncope cardíaco:** Estos pacientes son considerados de alto riesgo, ya que el síncope suele estar asociado a hipoperfusión cerebral secundaria a un bajo gasto cardíaco. Su evaluación y manejo deben priorizarse debido a la potencial gravedad de la causa subyacente.
2. **Personas mayores:** En ancianos, la causa más frecuente de síncope es la hipotensión ortostática, cuya incidencia aumenta con la edad. Además, deben considerarse otras etiologías comunes como la medicación y las patologías cardíacas, que requieren una evaluación exhaustiva.
3. **Pacientes pediátricos:**
 - En niños, la mayoría de los síncope son de origen reflejo y rara vez están asociados a causas que pongan en peligro la vida, aunque siempre deben ser investigados.
 - **Niños y adolescentes:** La educación es la base del tratamiento. Es fundamental tranquilizarlos, crear un entorno seguro y privado (como el interior de la ambulancia) y permitir que los padres estén presentes en todo momento.
 - **Lactantes e infantes:** Durante la valoración inicial, es aconsejable que el niño permanezca en brazos de su madre para reducir la ansiedad. La evaluación debe incluir el trabajo respiratorio, la apariencia general y la circulación cutánea.
4. **Mujeres embarazadas:** En mujeres con más de 24 semanas de gestación, debe evitarse el síndrome de compresión de la vena cava inferior que ocurre en posición de decúbito supino. Para prevenirlo, se recomienda inclinar la zona lumbar hacia el lado izquierdo, elevando aproximadamente 30 grados el lateral derecho.



7.7 Historia de Cuidados de Enfermería (SVAE)

En la Historia de Cuidados de Enfermería Extrahospitalaria se deben registrar, como mínimo, los siguientes datos:

V. REGISTRO DE ENFERMERÍA			
Etiquetas diagnósticas NANDA	Resultados NOC	Intervenciones NIC	
☐ 00257 Sd. Fragilidad del anciano	☐ 0802 Signos Vitales ☐ 1912 Caídas ☐ 0208 Movilidad ☐ 2402 Función sensitiva ☐ 1913 Severidad de la lesión física	☐ 6680 Monitorización de los signos vitales ☐ 4420 Acuerdo con el paciente ☐ 5510 Educación para la salud ☐ 7170 Facilitar la presencia de la familia	☐ 4235 Flebotomía: vía canalizada. Tipo: _____ Calibre: _____ Localización: _____ ☐ 7820 Manejo de muestras. Tipo: _____ ☐ 1380 Aplicación de calor o frío ☐ 3900 Regulación de la temperatura ☐ 6610 Identificación de riesgos ☐ 6364 Triaje: centro de urgencias ☐ 7140 Apoyo a la familia ☐ 6650 Vigilancia ☐ 7680 Ayuda a la exploración ☐ 8020 Reunión multidisciplinar de cuidados ☐ 7910 Consulta ☐ 7726 Preceptor: estudiante
☐ 00103 Deterioro de la deglución ☐ 00179 Riesgo de nivel de glucemia inestable ☐ 00002 Desequilibrio nutricional: inferior a las necesidades corporales ☐ 00232 Obesidad ☐ 00233 Sobrepeso ☐ 00134 Náuseas	☐ 1010 Estado de deglución ☐ 2300 Nivel de glucemia ☐ 1404 Estado nutricional ☐ 1618 Control de náuseas y vómitos	☐ 1080 Sondaje nasogástrico. Calibre: _____ ☐ 4035 Muestra de sangre capilar ☐ 2120 Manejo de la hiperglucemia ☐ 2130 Manejo de la hipoglucemia ☐ 1100 Manejo de la nutrición ☐ 1570 Manejo del vómito	
☐ 00016 Deterioro de la eliminación urinaria ☐ 00023 Retención urinaria ☐ 00011 Estreñimiento. ☐ 00013 Diarrea.	☐ 0501 Eliminación intestinal. ☐ 0503 Eliminación urinaria.	☐ 0590 Manejo de la eliminación urinaria ☐ 0580 Sondaje Vesical Calibre: _____ Débito: _____ ☐ 0620 Cuidados de la retención urinaria ☐ 1876 Cuidados del catéter urinario ☐ 0430 Control intestinal	Valoración de Enfermería Percepción-Manejo de la Salud Adherencia al tratamiento: Si ☐ NO ☐ Ingresos hospitalarios previos: Si ☐ NO ☐ Hábitos tóxicos: Si ☐ NO ☐
☐ 00030 Deterioro del intercambio de gases ☐ 00032 Patrón respiratorio ineficaz ☐ 00031 Limpieza ineficaz de vía aérea. ☐ 00039 Riesgo de aspiración.	☐ 0415 Estado respiratorio	☐ 3160 Aspiración de las vías aéreas Oxigenoterapia. FIO ₂ _____ lts/min: _____ Tipo: _____ ☐ 3302 Manejo de la ventilación mecánica: no invasiva. Modo: _____ FIO ₂ _____ PEEP: _____ Trigger: _____ Frec. Resp: _____	Nutrición-Metabólico Autónomo ☐ Dependiente ☐ Dieta equilibrada ☐ Disfagia ☐ SNG ☐ PEG ☐ Problemas digestivos: _____
☐ 00029 Disminución del gasto cardíaco ☐ 00267 Riesgo de tensión arterial inestable	☐ 0400 Efectividad de la bomba cardíaca. ☐ 0401 Estado circulatorio ☐ 2301 Respuesta a la medicación	☐ 4250 Manejo del shock. ☐ 4040 Cuidados cardíacos. ☐ ECG ☐ Monitor ☐ 4162 Manejo de la hipertensión ☐ 4175 Manejo de la hipotensión ☐ 4092 Manejo del marcapasos: temporal Frec: _____ mVoltios: _____	Eliminación Normal ☐ Incontinencia ☐ Diarrea ☐ Estreñimiento ☐
☐ 00051 Deterioro de la comunicación verbal ☐ 00128 Confusión aguda. ☐ 00129 Confusión crónica. ☐ 00146 Ansiedad.	☐ 0902 Comunicación ☐ 0909 Estado neurológico ☐ 1214 Nivel de agitación ☐ 1211 Nivel de ansiedad	☐ 2620 Monitorización neurológica. ☐ 5270 Apoyo emocional. ☐ 4929 Escucha activa	Actividad-Ejercicio Activo ☐ Sedentario ☐ Movilidad: Autónomo ☐ Necesita ayuda ☐ Dependiente ☐
☐ 00114 Síndrome de estrés del traslado	☐ 0210 Realización de transferencia ☐ 1311 Adaptación al traslado	☐ 8100 Derivación ☐ 7890 Transporte entre instalaciones ☐ 7710 Colaboración con el médico ☐ 7960 Intercambio de información de cuidados de salud	Sueño-Descanso Normal ☐ Alterado ☐ Ayudas para dormir ☐
☐ 00004 Riesgo de infección ☐ 00206 Riesgo de sangrado ☐ 00038 Riesgo de traumatismo físico ☐ 00312 Lesión por presión en el adulto ☐ 00044 Deterioro de la integridad tisular ☐ 00303 Riesgos de caídas en el adulto	☐ 1101 Integridad tisular: piel	☐ 4020 Disminución de la Hemorragia ☐ Torqu Shore. Hora: _____ ☐ Compresión ☐ 3660 Cuidados de la herida. ☐ 3620 Sutura ☐ 6610 Identificación de riesgos	Cognitivo-Perceptivo Consciente: Si ☐ NO ☐ Orientado: Si ☐ NO ☐
☐ 00132 Dolor agudo ☐ 00133 Dolor crónico	☐ 1605 Control del dolor	☐ 2300 Administración de Medicación. ☐ 1410 Manejo del dolor: agudo ☐ 1415 Manejo del dolor: crónico	Autopercepción-Autoconcepto Conducta: No alterado ☐ Alterado ☐
☐ 00020 Riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca ☐ 00033 Deterioro de la ventilación espontánea	☐ 0414 Estado cardiopulmonar	☐ 6200 Cuidados de la emergencia ☐ 6140 Manejo de la parada cardiopulmonaria ☐ 6320 Reanimación ☐ 4095 Manejo del desfibrilador ☐ 3140 Manejo de la vía aérea. Tipo: _____	Rol-Relaciones Mayor Vulnerable ☐ Violencia doméstica ☐ Ayuda domiciliaria ☐ Menor Vulnerable ☐ Sin Hogar ☐ Conducta suicida ☐ Riesgo Social ☐ Síndrome Diógenes ☐
			Sexualidad y reproducción Adaptación tolerancia al estrés Valores y creencias

Se marcará lo que proceda.

7.8 Bibliografía

1. Procedimiento General de Actuación SVAE. Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de la Región de Murcia. 2022.
2. Guía de Actuación Enfermera de Urgencias y Emergencias prehospitalarias. Emergències mèdiques 061. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. 2015.
3. Guía de Actuación Extrahospitalaria para Soporte Vital Avanzado Enfermero. Ediciones CECOVA. Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana. 2023
4. Pardo, C, Muñoz, T, Chamorro, C. Monitorización del dolor. Recomendaciones del grupo de trabajo de analgesia y sedación de la SEMICYUC. 2006.
5. Guía farmacoterapéutica de medicamentos utilizados por los servicios de urgencias y emergencias sanitarias 061 de la Región de Murcia. Servicio Murciano de Salud. 2014.
6. Manual de protocolos asistenciales. Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias. PAUE. Servicio Andaluz de Salud. 2012
7. Manual y procedimientos de Enfermería SUMMA 112. Comunidad de Madrid. 2012.
8. Casas Benavent, V, Iniesta Roser, R. Procesos asistenciales SVA Enfermería. Servicio de Emergencias Sanitarias. Generalitat Valenciana. 2021



8. ATENCIÓN AL PACIENTE CON CONVULSIONES

8.1 Definición

Una crisis convulsiva se define como una descarga excesiva y sincrónica de un grupo de neuronas, cuya localización determina la manifestación clínica, que puede incluir síntomas motores, sensitivos, autonómicos o psíquicos, con o sin pérdida de consciencia. Las convulsiones pueden clasificarse como:

- **Sintomáticas o secundarias:** Provocadas por un estímulo transitorio que altera la actividad cerebral, como hipoglucemia, traumatismos, fiebre o infecciones del sistema nervioso central.
- **Idiopáticas:** Sin relación temporal con un estímulo conocido. Cuando estas convulsiones idiopáticas son recurrentes, se utiliza el término **epilepsia**.

El término **estatus epiléptico** se refiere a una condición en la que la actividad convulsiva persiste durante más de 30 minutos o se repite con tanta frecuencia que no permite una recuperación completa de la consciencia entre episodios.

8.2 Objetivos

- **Interrumpir la actividad convulsiva:** Implementar las medidas necesarias para controlar de manera efectiva las convulsiones en curso, minimizando su duración e impacto en el paciente.
- **Prevenir complicaciones secundarias:** Reducir el riesgo de lesiones físicas o daños adicionales derivados de la actividad convulsiva, como traumatismos o compromiso de las vías respiratorias.
- **Identificar la causa subyacente:** Realizar una evaluación clínica exhaustiva para determinar los factores desencadenantes de la crisis convulsiva, diferenciando entre causas transitorias, estructurales o idiopáticas.

8.3 Ámbito de Aplicación

Pacientes adultos y pediátricos que requieran atención sanitaria en un contexto extrahospitalario.



8.4 Materiales

- Monitor y parches desfibrilación
- Ampulario
- Mochila de Circulatorio
- Mochila de Respiratorio
- Otro material que precise para la asistencia.

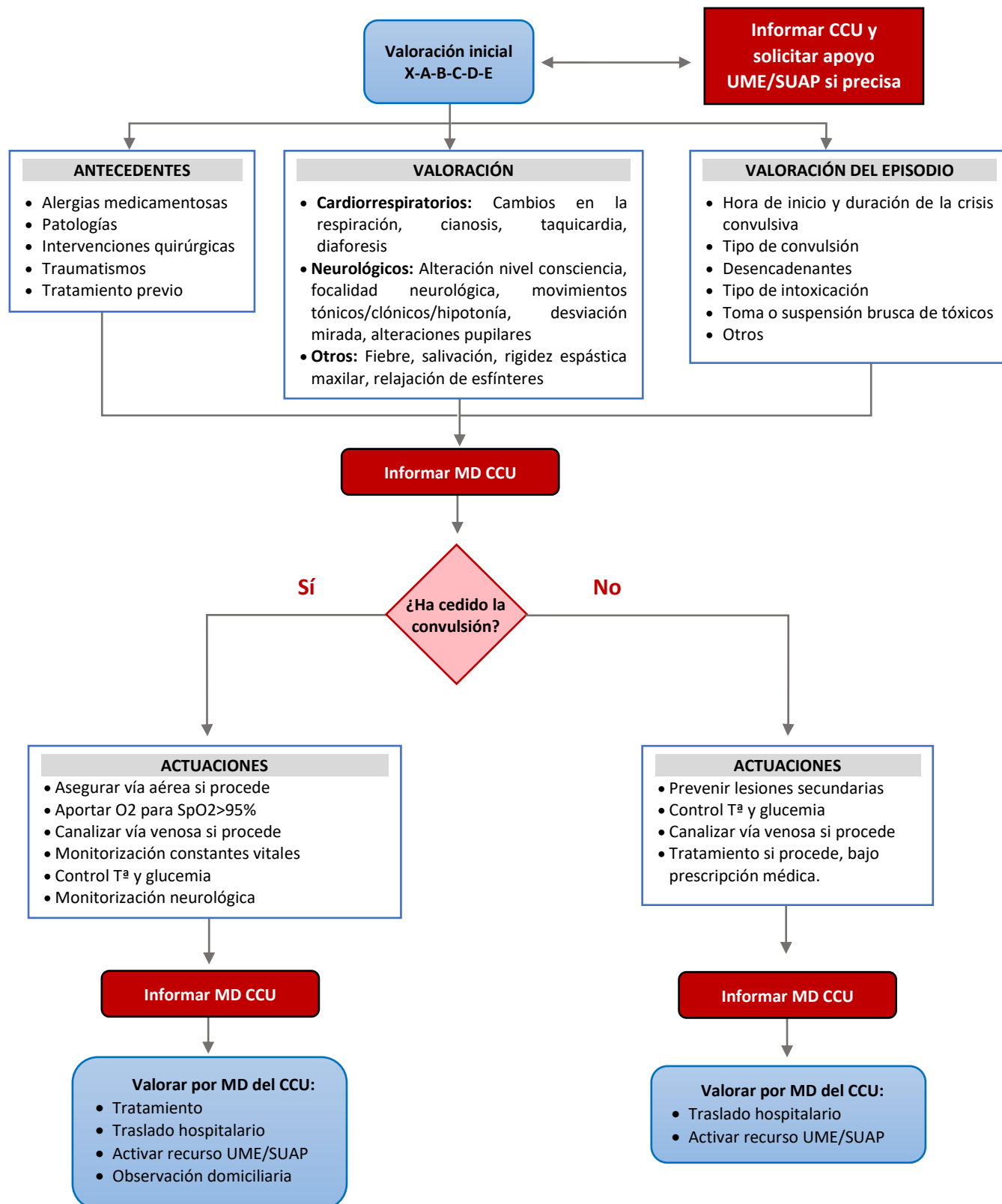
Consultar anexo 1 para la ubicación del material.

8.5 Plan de Actuación

Realizar una evaluación primaria orientada a identificar y tratar de manera inmediata cualquier problema que represente un riesgo vital (consultar epígrafe 1: Procedimiento General de Actuación SVAE). Implementar el proceso de cuidados específico descrito a continuación:



ATENCIÓN AL PACIENTE CON CONVULSIONES





8.6 Observaciones

Valoración del episodio

- Hora de inicio y duración de la crisis convulsiva
- Tipo de convulsión: parcial o generalizada (hipotónica, mioclónica, tonicoclónica)
- Administración de fármacos por la familia
- Desencadenantes (fiebre, hipoxia, hipoglucemia, abandono de la medicación, otros.)
- Intoxicación por fármacos (antidepresivos, antihistamínicos, antipsicóticos...)
- Intoxicación (alcohol, drogas, plomo, mercurios, CO, insecticidas organofosforados)
- Toma o suspensión brusca de tóxicos
- TCE previo, enfermedad vascular cerebral previa.



8.7 Historia de Cuidados de Enfermería (SVAE)

En la Historia de Cuidados de Enfermería Extrahospitalaria se deben registrar, como mínimo, los siguientes datos:

V. REGISTRO DE ENFERMERÍA		
Etiquetas diagnóstico NANDA	Resultados NOC	Intervenciones NIC
☐ 00257 Sd. Fragilidad del anciano ☐ 00103 Deterioro de la deglución ☐ 00179 Riesgo de nivel de glucemia inestable ☐ 00002 Desequilibrio nutricional: inferior a las necesidades corporales ☐ 00232 Obesidad ☐ 00233 Sobrepeso ☐ 00134 Náuseas	Paciente Frágil ☐ 0902 Signos Vitales ☐ 1912 Caídas ☐ 0208 Movilidad ☐ 2402 Función sensitiva ☐ 1913 Severidad de la lesión física Nutrición ☐ 1010 Estado de deglución ☐ 2300 Nivel de glucemia ☐ 1404 Estado nutricional ☐ 1618 Control de náuseas y vómitos Eliminación ☐ 0501 Eliminación intestinal. ☐ 0503 Eliminación urinaria. Respiratorio ☐ 0415 Estado respiratorio Circulatorio ☐ 0400 Efectividad de la bomba cardíaca. ☐ 0401 Estado circulatorio ☐ 2301 Respuesta a la medicación	NIC válidos para varios diagnósticos ☐ 4235 Flebotomía: vía canalizada. Tipo: _____ Calibre: _____ Localización: _____ ☐ 7820 Manejo de muestras. Tipo: _____ ☐ 1380 Aplicación de calor o frío ☐ 3900 Regulación de la temperatura ☐ 6610 Identificación de riesgos ☐ 6364 Triaje: centro de urgencias ☐ 7140 Apoyo a la familia ☐ 6650 Vigilancia ☐ 7680 Ayuda a la exploración ☐ 8020 Reunión multidisciplinar de cuidados ☐ 7910 Consulta ☐ 7726 Preceptor: estudiante Valoración de Enfermería Percepción-Manejo de la Salud Adherencia al tratamiento: Si ☐ No ☐ Ingresos hospitalarios previos: Si ☐ No ☐ Hábitos tóxicos: Si ☐ No ☐ Nutrición-Metabólico Autónomo ☐ Dependiente ☐ Dieta equilibrada ☐ Disfagia ☐ SNG ☐ PEG ☐ Problemas digestivos: _____ Eliminación Normal ☐ Incontinencia ☐ Diarrea ☐ Estreñimiento ☐ Actividad-Ejercicio Activo ☐ Sedentario ☐ Movilidad: Autónomo ☐ Necesita ayuda ☐ Dependiente ☐ Suño-Descanso Normal ☐ Alterado ☐ Ayudas para dormir ☐ Equilibrio-Percepción Consciente: Si ☐ NO ☐ Orientado: Si ☐ NO ☐ Auto-percepción-Auto-concepto Conducta: No alterado ☐ Alterado ☐ Rel-Relaciones Mayor Vulnerable ☐ Violencia doméstica ☐ Ayuda domiciliaria ☐ Menor Vulnerable ☐ Sin Hogar ☐ Conducta suicida ☐ Riesgo Social ☐ Síndrome Diógenes ☐ Otros: _____ Sexualidad y reproducción Adaptación tolerancia al estrés Valores y creencias
☐ 00029 Deterioro del intercambio de gases ☐ 00032 Patrón respiratorio ineficaz ☐ 00031 Limpieza ineficaz de vía aérea. ☐ 00039 Riesgo de aspiración.	Psicológico/Neurológico ☐ 0902 Comunicación ☐ 0909 Estado neurológico ☐ 1214 Nivel de agitación ☐ 1211 Nivel de ansiedad Traslado ☐ 0210 Realización de transferencia ☐ 1311 Adaptación al traslado	☐ 0590 Manejo de la eliminación urinaria ☐ 0580 Sondaje Vesical Calibre: _____ Débito: _____ ☐ 0620 Cuidados de la retención urinaria ☐ 1876 Cuidados del catéter urinario ☐ 0430 Control intestinal ☐ 3160 Aspiración de las vías aéreas ☐ 3320 Oxigenoterapia. FIO ₂ : _____ ts/min: _____ Tipo: _____ ☐ 3302 Manejo de la ventilación mecánica: no invasiva. Modo: _____ FIO ₂ : _____ PEEP: _____ Trigger: _____ Frec. Resp.: _____ ☐ 4250 Manejo del shock. ☐ 4040 Cuidados cardíacos. ☐ ECG ☐ Monitor ☐ Cardioversión ☐ Desfibrilador Julios: _____ Choques: _____ ☐ 4162 Manejo de la hipertensión ☐ 4175 Manejo de la hipotensión ☐ 4092 Manejo del marcapasos: temporal Frec.: _____ mVoltios: _____ ☐ 2620 Monitorización neurológica. ☐ 5270 Apoyo emocional. ☐ 4929 Escucha activa ☐ 8100 Derivación ☐ 7890 Transporte entre instalaciones ☐ 7710 Colaboración con el médico ☐ 7960 Intercambio de información de cuidados de salud ☐ 4020 Disminución de la Hemorragia ☐ Torniquete. Hora: _____ ☐ Compresión ☐ 3660 Cuidados de la herida. ☐ 3620 Sutura ☐ 6610 Identificación de riesgos Dolor ☐ 1605 Control del dolor ☐ 2300 Administración de Medicación. ☐ 1410 Manejo del dolor: agudo ☐ 1415 Manejo del dolor: crónico PCR ☐ 6200 Cuidados de la emergencia ☐ 6140 Manejo de la parada cardiorrespiratoria ☐ 6320 Reanimación ☐ 4095 Manejo del desfibrilador ☐ 3140 Manejo de la vía aérea. Tipo: _____
☐ 00004 Riesgo de infección ☐ 00206 Riesgo de sangrado ☐ 00038 Riesgo de traumatismo físico ☐ 00312 Lesión por presión en el adulto ☐ 00044 Deterioro de la integridad tisular ☐ 00303 Riesgos de caídas en el adulto	☐ 1101 Integridad tisular: piel Dolor ☐ 1605 Control del dolor PCR ☐ 0414 Estado cardiopulmonar	☐ 00020 Riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca ☐ 00033 Deterioro de la ventilación espontánea

Se marcará lo que proceda.

8.8 Bibliografía

1. Procedimiento General de Actuación SVAE. Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de la Región de Murcia. 2020.
2. Guía de Actuación Enfermera de Urgencias y Emergencias prehospitalarias. Emergències mèdiques 061. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. 2015.
3. Guía de Actuación Extrahospitalaria para Soporte Vital Avanzado Enfermero. Ediciones CECOVA. Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana. 2023
4. Pardo, C, Muñoz, T, Chamorro, C. Monitorización del dolor. Recomendaciones del grupo de trabajo de analgesia y sedación de la SEMICYUC. 2006.
5. Guía farmacoterapéutica de medicamentos utilizados por los servicios de urgencias y emergencias sanitarias 061 de la Región de Murcia. Servicio Murciano de Salud. 2014.
6. Manual de protocolos asistenciales. Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias. PAUE. Servicio Andaluz de Salud. 2012
7. Manual y procedimientos de Enfermería SUMMA 112. Comunidad de Madrid. 2012.
8. Casas Benavent, V, Iniesta Roser, R. Procesos asistenciales SVA Enfermería. Servicio de Emergencias Sanitarias. Generalitat Valenciana. 2021



9. ATENCIÓN AL PACIENTE CON ALTERACIÓN DE LA GLUCEMIA

9.1 Definición

La alteración de los niveles de glucosa en sangre, ya sea en forma de hipoglucemia o hiperglucemia, constituye una condición clínica que puede comprometer la seguridad y el bienestar del paciente, requiriendo una atención médica inmediata.

La **hipoglucemia**, caracterizada por niveles de glucosa en sangre inferiores a **50 mg/dl**, puede provocar síntomas graves como confusión, pérdida de conciencia, convulsiones y, en casos extremos, riesgo de vida. Por otro lado, la **hiperglucemia**, definida como niveles superiores a **200 mg/dl**, puede estar asociada a complicaciones agudas, como cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar, además de aumentar el riesgo de daño orgánico a largo plazo si no se interviene de manera adecuada.

Este protocolo establece un conjunto de actividades dirigidas a proporcionar cuidados integrales al paciente durante un episodio de hipoglucemia o hiperglucemia, asegurando un enfoque sistemático que abarca desde la evaluación inicial hasta la estabilización del paciente.

9.2 Objetivos

- Detectar de manera rápida y eficaz las situaciones que requieren una actuación urgente.
- Analizar las posibles causas subyacentes de la alteración de la glucemia.
- Aplicar las intervenciones específicas establecidas en el protocolo para restablecer los valores normales de glucosa.
- Prevenir la aparición de complicaciones graves asociadas a la alteración de la glucemia.

9.3 Ámbito de Aplicación

Pacientes adultos y pediátricos que requieran atención sanitaria en un contexto extrahospitalario.



9.4 Materiales

- Monitor y parches desfibrilación
- Ampulario
- Mochila de Circulatorio
- Mochila de Respiratorio
- Otro material que precise para la asistencia.

Consultar anexo 1 para la ubicación del material.

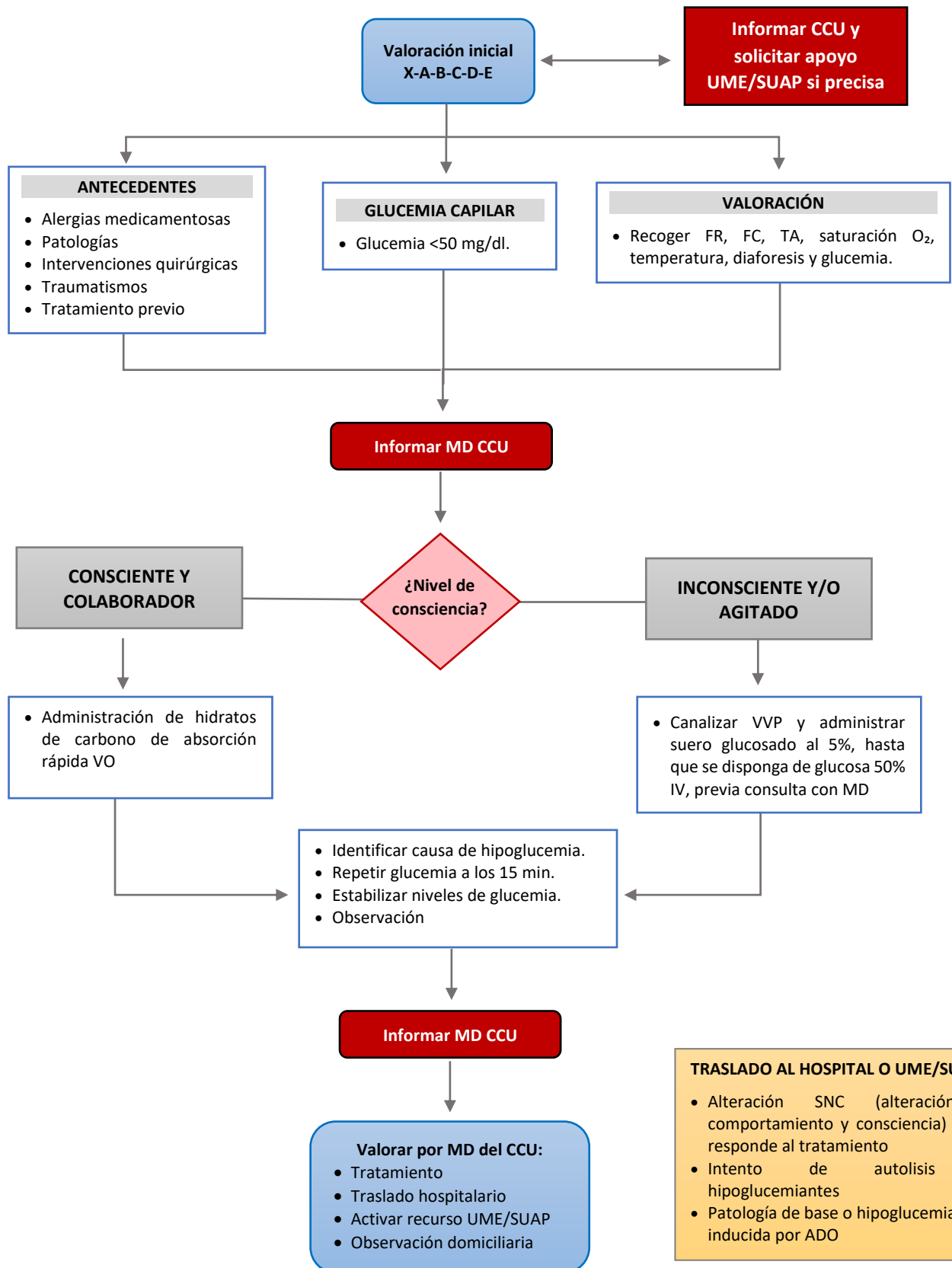
9.5 Plan de Actuación

Realizar una evaluación primaria orientada a identificar y tratar de manera inmediata cualquier problema que represente un riesgo vital (consultar epígrafe 1: Procedimiento General de Actuación SVAE).

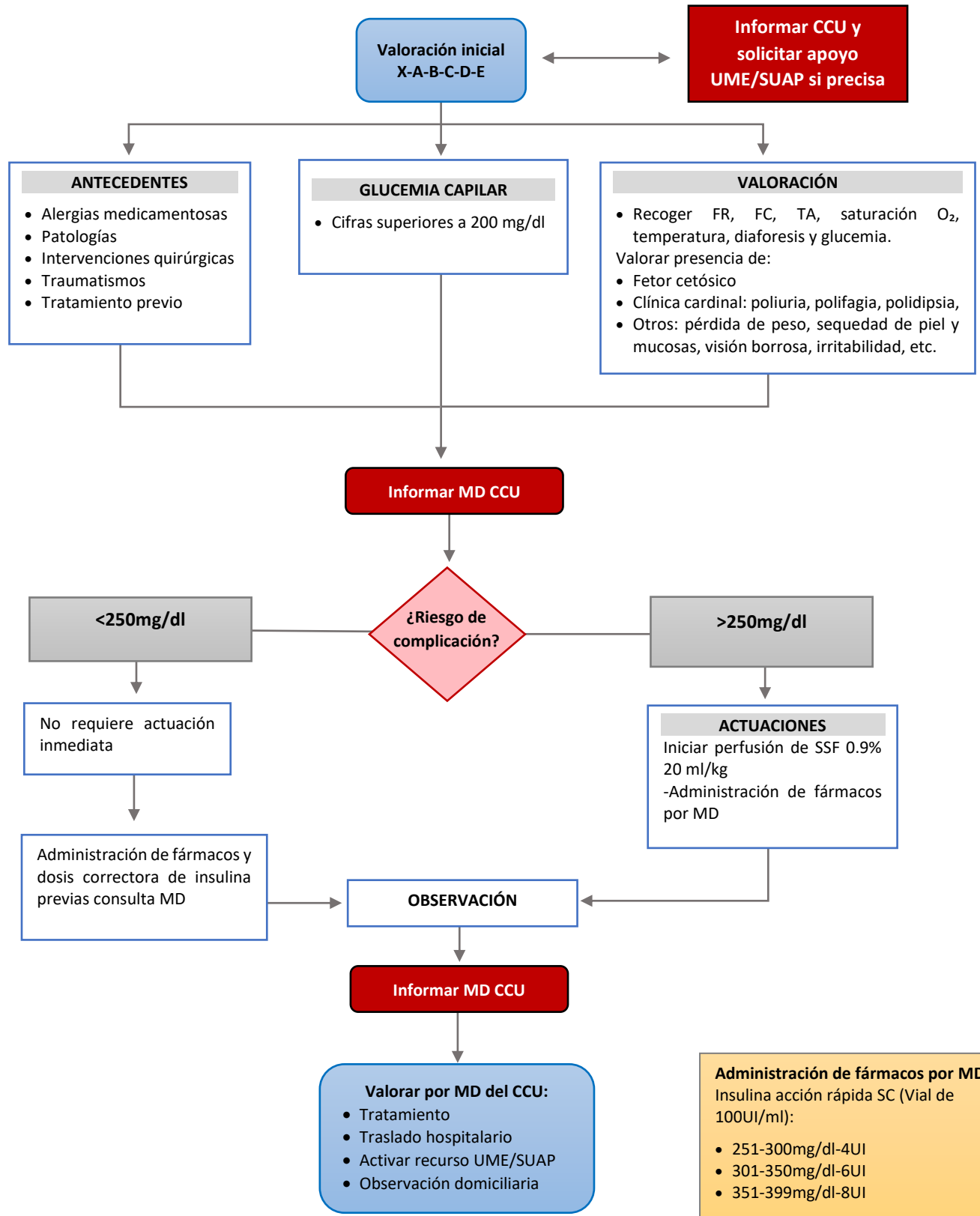
Implementar el proceso de cuidados específico descrito a continuación:



ATENCIÓN AL PACIENTE CON HIPOGLUCEMIA



ATENCIÓN AL PACIENTE CON HIPERGLUCEMIA



9.6 Observaciones

En pacientes con Diabetes Mellitus no diagnosticada:

- Es fundamental considerar el despistaje de hiperglucemias superiores a 180 mg/dl, especialmente en aquellos que estén recibiendo tratamiento con esteroides o nutrición artificial.
- Se debe investigar la presencia de síntomas asociados, como poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso.
- Se proporcionará al paciente información básica sobre la enfermedad para favorecer su comprensión.
- Se evaluará la capacidad de comprensión del paciente y, en la población anciana, las habilidades y competencias del cuidador principal para garantizar un manejo adecuado.

En pacientes con Diabetes Mellitus diagnosticada:

Es importante indagar sobre:

- La adecuación de las dosis de insulina y agentes hipoglucemiantes orales.
- El uso de tratamientos con corticoides.
- La adherencia a una dieta adecuada en el contexto del tratamiento.

Se valorará la capacidad de comprensión del paciente o del cuidador principal, haciendo énfasis en la población anciana para asegurar un correcto manejo de la enfermedad.

En mujeres gestantes se seguirá el procedimiento estándar establecido para los pacientes adultos, adaptándolo según sea necesario.



9.7 Historia de Cuidados de Enfermería (SVAE)

En la Historia de Cuidados de Enfermería Extrahospitalaria se deben registrar, como mínimo, los siguientes datos:

V. REGISTRO DE ENFERMERÍA		
Etiquetas diagnóstico NANDA	Resultados NOC	Intervenciones NIC
☐ 00257 Sd. Fragilidad del anciano	Paciente Frágil ☐ 0802 Signos Vitales ☐ 1912 Caídas ☐ 0208 Movilidad ☐ 2402 Función sensitiva ☐ 1913 Severidad de la lesión física	NIC válidos para varios diagnósticos ☐ 4235 Flebotomía: vía canalizada. Tipo: _____ Calibre: _____ Localización: _____ ☐ 7820 Manejo de muestras. Tipo: _____ ☐ 1380 Aplicación de calor o frío ☐ 3900 Regulación de la temperatura ☐ 6610 Identificación de riesgos ☐ 6364 Triaje: centro de urgencias ☐ 7140 Apoyo a la familia ☐ 6650 Vigilancia ☐ 7680 Ayuda a la exploración ☐ 6020 Reunión multidisciplinar de cuidados ☐ 7910 Consulta ☐ 7726 Preceptor: estudiante
☐ 00103 Deterioro de la deglución ☐ 00179 Riesgo de nivel de glucemia inestable ☐ 00002 Desequilibrio nutricional: inferior a las necesidades corporales ☐ 00232 Obesidad ☐ 00233 Sobre peso ☐ 00134 Náuseas	Nutrición ☐ 1010 Estado de deglución ☐ 2300 Nivel de glucemia ☐ 1404 Estado nutricional ☐ 1618 Control de náuseas y vómitos	☐ 1080 Sondaje nasogástrico. Calibre: _____ ☐ 4035 Muestra de sangre capilar ☐ 2120 Manejo de la hiperglucemia ☐ 2130 Manejo de la hipoglucemia ☐ 1100 Manejo de la nutrición ☐ 1570 Manejo del vómito
☐ 00016 Deterioro de la eliminación urinaria ☐ 00023 Retención urinaria ☐ 00011 Estreñimiento. ☐ 00013 Diarrea.	Eliminación ☐ 0501 Eliminación intestinal. ☐ 0503 Eliminación urinaria.	☐ 0590 Manejo de la eliminación urinaria ☐ 0580 Sondaje Vesical Calibre: _____ Débito: _____ ☐ 0620 Cuidados de la retención urinaria ☐ 1876 Cuidados del catéter urinario ☐ 0430 Control intestinal
☐ 00030 Deterioro del intercambio de gases ☐ 00032 Patrón respiratorio ineficaz ☐ 00031 Limpieza ineficaz de vía aérea. ☐ 00039 Riesgo de aspiración.	Respiratorio ☐ 0415 Estado respiratorio	☐ 3160 Aspiración de las vías aéreas ☐ 3320 Oxigenoterapia. FIO ₂ : _____ lts/min: _____ Tipo: _____ ☐ 3302 Manejo de la ventilación mecánica: no Invasiva. Modo: _____ FIO ₂ : _____ PEEP: _____ Trigger: _____ Frec. Resp: _____
☐ 00029 Disminución del gasto cardiaco ☐ 00267 Riesgo de tensión arterial inestable	Circulatorio ☐ 0400 Efectividad de la bomba cardiaca. ☐ 0401 Estado circulatorio ☐ 2301 Respuesta a la medicación	☐ 4250 Manejo del shock. ☐ 4040 Cuidados cardiacos. ☐ ECG ☐ Monitor ☐ Cardioversión ☐ Desfibrilador Julios: _____ Choques: _____ ☐ 4162 Manejo de la hipertensión ☐ 4175 Manejo de la hipotensión ☐ 4092 Manejo del marcapasos: temporal Frec: _____ mVolts: _____
☐ 00051 Deterioro de la comunicación verbal ☐ 00128 Confusión aguda. ☐ 00129 Confusión crónica. ☐ 00146 Ansiedad.	Psicológico/Neurológico ☐ 0902 Comunicación ☐ 0909 Estado neurológico ☐ 1214 Nivel de agitación ☐ 1211 Nivel de ansiedad	☐ 2620 Monitorización neurológica. ☐ 5270 Apoyo emocional. ☐ 4929 Escucha activa
☐ 00114 Síndrome de estrés del traslado	Traslado ☐ 0210 Realización de transferencia ☐ 1311 Adaptación al traslado	☐ 8100 Derivación ☐ 7890 Transporte entre instalaciones ☐ 7710 Colaboración con el médico ☐ 7960 Intercambio de información de cuidados de salud
☐ 00004 Riesgo de infección ☐ 00206 Riesgo de sangrado ☐ 00038 Riesgo de traumatismo físico ☐ 00312 Lesión por presión en el adulto ☐ 00044 Deterioro de la integridad tisular ☐ 00303 Riesgos de caídas en el adulto	Musculoesquelético ☐ 1101 Integridad tisular: piel	☐ 4020 Disminución de la Hemorragia ☐ Torniquete. Hora: _____ ☐ Compresión ☐ 3660 Cuidados de la herida. ☐ 3620 Sutura ☐ 6610 Identificación de riesgos
☐ 00132 Dolor agudo ☐ 00133 Dolor crónico	Dolor ☐ 1605 Control del dolor	☐ 2300 Administración de Medicación. ☐ 1410 Manejo del dolor: agudo ☐ 1415 Manejo del dolor: crónico
☐ 00020 Riesgo de disminución de la perfusión tisular cardiaca ☐ 00033 Deterioro de la ventilación espontánea	PCR ☐ 0414 Estado cardiopulmonar	☐ 6200 Cuidados de la emergencia ☐ 6140 Manejo de la parada cardiopulmonar ☐ 6320 Reanimación ☐ 4095 Manejo del desfibrilador ☐ 3140 Manejo de la vía aérea. Tipo: _____

Se marcará lo que proceda.

9.8 Bibliografía

1. Procedimiento General de Actuación SVAE. Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de la Región de Murcia. 2020.
2. Guía de Actuación Enfermera de Urgencias y Emergencias prehospitalarias. Emergències mèdiques 061. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. 2015.
3. Guía de Actuación Extrahospitalaria para Soporte Vital Avanzado Enfermero. Ediciones CECOVA. Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana. 2023
4. Pardo, C, Muñoz, T, Chamorro, C. Monitorización del dolor. Recomendaciones del grupo de trabajo de analgesia y sedación de la SEMICYUC. 2006.
5. Guía farmacoterapéutica de medicamentos utilizados por los servicios de urgencias y emergencias sanitarias 061 de la Región de Murcia. Servicio Murciano de Salud. 2014.
6. Manual de protocolos asistenciales. Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias. PAUE. Servicio Andaluz de Salud. 2012
7. Manual y procedimientos de Enfermería SUMMA 112. Comunidad de Madrid. 2012.
8. Casas Benavent, V, Iniasta Roser, R. Procesos asistenciales SVA Enfermería. Servicio de Emergencias Sanitarias. Generalitat Valenciana. 2021
9. Procesos asistenciales: SVA. Procedimientos SAMUR- Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid. Disponible en:
<https://www.madrid.es/ficheros/SAMUR/> (Consultado 07/10/2024)



10. ATENCIÓN AL PACIENTE AGITADO

10.1 Definición

La agitación psicomotriz es un estado de intensa excitación mental, que se acompaña de un aumento anómalo de la actividad motora, que puede variar en intensidad, desde una leve inquietud hasta movimientos descoordinados y sin propósito claro. Se trata de un síndrome no específico, con diversas causas posibles, y se caracteriza por una alteración en el comportamiento motor. Esto implica un incremento excesivo y desorganizado de la motricidad, asociado a una activación del sistema autónomo (como sudoración excesiva, taquicardia, dilatación pupilar, entre otros), junto con una fuerte ansiedad, pánico u otros estados emocionales intensos.

10.2 Objetivos

- Identificar las situaciones que pongan en peligro la vida del paciente.
- Garantizar la seguridad del paciente y del equipo asistencial.
- Favorecer el estado de bienestar físico y psicológico del paciente.

10.3 Ámbito de Aplicación

Paciente agitado con necesidad de asistencia sanitaria en contexto extrahospitalario.

10.4 Materiales

- Monitor y parches desfibrilación
- Ampulario
- Mochila de Circulatorio
- Mochila de Respiratorio
- Otro material que precise para la asistencia.

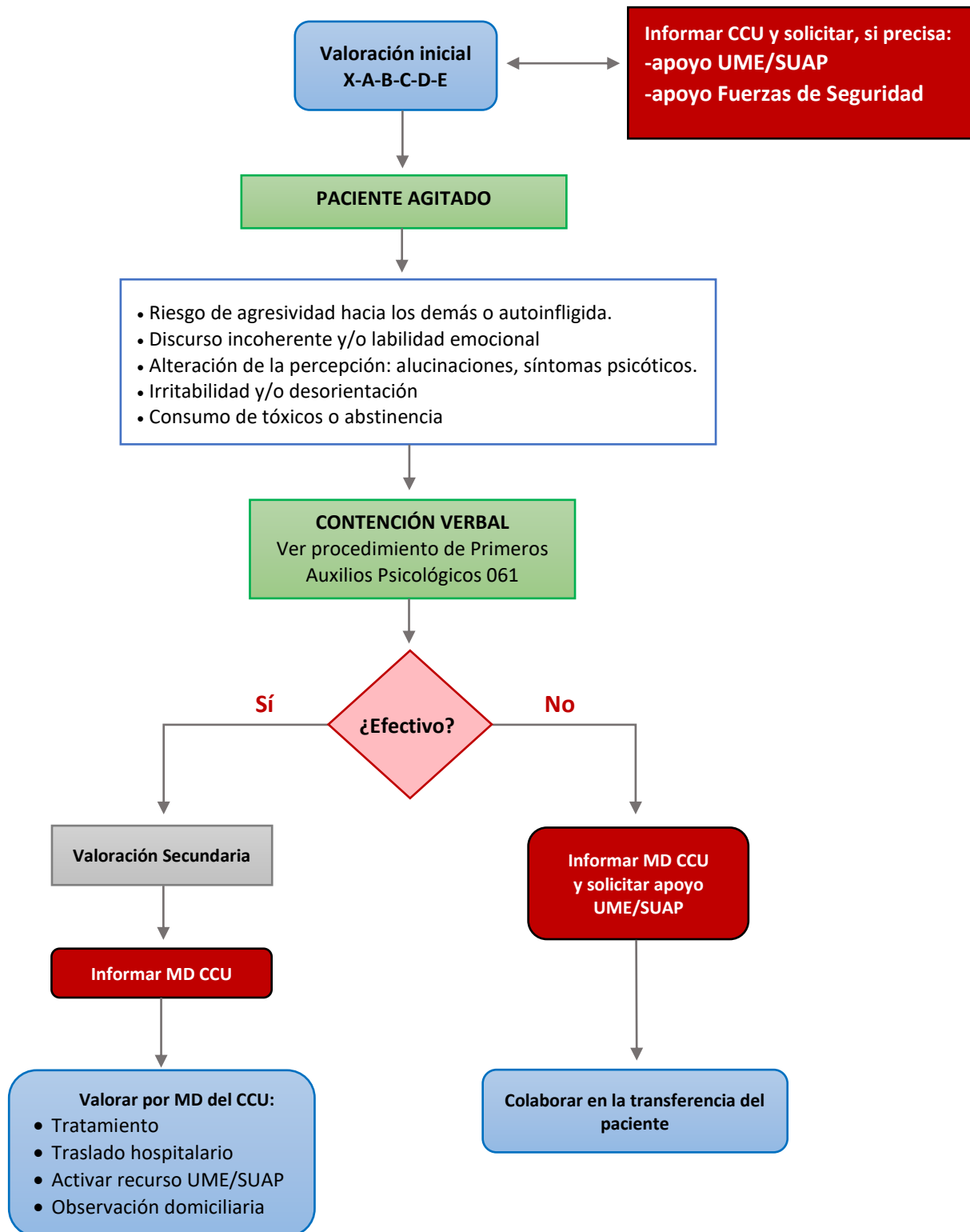
Consultar anexo 1 para la ubicación del material.

10.5 Plan de Actuación

Realizar por un lado, una evaluación primaria orientada a identificar y tratar de manera inmediata cualquier problema que represente un riesgo vital terapéutico (consultar epígrafe 1: Procedimiento General de Actuación SVAE), y por otro, una valoración secundaria que permita el mejor abordaje descrito a continuación:



ATENCIÓN AL PACIENTE AGITADO



10.6 Observaciones

A la hora de implementar esta actuación es importante seguir el procedimiento “primeros auxilios psicológicos en afectados de una situación de crisis en urgencias y emergencias extrahospitalarias del 061”. Para más información consultar el procedimiento completo, que se encuentra disponible en la intranet del 061.

En dicho procedimiento, se identifican 3 espacios temporales; antes, durante y después de la intervención. En el momento de la intervención es donde se implementaría el modelo de las 5 C's, que se describe a continuación.

1. **CONTEXTO.** Se trata de conocer la mayor cantidad y precisión de información sobre lo acontecido.
2. **CONTACTO.** Se trata de “vincular” con el paciente para asegurarnos que estamos siendo aceptados. En esta fase es importante que la persona con más competencias psico-sociales sea quien inicie el contacto.
3. **CONTROL PLANO EMOCIONAL.** Se trata de asegurar de cierto control emocional que permita que la comunicación pueda ser efectiva. Si no se consigue asegurar un mínimo de ajuste emocional, toda la información que se comparta no será aprovechada.
4. **CONTROL PLANO COGNITIVO.** Una vez que tenemos asegurada una estabilidad emocional, entonces es el momento de hacer preguntas, de dar instrucciones o pedir la colaboración.
5. **CONTROL PLANO SOCIAL.** Ahora es el momento de vehiculizar el apoyo social externo porque el paciente tiene cierta estabilidad emocional, entiende y colabora en las instrucciones y puede aprovechar el apoyo de su red social inmediata.

Este modelo es gradual y si no se consigue alguna de las fases, no se podría continuar con las siguientes y eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de la implementación del algoritmo de actuación.

En España, la regulación del uso de la contención mecánica en contextos sanitarios y de internamiento involuntario sigue los marcos legales nacionales establecidos por la **Ley de Enjuiciamiento Civil** (Artículo 763) y la **Ley General de Sanidad** (Artículo 10).

En la Región de Murcia, además disponemos de Reglamento de la Ley de Salud Mental de la Región de Murcia (Decreto 21/2010, de 15 de marzo) y de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Salud Mental de la Región de Murcia, que en su artículo 35, se hace referencia a la contención física como medida terapéutica en situaciones de riesgo, y establece que solo debe ser utilizada cuando sea estrictamente necesario y siempre bajo un control estricto, evaluándose su uso en función del bienestar del paciente.



10.7 Historia de Cuidados de Enfermería (SVAE)

En la Historia de Cuidados de Enfermería Extrahospitalaria se deben registrar, como mínimo, los siguientes datos:

V. REGISTRO DE ENFERMERÍA			
Etiquetas diagnóstico NANDA	Resultados NOC	Intervenciones NIC	
☐ 00257 Sd. Fragilidad del anciano ☐ 0802 Signos Vitales ☐ 1912 Caídas ☐ 0208 Movilidad ☐ 2402 Función sensitiva ☐ 1913 Severidad de la lesión física ☐ 6680 Monitorización de los signos vitales ☐ 4420 Acuerdo con el paciente ☐ 5510 Educación para la salud ☐ 7170 Facilitar la presencia de la familia			
☐ 00103 Deterioro de la deglución ☐ 00179 Riesgo de nivel de glucemia inestable ☐ 00002 Desequilibrio nutricional: inferior a las necesidades corporales ☐ 00232 Obesidad ☐ 00233 Sobre peso ☐ 00134 Náuseas ☐ 1010 Estado de deglución ☐ 2300 Nivel de glucemia ☐ 1404 Estado nutricional ☐ 1618 Control de náuseas y vómitos ☐ 1080 Sondaje nasogástrico. Calibre: _____ ☐ 4035 Muestra de sangre capilar ☐ 2120 Manejo de la hiperglucemia ☐ 2130 Manejo de la hipoglucemia ☐ 1100 Manejo de la nutrición ☐ 1570 Manejo del vómito			
☐ 00016 Deterioro de la eliminación urinaria ☐ 00023 Retención urinaria ☐ 00011 Estreñimiento. ☐ 00013 Diarrea. ☐ 0501 Eliminación intestinal. ☐ 0503 Eliminación urinaria. ☐ 0590 Manejo de la eliminación urinaria ☐ 0580 Sondaje Vesical ☐ _____ Débito: _____ ☐ 0620 Cuidados de la retención urinaria ☐ 1876 Cuidados del catéter urinario ☐ 0430 Control intestinal			
☐ 00030 Deterioro del intercambio de gases ☐ 00032 Patrón respiratorio ineficaz ☐ 00031 Limpieza ineficaz de vía aérea. ☐ 00039 Riesgo de aspiración. ☐ 0415 Estado respiratorio ☐ 3160 Aspiración de las vías aéreas ☐ 3320 Oxigenoterapia. FIO₂: _____ lts/min: _____ ☐ _____ Tipo: _____ ☐ 3302 Manejo de la ventilación mecánica: no Invasiva. Modo: _____ FIO₂: _____ ☐ _____ PEEP: _____ Trigger: _____ Frec. Resp: _____			
☐ 00029 Disminución del gasto cardiaco ☐ 00267 Riesgo de tensión arterial inestable ☐ 0400 Efectividad de la bomba cardiaca. ☐ 0401 Estado circulatorio ☐ 2301 Respuesta a la medicación ☐ 4250 Manejo del shock. ☐ 4040 Cuidados cardíacos. ☐ ECG ☐ Monitor ☐ Cardioversión ☐ Desfibrilador ☐ _____ Julios: _____ Choques: _____ ☐ 4162 Manejo de la hipertensión ☐ 4175 Manejo de la hipotensión ☐ 4092 Manejo del marcapasos: temporal Frec: _____ mV/Voltios: _____			
☐ 00051 Deterioro de la comunicación verbal ☐ 00128 Confusión aguda. ☐ 00129 Confusión crónica. ☐ 00146 Ansiedad. ☐ 0902 Comunicación ☐ 0909 Estado neurológico ☐ 1214 Nivel de agitación ☐ 1211 Nivel de ansiedad ☐ 2620 Monitorización neurológica. ☐ 5270 Apoyo emocional. ☐ 4929 Escucha activa			
☐ 00114 Síndrome de estrés del traslado ☐ 0210 Realización de transferencia ☐ 1311 Adaptación al traslado ☐ 8100 Derivación ☐ 7890 Transporte entre instalaciones ☐ 7710 Colaboración con el médico ☐ 7960 Intercambio de información de cuidados de salud			
☐ 00004 Riesgo de infección ☐ 00206 Riesgo de sangrado ☐ 00038 Riesgo de traumatismo físico ☐ 00312 Lesión por presión en el adulto ☐ 00044 Deterioro de la integridad tisular ☐ 00303 Riesgos de caídas en el adulto ☐ 1101 Integridad tisular: piel ☐ 4020 Disminución de la Hemorragia ☐ _____ Torniquete. Hora: _____ ☐ _____ Compresión ☐ 3660 Cuidados de la herida. ☐ 3620 Sutura ☐ 6610 Identificación de riesgos			
☐ 00132 Dolor agudo ☐ 00133 Dolor crónico ☐ 1605 Control del dolor ☐ 2300 Administración de Medicación. ☐ 1410 Manejo del dolor: agudo ☐ 1415 Manejo del dolor: crónico			
☐ 00020 Riesgo de disminución de la perfusión tisular cardiaca ☐ 00033 Deterioro de la ventilación espontánea ☐ 0414 Estado cardiopulmonar ☐ 6200 Cuidados de la emergencia ☐ 6140 Manejo de la parada cardiopulmonar ☐ 6320 Reanimación ☐ 4095 Manejo del desfibrilador ☐ 3140 Manejo de la vía aérea. ☐ _____ Tipo: _____			
☐ 4235 Flebotomía: vía canalizada. Tipo: _____ ☐ _____ Calibre: _____ Localización: _____ ☐ 7820 Manejo de muestras. Tipo: _____ ☐ 1380 Aplicación de calor o frío ☐ 3900 Regulación de la temperatura ☐ 6610 Identificación de riesgos ☐ 6364 Triaje: centro de urgencias ☐ 7140 Apoyo a la familia ☐ 6650 Vigilancia ☐ 7680 Ayuda a la exploración ☐ 8020 Reunión multidisciplinar de cuidados ☐ 7910 Consulta ☐ 7726 Preceptor: estudiante			
Valoración de Enfermería Percepción-Manejo de la Salud Adherencia al tratamiento: Si ☐ NO ☐ Ingresos hospitalarios previos: Si ☐ NO ☐ Hábitos tóxicos: Si ☐ NO ☐ Nutrición-Metabólico Autónomo ☐ Dependiente ☐ Dieta equilibrada ☐ Disfagia ☐ SING ☐ PEG ☐ Problemas digestivos: _____ Eliminación Normal ☐ Incontinencia ☐ Diarrea ☐ Estreñimiento ☐ Actividad-Ejercicio Activo ☐ Sedentario ☐ Movilidad: Autónomo ☐ Necesita ayuda ☐ Dependiente ☐ Sueño-Descanso Normal ☐ Alterado ☐ Ayudas para dormir ☐ Cognitivo-Perceptivo Consciente: Si ☐ NO ☐ Orientado: Si ☐ NO ☐ Auto percepción-Autoconcepto Conducta: No alterado ☐ Alterado ☐ Rol-Relaciones Mayor Vulnerable ☐ Violencia doméstica ☐ Ayuda domiciliaria ☐ Menor Vulnerable ☐ Sin Hogar ☐ Conducta suicida ☐ Riesgo Social ☐ Síndrome Diógenes ☐ Otros: _____ Sexualidad y reproducción Adaptación tolerancia al estrés Valores y creencias			

Se marcará lo que proceda.

10.8 Bibliografía

1. Procedimiento General de Actuación SVAE. Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de la Región de Murcia. 2022.
2. Guía de Actuación Enfermera de Urgencias y Emergencias prehospitalarias. Emergències mèdiques 061. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. 2015.
3. Guía de Actuación Extrahospitalaria para Soporte Vital Avanzado Enfermero. Ediciones CECOVA. Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana. 2023
4. Pardo, C, Muñoz, T, Chamorro, C. Monitorización del dolor. Recomendaciones del grupo de trabajo de analgesia y sedación de la SEMICYUC. 2006.
5. Guía farmacoterapéutico de medicamentos utilizados por los servicios de urgencias y emergencias sanitarias 061 de la Región de Murcia. Servicio Murciano de Salud. 2014.
6. Manual de protocolos asistenciales. Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias. PAUE. Servicio Andaluz de Salud. 2012
7. Manual y procedimientos de Enfermería SUMMA 112. Comunidad de Madrid. 2012
8. Pastor Pons G. y Pérez Galán J. (2014). Intervención en crisis. Comunicación malas noticias. En Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario de SESCAM.
9. Guía Asistencial Urgencias y Emergencias extrahospitalarias SESCAM. Slaikeu KA. (2000).
10. Intervención en crisis. Manual para práctica e investigación. México: Manual Moderno Fernández JM. (2013).
11. Gestión e intervención psicológica en emergencias y catástrofes. Madrid: Pirámide Organización Mundial de la Salud War Trauma Foundation y Visión Mundial Internacional (2012).
12. Primera ayuda psicológica: Guía para trabajadores de campo. OMS: Ginebra. Pacheco-Tabuenca T. (2012).
13. Atención psicosocial en emergencias. Madrid: Síntesis. Parada Torres E. (2009).
14. Psicología y Emergencia: Habilidades psicológicas en las profesiones de socorro y emergencia. Bilbao: Descleé de Brouwer Muñoz M, Ausín B y Pérez-Santos E (2007).
15. Primeros auxilios psicológicos: protocolo acercarse. Psicología Conductual. 15(3), 479-50.



11. ATENCIÓN AL PACIENTE CON DISNEA

11.1 Definición

Respiración anormal o dificultosa con percepción de mayor trabajo respiratorio que se instaura en un periodo breve de tiempo. Es un síntoma subjetivo que el paciente define como “falta de aire”, y que puede aparecer en reposo, tras actividad física leve o moderada, cambios en el estado de ánimo o tras disfunción de órganos.

11.2 Objetivos

- Disminuir la angustia por la sensación de falta de aire.
- Mejorar la ventilación e intercambio gaseoso.
- Identificar las posibles causas del episodio de la disnea.

11.3 Ámbito de Aplicación

Paciente adulto y pediátrico en contexto extrahospitalario.

11.4 Materiales

- Monitor y parches desfibrilación
- Ampulario
- Mochila de Circulatorio
- Mochila de Respiratorio
- Otro material que precise para la asistencia.

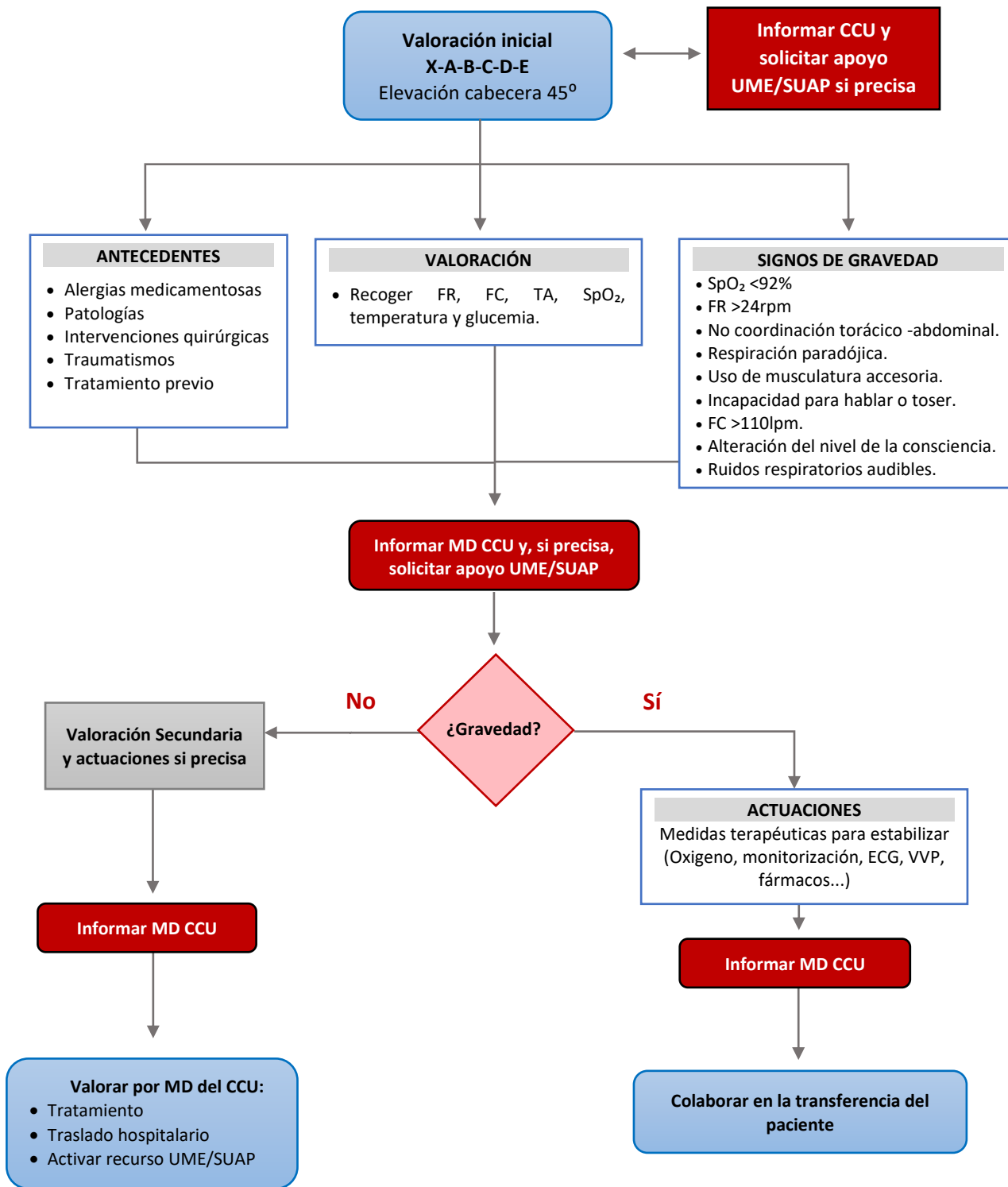
Consultar anexo 1 para la ubicación del material.

11.5 Plan de Actuación

Realizar por un lado, una evaluación primaria orientada a identificar y tratar de manera inmediata cualquier problema que represente un riesgo vital terapéutico (consultar epígrafe 1: Procedimiento General de Actuación SVAE), y por otro, una valoración secundaria que permita el mejor abordaje descrito a continuación:



ATENCIÓN AL PACIENTE CON DISNEA



11.6 Observaciones

Se recomienda tener presente la siguiente información:

La pulsioximetría:

- Es eficaz para saturaciones entre 80% y 100%. Una SpO2 del 90% equivale a oxemia de 60 mmHg
- Es menos fiable si existe anemia grave (Hb<5gr/dl), mala perfusión periférica, luz ambiental intensa (infrarrojos, fluorescentes, xenón), obstáculo a la absorción de la luz (laca uñas, hiperpigmentación de la piel, dishemoglobinemias (carboxiHb)).

La escala para la medida de la disnea. New York Heart Association (NYHA). Más indicada en disnea por insuficiencia cardíaca. Da idea de gravedad.

- Clase I: Sin limitación de la actividad física diaria
- Clase II: Ligera limitación de la actividad física ordinaria
- Clase III: Marcada limitación de la actividad física ordinaria
- Clase IV: Incapacidad para hacer cualquier actividad física, aunque sea mínima, incluso en reposo



11.7 Historia de Cuidados de Enfermería (SVAE)

En la Historia de Cuidados de Enfermería Extrahospitalaria se deben registrar, como mínimo, los siguientes datos:

V. REGISTRO DE ENFERMERÍA		
Etiquetas diagnóstico NANDA	Resultados NOC	Intervenciones NIC
☐ 00257 Sd. Fragilidad del anciano ☐ 00103 Deterioro de la deglución ☐ 00179 Riesgo de nivel de glucemia inestable ☐ 00002 Desequilibrio nutricional: inferior a las necesidades corporales ☐ 00232 Obesidad ☐ 00233 Sobrepeso ☐ 00134 Náuseas	Paciente Frágil ☐ 0802 Signos Vitales ☐ 1912 Caldas ☐ 0208 Movilidad ☐ 2402 Función sensitiva ☐ 1913 Severidad de la lesión física Nutrición ☐ 1010 Estado de deglución ☐ 2300 Nivel de glucemia ☐ 1404 Estado nutricional ☐ 1618 Control de náuseas y vómitos	NIC válidos para varios diagnósticos ☐ 4235 Flebotomía: vía canalizada. Tipo: _____ Calibre: _____ Localización: _____ ☐ 7820 Manejo de muestras. Tipo: _____ ☐ 1380 Aplicación de calor o frío ☐ 3900 Regulación de la temperatura ☐ 6610 Identificación de riesgos ☐ 6364 Triaje: centro de urgencias ☐ 7140 Apoyo a la familia ☐ 6650 Vigilancia ☐ 7680 Ayuda a la exploración ☐ 8020 Reunión multidisciplinar de cuidados ☐ 7910 Consulta ☐ 7726 Preceptor: estudiante
☐ 00016 Deterioro de la eliminación urinaria ☐ 00023 Retención urinaria ☐ 00011 Estreñimiento. ☐ 00013 Diarrea.	Eliminación ☐ 0501 Eliminación intestinal. ☐ 0503 Eliminación urinaria. Respiratorio ☐ 0415 Estado respiratorio	☐ 0590 Manejo de la eliminación urinaria ☐ 0580 Sondaje Vesical Calibre: _____ Débito: _____ ☐ 0620 Cuidados de la retención urinaria ☐ 1876 Cuidados del catéter urinario ☐ 0430 Control intestinal ☐ 3160 Aspiración de las vías aéreas ☐ 3320 Oxigenoterapia. FIO ₂ : _____ lts/min: _____ Tipo: _____ ☐ 3302 Manejo de la ventilación mecánica: no invasiva. Modo: _____ FIO ₂ : _____ PEEP: _____ Trigger: _____ Frec. Resp: _____
☐ 00030 Deterioro del intercambio de gases ☐ 00032 Patrón respiratorio ineficaz ☐ 00031 Limpieza ineficaz de vía aérea. ☐ 00039 Riesgo de aspiración.	Circulatorio ☐ 0400 Efectividad de la bomba cardíaca. ☐ 0401 Estado circulatorio ☐ 2301 Respuesta a la medicación	☐ 4250 Manejo del shock. ☐ 4040 Cuidados cardíacos: ☐ ECG ☐ Monitor ☐ Cardioversión ☐ Desfibrilador Julios: _____ Choques: _____ ☐ 4162 Manejo de la hipertensión ☐ 4175 Manejo de la hipotensión ☐ 4092 Manejo del marcapasos: temporal Frec: _____ mVoltios: _____
☐ 00029 Disminución del gasto cardíaco ☐ 00267 Riesgo de tensión arterial inestable	Psicológico/Neurológico ☐ 0902 Comunicación ☐ 0909 Estado neurológico ☐ 1214 Nivel de agitación ☐ 1211 Nivel de ansiedad	☐ 2620 Monitorización neurológica. ☐ 5270 Apoyo emocional. ☐ 4929 Escucha activa
☐ 00051 Deterioro de la comunicación verbal ☐ 00128 Confusión aguda. ☐ 00129 Confusión crónica. ☐ 00146 Ansiedad.	Traslado ☐ 0210 Realización de transferencia ☐ 1311 Adaptación al traslado	☐ 8100 Derivación ☐ 7890 Transporte entre instalaciones ☐ 7710 Colaboración con el médico ☐ 7960 Intercambio de información de cuidados de salud
☐ 00004 Riesgo de infección ☐ 00206 Riesgo de sangrado ☐ 00038 Riesgo de traumatismo físico ☐ 00312 Lesión por presión en el adulto ☐ 00044 Deterioro de la integridad tisular ☐ 00303 Riesgos de caídas en el adulto	Musculoesquelético ☐ 1101 Integridad tisular: piel	☐ 4020 Disminución de la Hemorragia ☐ Tomiquete. Hora: _____ ☐ Compresión ☐ 3660 Cuidados de la herida. ☐ 3620 Sutura ☐ 6610 Identificación de riesgos
☐ 00132 Dolor agudo ☐ 00133 Dolor crónico	Dolor ☐ 1605 Control del dolor	☐ 2300 Administración de Medicación. ☐ 1410 Manejo del dolor: agudo ☐ 1415 Manejo del dolor: crónico
☐ 00020 Riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca ☐ 00033 Deterioro de la ventilación espontánea	PCR ☐ 0414 Estado cardiopulmonar	☐ 6200 Cuidados de la emergencia ☐ 6140 Manejo de la parada cardiopulmonar ☐ 6320 Reanimación ☐ 4095 Manejo del desfibrilador ☐ 3140 Manejo de la vía aérea. Tipo: _____

Se marcará lo que proceda.



11.8 Bibliografía

1. Procedimiento General de Actuación SVAE. Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de la Región de Murcia. 2022.
2. Guía de Actuación Enfermera de Urgencias y Emergencias prehospitalarias. Emergències mèdiques 061. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. 2015.
3. Guía de Actuación Extrahospitalaria para Soporte Vital Avanzado Enfermero. Ediciones CECOVA. Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana. 2023
4. Pardo, C, Muñoz, T, Chamorro, C. Monitorización del dolor. Recomendaciones del grupo de trabajo de analgesia y sedación de la SEMICYUC. 2006.
5. Guía farmacoterapéutico de medicamentos utilizados por los servicios de urgencias y emergencias sanitarias 061 de la Región de Murcia. Servicio Murciano de Salud. 2014.
6. Manual de protocolos asistenciales. Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias. PAUE. Servicio Andaluz de Salud. 2012
7. Manual y procedimientos de Enfermería SUMMA 112. Comunidad de Madrid. 2012
8. Casas Benavent, V, Iniesta Roser, R. Procesos asistenciales SVA Enfermería. Servicio de Emergencias Sanitarias. Generalitat Valenciana. 2021.



12. ATENCIÓN AL PACIENTE INTOXICADO

12.1 Definición

La intoxicación es un síndrome clínico que se desarrolla como resultado de la introducción de una sustancia tóxica en el organismo, ya sea de forma intencionada o accidental. Dependiendo de la fuente del tóxico, que puede ser farmacológica, ambiental, alimentaria, animal, ..., el cuadro clínico varía y, por lo tanto, requiere un tratamiento específico.

12.2 Objetivos

- Controlar el estado hemodinámico
- Identificar la sustancia tóxica e impedir la continuidad de la absorción.
- Controlar los efectos de la sustancia nociva.

12.3 Ámbito de Aplicación

Pacientes con intoxicación que precisan atención en el contexto extrahospitalario.

12.4 Materiales

- Monitor y parches desfibrilación
- Ampulario
- Mochila de Circulatorio
- Mochila de Respiratorio
- Otro material que precise para la asistencia.

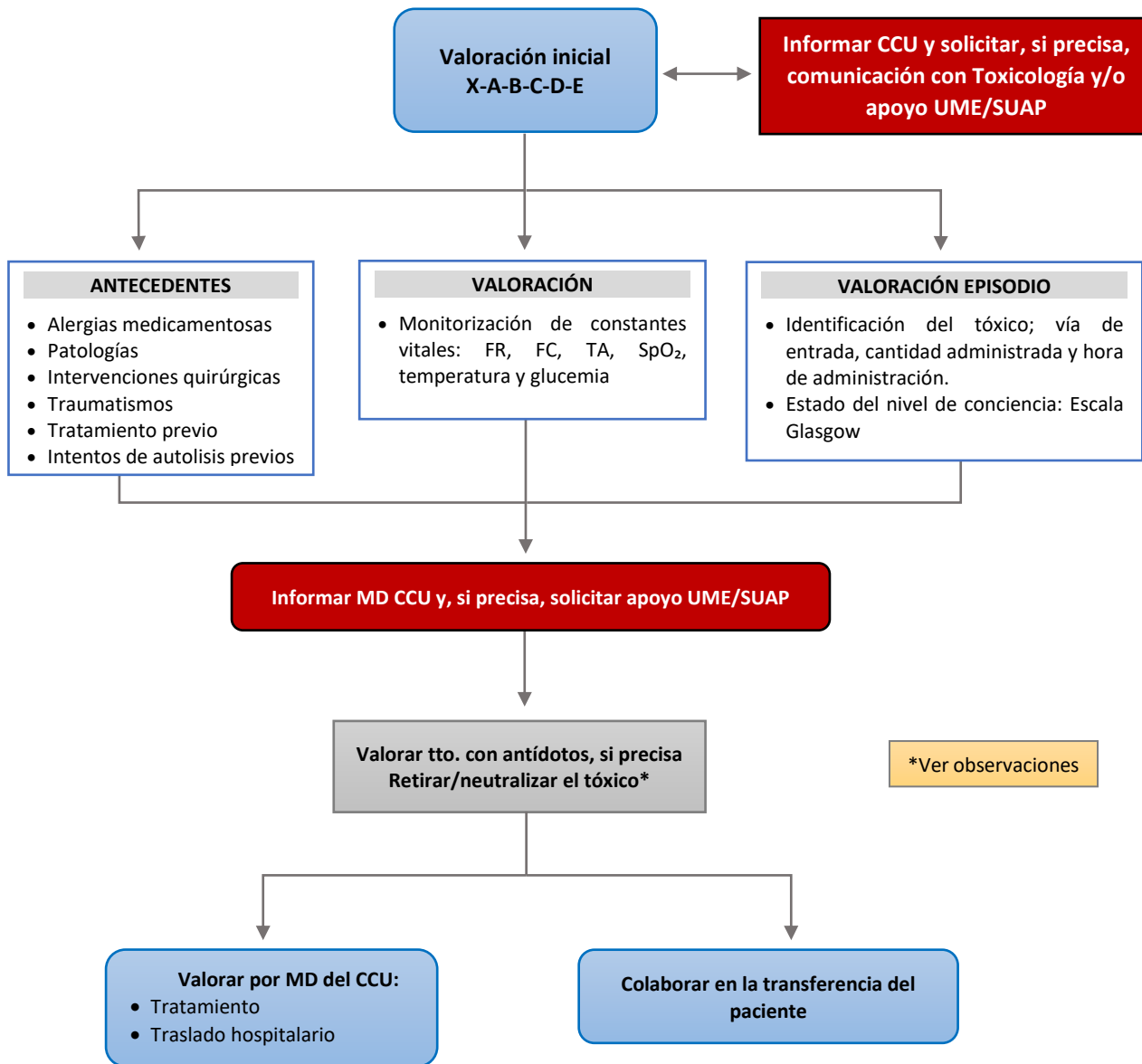
Consultar anexo 1 para la ubicación del material.

12.5 Plan de Actuación

Realizar por un lado, una evaluación primaria orientada a identificar y tratar de manera inmediata cualquier problema que represente un riesgo vital terapéutico (consultar epígrafe 1: Procedimiento General de Actuación SVAE), y por otro, una valoración secundaria que permita el mejor abordaje descrito a continuación:



ATENCIÓN AL PACIENTE INTOXICADO



12.6 Observaciones

Administración de fármacos (MD) si coma de origen desconocido:

- Naloxona
- Flumazenilo (no si hay posibilidad de convulsiones)
- Glucosmón hasta descartar hipoglucemia

Algunos antidotos específicos para los distintos tóxicos más frecuentes:

TÓXICO	ANTÍDOTO
Insecticidas con acción anticolinesterasa (organofosforados y carbamatos)	Atropina
Benzodiacepinas, coma de origen desconocido	Flumazenilo
Betabloqueantes y antagonistas del calcio	Glucagón
Ácido oxálico y antagonistas del calcio	Gluconato cálcico
Hipoglucemiantes orales e insulina, coma de origen desconocido	Glucosa
Opiáceos, coma de origen desconocido	Naloxona
Monóxido de carbono y otros gases	Oxígeno
Alcohol etílico	Tiamina
Cianuro	(Cianokit) Vitamina B12 (UME)

Para la disminución de la absorción del toxico*.

- Vía parenteral: frío local
- Vía inhalatoria: aislar del tóxico y oxigenación al 50-100%
- Vía conjuntival: lavado ocular con SSF mínimo 10 minutos.
- Vía cutánea: lavado con agua y retirar ropa contaminada.
- Vía digestiva: Los antieméticos no están aconsejados, valorar lavado gástrico. El uso del carbón activado está indicado en las 2 primeras horas tras la ingesta del tóxico.

Principales contraindicaciones:

Lavado y aspirado gástrico
Intoxicaciones leves
Ingesta de cáusticos y sustancias corrosivas en general
Estenosis esofágica
No sobrepasar los tres litros
Carbón activado
Intoxicaciones muy leves
Sustancias no absorbibles
Ingesta de cáusticos y sustancias corrosivas en general
Existencia de situación de abdomen agudo
Sospecha de posible perforación del tracto digestivo
Obstrucción conocida del tracto digestiva: neoplasias, etc.

*Guía de actuación enfermera de urgencias y emergencias prehospitalarias. Emergencias médicas 061. Generalitat de Catalunya. Departamento de Salut. 2015



12.7 Historia de Cuidados de Enfermería (SVAE)

V. REGISTRO DE ENFERMERÍA			
Etiquetas diagnóstico NANDA	Resultados NOC		Intervenciones NIC
☐ 00257 Sd. Fragilidad del anciano ☐ 00103 Deterioro de la deglución ☐ 00179 Riesgo de nivel de glucemia inestable ☐ 00002 Desequilibrio nutricional: inferior a las necesidades corporales ☐ 00232 Obesidad ☐ 00233 Sobrepeso ☐ 00134 Náuseas	Paciente Frágil ☐ 0802 Signos Vitales ☐ 1912 Caídas ☐ 0208 Movilidad ☐ 2402 Función sensitiva ☐ 1913 Severidad de la lesión física	☐ 6680 Monitorización de los signos vitales ☐ 4420 Acuerdo con el paciente ☐ 5510 Educación para la salud ☐ 7170 Facilitar la presencia de la familia	NIC válidos para varios diagnósticos ☐ 4235 Flebotomía: vía canalizada. Tipo: _____ Calibre: _____ Localización: _____ ☐ 7820 Manejo de muestras. Tipo: _____ ☐ 1380 Aplicación de calor o frío ☐ 3900 Regulación de la temperatura ☐ 6610 Identificación de riesgos ☐ 6364 Triaje: centro de urgencias ☐ 7140 Apoyo a la familia ☐ 6650 Vigilancia ☐ 7680 Ayuda a la exploración ☐ 8020 Reunión multidisciplinar de cuidados ☐ 7910 Consulta ☐ 7726 Preceptor: estudiante
☐ 00103 Deterioro de la deglución ☐ 00179 Riesgo de nivel de glucemia inestable ☐ 00002 Desequilibrio nutricional: inferior a las necesidades corporales ☐ 00232 Obesidad ☐ 00233 Sobrepeso ☐ 00134 Náuseas	☐ 1010 Estado de deglución ☐ 2300 Nivel de glucemia ☐ 1404 Estado nutricional ☐ 1618 Control de náuseas y vómitos	☐ 1080 Sondaje nasogástrico. Calibre: _____ ☐ 4035 Muestra de sangre capilar ☐ 2120 Manejo de la hiperglucemia ☐ 2130 Manejo de la hipoglucemia ☐ 1100 Manejo de la nutrición ☐ 1570 Manejo del vómito	Valoración de Enfermería Percepción-Manejo de la Salud Adherencia al tratamiento: Si ☐ NO ☐ Ingresos hospitalarios previos: Si ☐ NO ☐ Hábitos tóxicos: Si ☐ NO ☐ Nutrición-Metabólico Autónomo ☐ Dependiente ☐ Dieta equilibrada ☐ Disfagia ☐ SNG ☐ PEG ☐ Problemas digestivos: _____ Eliminación Normal ☐ Incontinencia ☐ Diarrea ☐ Estreñimiento ☐ Actividad-Ejercicio Activo ☐ Sedentario ☐ Movilidad: Autónomo ☐ Necesita ayuda ☐ Dependiente ☐ Sueño-Descanso Normal ☐ Alterado ☐ Ayudas para dormir ☐ Cognitivo-Perceptivo Consciente: Si ☐ NO ☐ Orientado: Si ☐ NO ☐ Autopercepción-Autoconcepto Conducta: No alterado ☐ Alterado ☐ Rol-Relaciones Mayor Vulnerable ☐ Violencia doméstica ☐ Ayuda domiciliaria ☐ Menor Vulnerable ☐ Sin Hogar ☐ Conducta suicida ☐ Riesgo Social ☐ Síndrome Diógenes ☐ Otros: _____ Sexualidad y reproducción Adaptación tolerancia al estrés Valores y creencias
☐ 00016 Deterioro de la eliminación urinaria ☐ 00023 Retención urinaria ☐ 00011 Estreñimiento. ☐ 00013 Diarrea.	☐ 0501 Eliminación intestinal. ☐ 0503 Eliminación urinaria.	☐ 0590 Manejo de la eliminación urinaria ☐ 0580 Sondaje Vesical Calibre: _____ Débito: _____ ☐ 0620 Cuidados de la retención urinaria ☐ 1876 Cuidados del catéter urinario ☐ 0430 Control intestinal	
☐ 00030 Deterioro del intercambio de gases ☐ 00032 Patrón respiratorio ineficaz ☐ 00031 Limpieza ineficaz de vía aérea. ☐ 00039 Riesgo de aspiración.	☐ 0415 Estado respiratorio	☐ 3160 Aspiración de las vías aéreas ☐ 3320 Oxigenoterapia. FIO ₂ : _____ lts/min: Tipo: _____ ☐ 3302 Manejo de la ventilación mecánica: no invasiva. Modo: _____ FIO ₂ : _____ PEEP: _____ Trigger: _____ Frec. Resp: _____	
☐ 00029 Disminución del gasto cardíaco ☐ 00267 Riesgo de tensión arterial inestable	☐ 0400 Efectividad de la bomba cardíaca. ☐ 0401 Estado circulatorio ☐ 2301 Respuesta a la medicación	☐ 4250 Manejo del shock. ☐ 4040 Cuidados cardíacos. ☐ ECG ☐ Monit. ☐ Cardioversión ☐ Desfibrilador Julios: _____ Choques: _____ ☐ 4162 Manejo de la hipertensión ☐ 4175 Manejo de la hipotensión ☐ 4092 Manejo del marcapasos: temporal Frec: _____ mVotios: _____	
☐ 00051 Deterioro de la comunicación verbal ☐ 00128 Confusión aguda. ☐ 00129 Confusión crónica. ☐ 00146 Ansiedad.	☐ 0902 Comunicación ☐ 0909 Estado neurológico ☐ 1214 Nivel de agitación ☐ 1211 Nivel de ansiedad	☐ 2620 Monitorización neurológica. ☐ 5270 Apoyo emocional. ☐ 4929 Escucha activa	
☐ 00114 Síndrome de estrés del traslado	☐ 0210 Realización de transferencia ☐ 1311 Adaptación al traslado	☐ 8100 Derivación ☐ 7890 Transporte entre instalaciones ☐ 7710 Colaboración con el médico ☐ 7960 Intercambio de información de cuidados de salud	
☐ 00004 Riesgo de infección ☐ 00206 Riesgo de sangrado ☐ 00038 Riesgo de traumatismo físico ☐ 00312 Lesión por presión en el adulto ☐ 00044 Deterioro de la integridad tisular ☐ 00303 Riesgos de caídas en el adulto	☐ 1101 Integridad tisular: piel	☐ 4020 Disminución de la Hemorragia ☐ Torniquete. Hora: _____ ☐ Compresión ☐ 3660 Cuidados de la herida. ☐ 3620 Sutura ☐ 6610 Identificación de riesgos	
☐ 00132 Dolor agudo ☐ 00133 Dolor crónico	☐ 1605 Control del dolor	☐ 2300 Administración de Medicación. ☐ 1410 Manejo del dolor: agudo ☐ 1415 Manejo del dolor: crónico	
☐ 00020 Riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca ☐ 00033 Deterioro de la ventilación espontánea	☐ 0414 Estado cardiopulmonar	☐ 6200 Cuidados de la emergencia ☐ 6140 Manejo de la parada cardiopulmonar ☐ 6320 Reanimación ☐ 4095 Manejo del desfibrilador ☐ 3140 Manejo de la vía aérea. Tipo: _____	

Se marcará lo que proceda.



12.8 Bibliografía

1. Procedimiento General de Actuación SVAE. Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de la Región de Murcia. 2022.
2. Guía de Actuación Enfermera de Urgencias y Emergencias prehospitalarias. Emergències mèdiques 061. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. 2015.
3. Guía de Actuación Extrahospitalaria para Soporte Vital Avanzado Enfermero. Ediciones CECOVA. Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana. 2023
4. Pardo, C, Muñoz, T, Chamorro, C. Monitorización del dolor. Recomendaciones del grupo de trabajo de analgesia y sedación de la SEMICYUC. 2006.
5. Guía farmacoterapéutica de medicamentos utilizados por los servicios de urgencias y emergencias sanitarias 061 de la Región de Murcia. Servicio Murciano de Salud. 2014.
6. Manual de protocolos asistenciales. Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias. PAUE. Servicio Andaluz de Salud. 2012
7. Manual y procedimientos de Enfermería SUMMA 112. Comunidad de Madrid. 2012.
8. Casas Benavent, V, Iniesta Roser, R. Procesos asistenciales SVA Enfermería. Servicio de Emergencias Sanitarias. Generalitat Valenciana. 2021.



13. ATENCIÓN AL PACIENTE QUEMADO

13.1 Definición

Una quemadura es una lesión en la piel o en otros tejidos del cuerpo, ocasionada principalmente por calor, radiación, radiación ionizante, electricidad, fricción o el contacto con sustancias químicas.

13.2 Objetivos

- Realización de evaluación precoz e identificación de lesiones que puedan comprometer la vida del paciente.
- Valoración de las quemaduras: localización, extensión y profundidad.
- Control del dolor.

13.3 Ámbito de Aplicación

Paciente adulto y pediátrico con quemaduras de diversa etiología y gravedad, en contexto extrahospitalario

13.4 Materiales

- Monitor y parches desfibrilación
- Ampulario
- Mochila de Circulatorio
- Mochila de Respiratorio
- Otro material que precise para la asistencia.

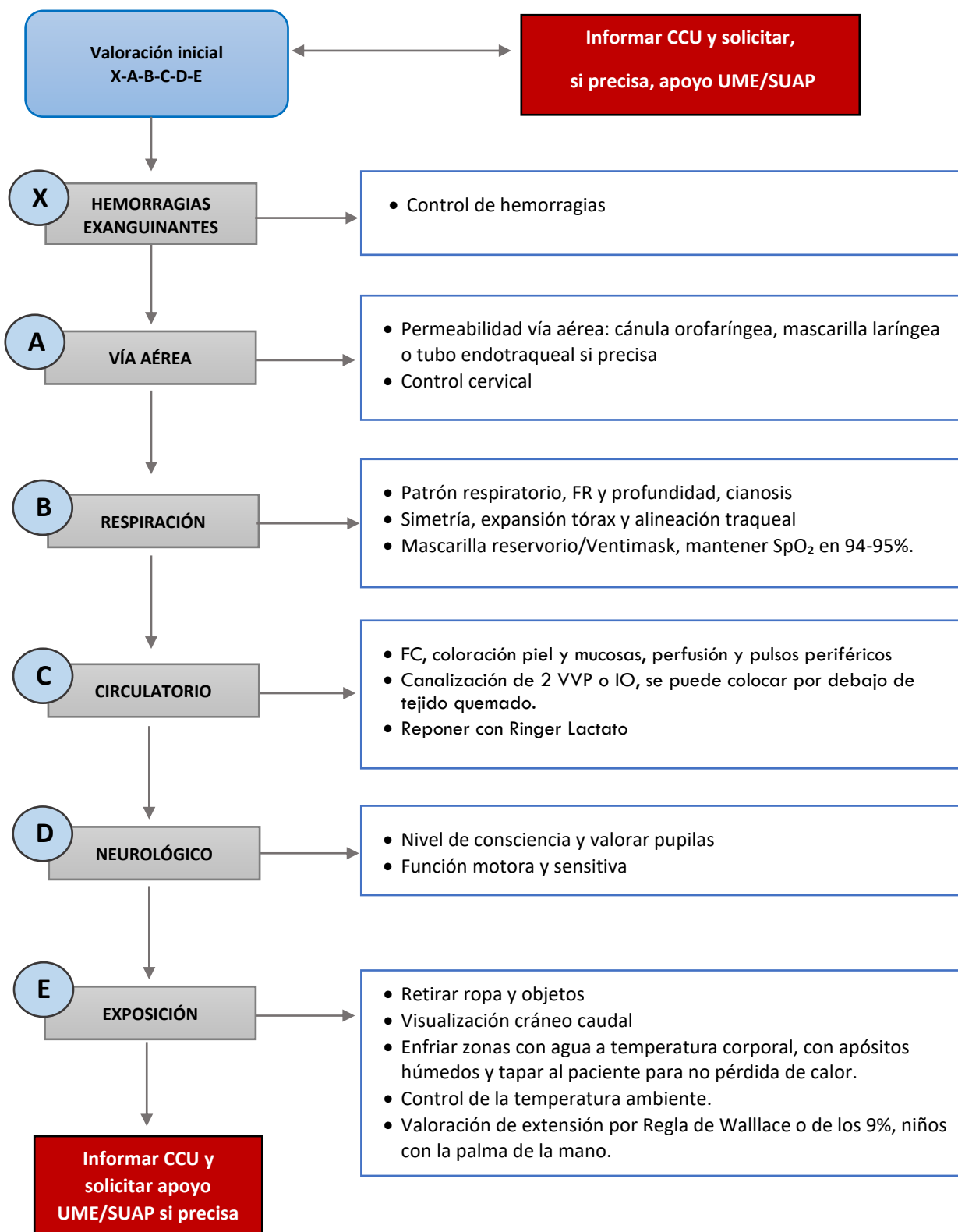
Consultar anexo 1 para la ubicación del material.

13.5 Plan de Actuación

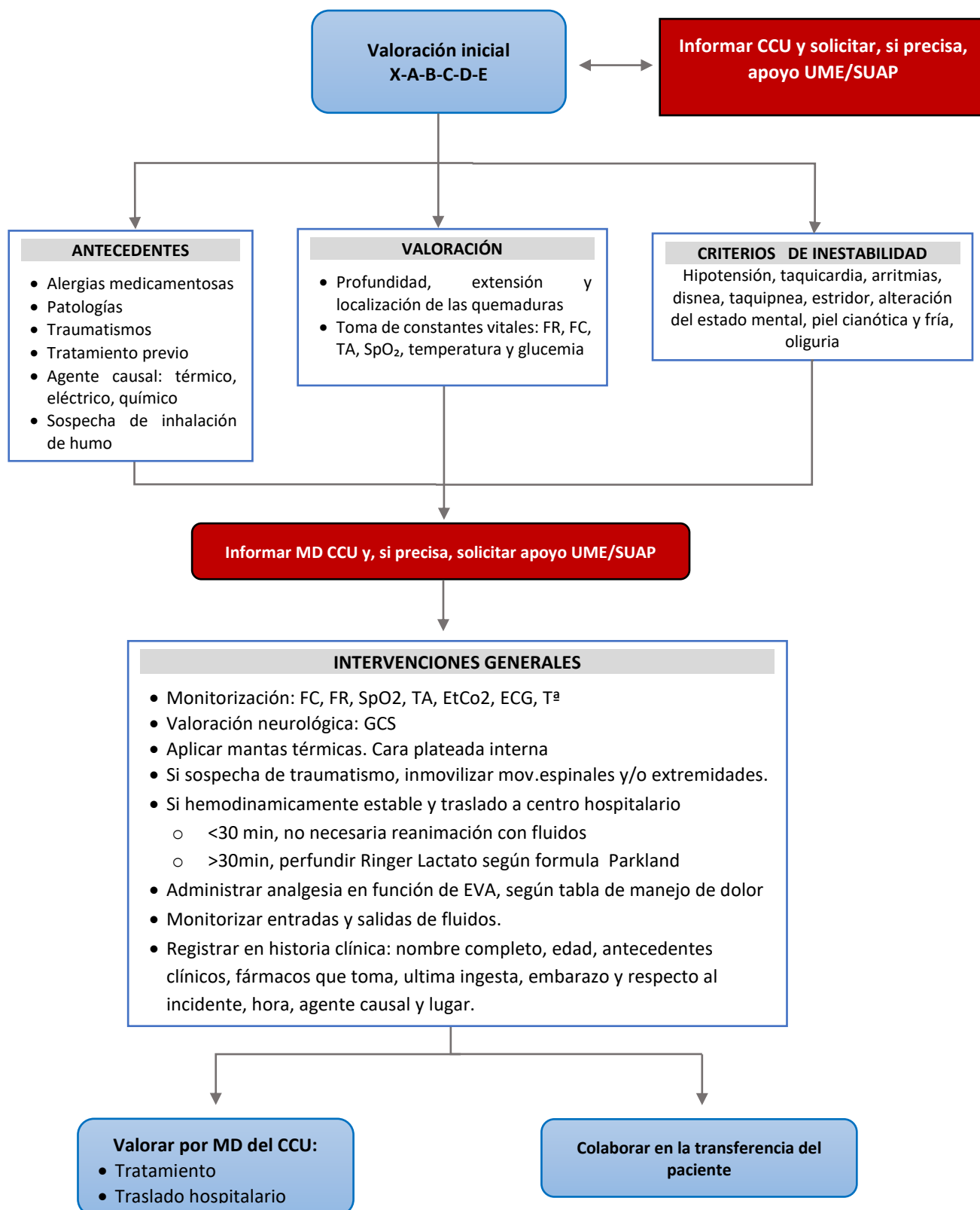
Realizar por un lado, una evaluación primaria orientada a identificar y tratar de manera inmediata cualquier problema que represente un riesgo vital terapéutico (consultar epígrafe 1: Procedimiento General de Actuación SVAE), y por otro, una valoración secundaria que permita el mejor abordaje descrito a continuación:



ATENCIÓN AL PACIENTE QUEMADO. VALORACIÓN PRIMARIA



ATENCIÓN AL PACIENTE QUEMADO



13.6 Observaciones

Se recomienda tener presente la siguiente información:

Formula de Parkland: Su propósito es determinar el volumen de líquido a infundir, su cálculo se obtiene de la siguiente manera: En 24h: Ringer Lactato 4 ml x Kg x % de Superficie Corporal Quemada (SCQ) en adulto, la mitad en las primeras 8 horas y el resto en las siguientes 16 horas.

Tabla del manejo del dolor, en función de resultados en escala EVA.

>4 dolor leve o leve/moderado
Medidas analgésicas y de confort
Paracetamol
Metamizol
4-6 dolor moderado grave
Ketorolaco
Tramadol
>6 dolor muy intenso
Fentanilo
Cloruro mórfico
Meperidina
Valorar la administración de metoclopramida u ondansetrón, éste último, para niños <30Kg y personas de edad avanzada con riesgo de discinesia tardía.

Consultar anexo 2. Fichas de Guía Farmacológica del 061.

En intoxicación por humo:

- Administrar O₂ con mascarilla reservorio.
- Aislamiento de vía aérea
- Administración fármacos:
- Disminución del nivel de consciencia
- Inestabilidad hemodinámica
- PCR



En quemaduras eléctricas:

- Inmovilizar si sospecha de lesión medular.
- Buscar puntos de entrada y salida de la corriente, estimando el recorrido y la posible afectación de órganos.

En quemaduras químicas:

- Irrigación de quemaduras con agua, si el agente químico es en polvo, primero cepillar.
- El litio y el sodio metálico reaccionan con el agua, liberando calor y gases tóxicos.
- Las lesiones en los ojos hay que irrigarlas constantemente.
- Explorar boca y faringe, en caso de quemaduras, aislar vía aérea.
- Si ingesta de productos cáusticos, no realizar lavado gástrico ni administración de carbón activado.

En quemaduras en cara y cuello:

- Administrar O₂ humidificado en altas concentraciones, paciente semisentado para disminuir edema por gravedad.
- Aislamiento de vía aérea

En paciente gran quemado:

>15% de superficie con quemaduras de 2º o 3º grado en adultos, 10% en edades extremas.

- Si hay afectación de cuello, cara, resto de hollín en narinas, esputo con carbonilla o quemadura inhalatoria, aislar vía aérea.
- Si quemaduras circunferenciales, que impidan la expansión del tórax, hacer escarotomía.
- Reponer volemia tras prescripción MD.
- Tratamiento dolor según escala dolor EVA y pauta MD.
- Evitar la Hipotermia. En quemaduras extensas, cubrir con apósito de hidrogel la herida y cubrir con mantas al paciente. En extremidades con quemaduras circunferenciales, si aparece el efecto torniquete, hacer escarotomía.



13.7 Historia de Cuidados de Enfermería (SVAE)

En la Historia de Cuidados de Enfermería Extrahospitalaria se deben registrar, como mínimo, los siguientes datos

V. REGISTRO DE ENFERMERÍA		
Etiquetas diagnóstico NANDA	Resultados NOC	Intervenciones NIC
Paciente Frágil ☐ 00257 Sd. Fragilidad del anciano ☐ 0802 Signos Vitales ☐ 1912 Caídas ☐ 0208 Movilidad ☐ 2402 Función sensitiva ☐ 1913 Severidad de la lesión física		
Nutrición ☐ 00103 Deterioro de la deglución ☐ 00179 Riesgo de nivel de glucemia inestable ☐ 00002 Desequilibrio nutricional: inferior a las necesidades corporales ☐ 00232 Obesidad ☐ 00233 Sobre peso ☐ 00134 Náuseas ☐ 1010 Estado de deglución ☐ 2300 Nivel de glucemia ☐ 1404 Estado nutricional ☐ 1618 Control de náuseas y vómitos		
Eliminación ☐ 00016 Deterioro de la eliminación urinaria ☐ 00023 Retención urinaria ☐ 00011 Estreñimiento. ☐ 00013 Diarrea. ☐ 0501 Eliminación intestinal. ☐ 0503 Eliminación urinaria.		
Respiratorio ☐ 00030 Deterioro del intercambio de gases ☐ 00032 Patrón respiratorio ineficaz ☐ 00031 Limpieza ineficaz de vía aérea. ☐ 00039 Riesgo de aspiración. ☐ 0415 Estado respiratorio		
Circulatorio ☐ 00029 Disminución del gasto cardíaco ☐ 00267 Riesgo de tensión arterial inestable ☐ 0400 Efectividad de la bomba cardíaca. ☐ 0401 Estado circulatorio ☐ 2301 Respuesta a la medicación		
Psicológico/Neurológico ☐ 00051 Deterioro de la comunicación verbal ☐ 00128 Confusión aguda. ☐ 00129 Confusión crónica. ☐ 00146 Ansiedad. ☐ 0902 Comunicación ☐ 0909 Estado neurológico ☐ 1214 Nivel de agitación ☐ 1211 Nivel de ansiedad		
Transferencia ☐ 00114 Síndrome de estrés del traslado ☐ 0210 Realización de transferencia ☐ 1311 Adaptación al traslado		
Musculoesquelético ☐ 00004 Riesgo de infección ☐ 00206 Riesgo de sangrado ☐ 00038 Riesgo de traumatismo físico ☐ 00312 Lesión por presión en el adulto ☐ 00044 Deterioro de la integridad tisular ☐ 00303 Riesgos de caídas en el adulto ☐ 1101 Integridad tisular: piel		
Dolor ☐ 00132 Dolor agudo ☐ 00133 Dolor crónico ☐ 1605 Control del dolor		
PCR ☐ 00020 Riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca ☐ 00033 Deterioro de la ventilación espontánea ☐ 0414 Estado cardiopulmonar		
Intervenciones NIC NIC. Valioso para varios diagnósticos ☐ 4235 Flebotomía: vía canalizada. Tipo: _____ Calibre: _____ Localización: _____ ☐ 7820 Manejo de muestras. Tipo: _____ ☐ 1380 Aplicación de calor o frío ☐ 3900 Regulación de la temperatura ☐ 6610 Identificación de riesgos ☐ 6364 Triage: centro de urgencias ☐ 7140 Apoyo a la familia ☐ 6650 Vigilancia ☐ 7680 Ayuda a la exploración ☐ 8020 Reunión multidisciplinar de cuidados ☐ 7910 Consulta ☐ 7726 Preceptor: estudiante		
Valoración de Enfermería Percepción-Manejo de la Salud Adherencia al tratamiento: Si ☐ NO ☐ Ingresos hospitalarios previos: Si ☐ NO ☐ Hábitos tóxicos: Si ☐ NO ☐ Nutrición-Metabólico Autónomo ☐ Dependiente ☐ Dieta equilibrada ☐ Disfagia ☐ SNG ☐ PEG ☐ Problemas digestivos: _____ Eliminación Normal ☐ Incontinencia ☐ Diarrea ☐ Estreñimiento ☐ Actividad-Ejercicio Activo ☐ Sedentario ☐ Movilidad: Autónomo ☐ Necesita ayuda ☐ Dependiente ☐ Sueño-Descanso Normal ☐ Alterado ☐ Ayudas para dormir ☐ Cognitivo-Perceptivo Consciente: Si ☐ NO ☐ Orientado: Si ☐ NO ☐ Autopercepción-Autoconcepto Conducta: No alterado ☐ Alterado ☐ Rol-Relaciones Mayor Vulnerable ☐ Violencia doméstica ☐ Ayuda domiciliaria ☐ Menor Vulnerable ☐ Sin Hogar ☐ Conducta suicida ☐ Riesgo Social ☐ Síndrome Diógenes ☐ Otros: _____ Sexualidad y reproducción Adaptación tolerancia al estrés Valores y creencias		

Se marcará lo que proceda



13.8 Bibliografía

1. Procedimiento General de Actuación SVAE. Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de la Región de Murcia. 2022.
2. Guía de Actuación Enfermera de Urgencias y Emergencias prehospitalarias. Emergències mèdiques 061. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. 2015.
3. Guía de Actuación Extrahospitalaria para Soporte Vital Avanzado Enfermero. Ediciones CECOVA. Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana. 2023
4. Pardo, C, Muñoz, T, Chamorro, C. Monitorización del dolor. Recomendaciones del grupo de trabajo de analgesia y sedación de la SEMICYUC. 2006.
5. Guía farmacoterapéutica de medicamentos utilizados por los servicios de urgencias y emergencias sanitarias 061 de la Región de Murcia. Servicio Murciano de Salud. 2014.
6. Manual de protocolos asistenciales. Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias. PAUE. Servicio Andaluz de Salud. 2012
7. Manual y procedimientos de Enfermería SUMMA 112. Comunidad de Madrid. 2012.
8. Casas Benavent, V, Iniesta Roser, R. Procesos asistenciales SVA Enfermería. Servicio de Emergencias Sanitarias. Generalitat Valenciana. 2021.



14. PROCEDIMIENTO TOMA DE MUESTRAS EN COVID-19 POR UNIDADES SVAE.

14.1 Definición

Todas las actividades realizadas para la recogida de muestras y/o realización de pruebas rápidas, que determinen el diagnóstico de COVID, así como su secuenciación a petición de Salud Pública.

14.2 Objetivos

- Determinar si hay una infección por COVID
- Poder limitar la expansión de la infección si la hubiese.
- Poder secuenciar el agente infeccioso.

14.3 Ámbito de Aplicación

El lugar de actuación puede ser:

- Residencias, centros sanitarios, etc.
- Domicilios
- Otros por determinar

Destino será valorado por CCU, in situ, otra unidad, Hospital de referencia o el más Cercano, u otros.

14.4 Materiales

- 2 hojas de datos del paciente, facilitados por CCU, una copia para el laboratorio y otro para archivar.
- Hisopo para la toma de la muestra.
- Depresor lingual para tomo de muestra orofaríngea.
- Pegatinas de códigos de laboratorio.
- Triple embalaje para el transporte de la muestra.
- EPI +bata higiénica si hay varias muestras distintas que tomar.
- Par de guantes por toma
- Mascarilla quirúrgica para el paciente.
- Bolsas para la retirada del EPI, así como el desinfectante.



14.5 Plan de Actuación

PCR EN DOMICILIO:

Tras la llamada del CCU para dar los datos del paciente, se rellena la hoja de datos para el laboratorio con el nombre, DNI, y fecha de nacimiento. Se codifica esta hoja al igual que el tubo donde se introduce el hisopo, así como también los embalajes interior e exterior donde se deposita la muestra. Después la unidad de toma de muestras se dirige al domicilio.

Se procede a la colocación del EPI antes de entrar en el domicilio y sólo entra la enfermera, permaneciendo el técnico fuera de la puerta de entrada.

La enfermera realiza la toma de muestra del tracto respiratorio superior; frotis nasofaríngeo en las dos narinas, lugar de preferencia por detectar mayor carga viral y/o orofaríngeo según nivel de colaboración del paciente.

En el exterior del domicilio, el técnico espera con el triple embalaje para recepcionar la muestra y posteriormente cierra adecuadamente dicho embalaje. Al finalizar el proceso se procede a la retirada del EPI.

Inicialmente las muestras son llevadas al laboratorio de virología del Hospital que nos indique la Enfermera de Enlace del CCU. Allí se entrega el embalaje con las muestras, la hoja de datos del paciente y finalmente se cierra el aviso a través de una llamada al CCU.

PCR EN RESIDENCIAS O CENTROS SANITARIOS

Tras la llamada del CCU para dar los datos del/los paciente/s, se rellena la hoja de datos para el laboratorio con el nombre, DNI, fecha de nacimiento y nombre y municipio de la residencia de mayores. Se codifica esta hoja al igual que el tubo donde se introduce el hisopo. Después la unidad de toma de muestras se dirige al emplazamiento.

El EPI se coloca antes de entrar en la residencia. Solo entra la enfermera, permaneciendo el técnico fuera de la puerta de entrada al edificio de la residencia por donde saldrá la enfermera, si son pocas las pruebas a realizar.

Usaremos encima del EPI una bata higiénica y unos 3º guantes para cada usuario, que retiraremos después de cada toma muestra a la salida de la habitación del usuario, y pondremos otra bata higiénica y par de 3º guantes para el siguiente.

La enfermera realiza la toma de muestra del tracto respiratorio superior; frotis nasofaríngeo, siendo éste el lugar de preferencia por detectar mayor carga viral, y/o orofaríngeo.

En la parte de fuera de la residencia/ habitación el técnico espera con el triple embalaje para recepcionar la muestra y cerrar adecuadamente dicho embalaje. Al finalizar el proceso de toma y depósito de muestra/as, se procede a la retirada del EPI.

Las muestras son llevadas al Laboratorio de virología del Hospital que nos indique la Enfermera de enlace del CCU.

Una vez entregado el embalaje con la muestra/as, así como la hoja de datos del paciente, todo debidamente codificado, el aviso es cerrado a través del CCU.



14.6 Observaciones

Si por el estado de salud del paciente, precisase asistencia sanitaria, realizaríamos la evaluación inicial como el resto de los pacientes.



13.7 Historia de Cuidados de Enfermería (SVAE)

En la Historia de Cuidados de Enfermería Extrahospitalaria se deben registrar, como mínimo, los siguientes datos

V. REGISTRO DE ENFERMERÍA			
Etiquetas diagnóstico NANDA	Resultados NOC	Intervenciones NIC	
☐ 00257 Sd. Fragilidad del anciano	☐ 0802 Signos Vitales ☐ 1912 Caídas ☐ 0208 Movilidad ☐ 2402 Función sensitiva ☐ 1913 Severidad de la lesión física	☐ 6680 Monitorización de los signos vitales ☐ 4420 Acuerdo con el paciente ☐ 5510 Educación para la salud ☐ 7170 Facilitar la presencia de la familia	☐ 4235 Flebotomía: vía canalizada. Tipo: _____ Calibre: _____ Localización: _____ ☐ 7820 Manejo de muestras. Tipo: _____ ☐ 1380 Aplicación de calor o frío ☐ 3900 Regulación de la temperatura ☐ 6610 Identificación de riesgos ☐ 6364 Triaje: centro de urgencias ☐ 7140 Apoyo a la familia ☐ 6650 Vigilancia ☐ 7680 Ayuda a la exploración ☐ 8020 Reunión multidisciplinar de cuidados ☐ 7910 Consulta ☐ 7726 Preceptor: estudiante
☐ 00103 Deterioro de la deglución ☐ 00179 Riesgo de nivel de glucemia inestable ☐ 00002 Desequilibrio nutricional: inferior a las necesidades corporales ☐ 00232 Obesidad ☐ 00233 Sobre peso ☐ 00134 Náuseas	☐ 1010 Estado de deglución ☐ 2300 Nivel de glucemia ☐ 1404 Estado nutricional ☐ 1618 Control de náuseas y vómitos	☐ 1080 Sondaje nasogástrico. Calibre: _____ ☐ 4035 Muestra de sangre capilar ☐ 2120 Manejo de la hiperglucemia ☐ 2130 Manejo de la hipoglucemia ☐ 1100 Manejo de la nutrición ☐ 1570 Manejo del vómito	☐ 4235 Flebotomía: vía canalizada. Tipo: _____ Calibre: _____ Localización: _____ ☐ 7820 Manejo de muestras. Tipo: _____ ☐ 1380 Aplicación de calor o frío ☐ 3900 Regulación de la temperatura ☐ 6610 Identificación de riesgos ☐ 6364 Triaje: centro de urgencias ☐ 7140 Apoyo a la familia ☐ 6650 Vigilancia ☐ 7680 Ayuda a la exploración ☐ 8020 Reunión multidisciplinar de cuidados ☐ 7910 Consulta ☐ 7726 Preceptor: estudiante
☐ 00016 Deterioro de la eliminación urinaria ☐ 00023 Retención urinaria ☐ 00011 Estreñimiento. ☐ 00013 Diarrea.	☐ 0501 Eliminación intestinal. ☐ 0503 Eliminación urinaria.	☐ 0590 Manejo de la eliminación urinaria ☐ 0580 Sondaje Vesical Calibre: _____ Débito: _____ ☐ 0620 Cuidados de la retención urinaria ☐ 1876 Cuidados del catéter urinario ☐ 0430 Control intestinal	Valoración de Enfermería Percepción-Manejo de la Salud Adherencia al tratamiento: Si ☐ NO ☐ Ingresos hospitalarios previos: Si ☐ NO ☐ Hábitos tóxicos: Si ☐ NO ☐ Nutrición-Metabólico Autónomo ☐ Dependiente ☐ Dieta equilibrada ☐ Disfagia ☐ SNG ☐ PEG ☐ Problemas digestivos: _____ Eliminación Normal ☐ Incontinencia ☐ Diarrea ☐ Estreñimiento ☐ Actividad-Ejercicio Activo ☐ Sedentario ☐ Movilidad: Autónomo ☐ Necesita ayuda ☐ Dependiente ☐ Sueño-Descanso Normal ☐ Alterado ☐ Ayudas para dormir ☐ Cognitivo-Perceptivo Consciente: Si ☐ NO ☐ Orientado: Si ☐ NO ☐ Autopercepción-Autoconcepto Conducta: No alterado ☐ Alterado ☐ Rol-Relaciones Mayor Vulnerable ☐ Violencia doméstica ☐ Ayuda domiciliaria ☐ Menor Vulnerable ☐ Sin Hogar ☐ Conducta suicida ☐ Riesgo Social ☐ Síndrome Diógenes ☐ Otros: _____ Sexualidad y reproducción Adaptación tolerancia al estrés Valores y creencias
☐ 00030 Deterioro del intercambio de gases ☐ 00032 Patrón respiratorio ineficaz ☐ 00031 Limpieza ineficaz de vía aérea. ☐ 00039 Riesgo de aspiración.	☐ 0415 Estado respiratorio	☐ 3160 Aspiración de las vías aéreas ☐ 3320 Oxigenoterapia. FIO ₂ : _____ lts/min: _____ Tipo: _____ ☐ 3302 Manejo de la ventilación mecánica: no invasiva. Modo: _____ FIO ₂ : _____ PEEP: _____ Trigger: _____ Frec. Resp: _____	Valoración de Enfermería Percepción-Manejo de la Salud Adherencia al tratamiento: Si ☐ NO ☐ Ingresos hospitalarios previos: Si ☐ NO ☐ Hábitos tóxicos: Si ☐ NO ☐ Nutrición-Metabólico Autónomo ☐ Dependiente ☐ Dieta equilibrada ☐ Disfagia ☐ SNG ☐ PEG ☐ Problemas digestivos: _____ Eliminación Normal ☐ Incontinencia ☐ Diarrea ☐ Estreñimiento ☐ Actividad-Ejercicio Activo ☐ Sedentario ☐ Movilidad: Autónomo ☐ Necesita ayuda ☐ Dependiente ☐ Sueño-Descanso Normal ☐ Alterado ☐ Ayudas para dormir ☐ Cognitivo-Perceptivo Consciente: Si ☐ NO ☐ Orientado: Si ☐ NO ☐ Autopercepción-Autoconcepto Conducta: No alterado ☐ Alterado ☐ Rol-Relaciones Mayor Vulnerable ☐ Violencia doméstica ☐ Ayuda domiciliaria ☐ Menor Vulnerable ☐ Sin Hogar ☐ Conducta suicida ☐ Riesgo Social ☐ Síndrome Diógenes ☐ Otros: _____ Sexualidad y reproducción Adaptación tolerancia al estrés Valores y creencias
☐ 00029 Disminución del gasto cardíaco ☐ 00267 Riesgo de tensión arterial inestable	☐ 0400 Efectividad de la bomba cardíaca. ☐ 0401 Estado circulatorio ☐ 2301 Respuesta a la medicación	☐ 4250 Manejo del shock. ☐ 4040 Cuidados cardíacos. ☐ ECG ☐ Monitor ☐ Cardioversión ☐ Desfibrilador Julios: _____ Choques: _____ ☐ 4162 Manejo de la hipertensión ☐ 4175 Manejo de la hipotensión ☐ 4092 Manejo del marcapasos: temporal Frec: _____ mVotios: _____	Valoración de Enfermería Percepción-Manejo de la Salud Adherencia al tratamiento: Si ☐ NO ☐ Ingresos hospitalarios previos: Si ☐ NO ☐ Hábitos tóxicos: Si ☐ NO ☐ Nutrición-Metabólico Autónomo ☐ Dependiente ☐ Dieta equilibrada ☐ Disfagia ☐ SNG ☐ PEG ☐ Problemas digestivos: _____ Eliminación Normal ☐ Incontinencia ☐ Diarrea ☐ Estreñimiento ☐ Actividad-Ejercicio Activo ☐ Sedentario ☐ Movilidad: Autónomo ☐ Necesita ayuda ☐ Dependiente ☐ Sueño-Descanso Normal ☐ Alterado ☐ Ayudas para dormir ☐ Cognitivo-Perceptivo Consciente: Si ☐ NO ☐ Orientado: Si ☐ NO ☐ Autopercepción-Autoconcepto Conducta: No alterado ☐ Alterado ☐ Rol-Relaciones Mayor Vulnerable ☐ Violencia doméstica ☐ Ayuda domiciliaria ☐ Menor Vulnerable ☐ Sin Hogar ☐ Conducta suicida ☐ Riesgo Social ☐ Síndrome Diógenes ☐ Otros: _____ Sexualidad y reproducción Adaptación tolerancia al estrés Valores y creencias
☐ 00051 Deterioro de la comunicación verbal ☐ 00128 Confusión aguda. ☐ 00129 Confusión crónica. ☐ 00146 Ansiedad.	☐ 0902 Comunicación ☐ 0909 Estado neurológico ☐ 1214 Nivel de agitación ☐ 1211 Nivel de ansiedad	☐ 2620 Monitorización neurológica. ☐ 5270 Apoyo emocional. ☐ 4929 Escucha activa	Valoración de Enfermería Percepción-Manejo de la Salud Adherencia al tratamiento: Si ☐ NO ☐ Ingresos hospitalarios previos: Si ☐ NO ☐ Hábitos tóxicos: Si ☐ NO ☐ Nutrición-Metabólico Autónomo ☐ Dependiente ☐ Dieta equilibrada ☐ Disfagia ☐ SNG ☐ PEG ☐ Problemas digestivos: _____ Eliminación Normal ☐ Incontinencia ☐ Diarrea ☐ Estreñimiento ☐ Actividad-Ejercicio Activo ☐ Sedentario ☐ Movilidad: Autónomo ☐ Necesita ayuda ☐ Dependiente ☐ Sueño-Descanso Normal ☐ Alterado ☐ Ayudas para dormir ☐ Cognitivo-Perceptivo Consciente: Si ☐ NO ☐ Orientado: Si ☐ NO ☐ Autopercepción-Autoconcepto Conducta: No alterado ☐ Alterado ☐ Rol-Relaciones Mayor Vulnerable ☐ Violencia doméstica ☐ Ayuda domiciliaria ☐ Menor Vulnerable ☐ Sin Hogar ☐ Conducta suicida ☐ Riesgo Social ☐ Síndrome Diógenes ☐ Otros: _____ Sexualidad y reproducción Adaptación tolerancia al estrés Valores y creencias
☐ 00114 Síndrome de estrés del traslado	☐ 0210 Realización de transferencia ☐ 1311 Adaptación al traslado	☐ 8100 Derivación ☐ 7890 Transporte entre instalaciones ☐ 7710 Colaboración con el médico ☐ 7960 Intercambio de información de cuidados de salud	Valoración de Enfermería Percepción-Manejo de la Salud Adherencia al tratamiento: Si ☐ NO ☐ Ingresos hospitalarios previos: Si ☐ NO ☐ Hábitos tóxicos: Si ☐ NO ☐ Nutrición-Metabólico Autónomo ☐ Dependiente ☐ Dieta equilibrada ☐ Disfagia ☐ SNG ☐ PEG ☐ Problemas digestivos: _____ Eliminación Normal ☐ Incontinencia ☐ Diarrea ☐ Estreñimiento ☐ Actividad-Ejercicio Activo ☐ Sedentario ☐ Movilidad: Autónomo ☐ Necesita ayuda ☐ Dependiente ☐ Sueño-Descanso Normal ☐ Alterado ☐ Ayudas para dormir ☐ Cognitivo-Perceptivo Consciente: Si ☐ NO ☐ Orientado: Si ☐ NO ☐ Autopercepción-Autoconcepto Conducta: No alterado ☐ Alterado ☐ Rol-Relaciones Mayor Vulnerable ☐ Violencia doméstica ☐ Ayuda domiciliaria ☐ Menor Vulnerable ☐ Sin Hogar ☐ Conducta suicida ☐ Riesgo Social ☐ Síndrome Diógenes ☐ Otros: _____ Sexualidad y reproducción Adaptación tolerancia al estrés Valores y creencias
☐ 00004 Riesgo de infección ☐ 00206 Riesgo de sangrado ☐ 00038 Riesgo de traumatismo físico ☐ 00312 Lesión por presión en el adulto ☐ 00044 Deterioro de la integridad tisular ☐ 00303 Riesgos de caídas en el adulto	☐ 1101 Integridad tisular: piel	☐ 4020 Disminución de la Hemorragia ☐ Torniquete. Hora: _____ ☐ Compresión ☐ 3660 Cuidados de la herida. ☐ 3620 Sutura ☐ 6610 Identificación de riesgos	Valoración de Enfermería Percepción-Manejo de la Salud Adherencia al tratamiento: Si ☐ NO ☐ Ingresos hospitalarios previos: Si ☐ NO ☐ Hábitos tóxicos: Si ☐ NO ☐ Nutrición-Metabólico Autónomo ☐ Dependiente ☐ Dieta equilibrada ☐ Disfagia ☐ SNG ☐ PEG ☐ Problemas digestivos: _____ Eliminación Normal ☐ Incontinencia ☐ Diarrea ☐ Estreñimiento ☐ Actividad-Ejercicio Activo ☐ Sedentario ☐ Movilidad: Autónomo ☐ Necesita ayuda ☐ Dependiente ☐ Sueño-Descanso Normal ☐ Alterado ☐ Ayudas para dormir ☐ Cognitivo-Perceptivo Consciente: Si ☐ NO ☐ Orientado: Si ☐ NO ☐ Autopercepción-Autoconcepto Conducta: No alterado ☐ Alterado ☐ Rol-Relaciones Mayor Vulnerable ☐ Violencia doméstica ☐ Ayuda domiciliaria ☐ Menor Vulnerable ☐ Sin Hogar ☐ Conducta suicida ☐ Riesgo Social ☐ Síndrome Diógenes ☐ Otros: _____ Sexualidad y reproducción Adaptación tolerancia al estrés Valores y creencias
☐ 00132 Dolor agudo ☐ 00133 Dolor crónico	☐ 1605 Control del dolor	☐ 2300 Administración de Medicación. ☐ 1410 Manejo del dolor: agudo ☐ 1415 Manejo del dolor: crónico	Valoración de Enfermería Percepción-Manejo de la Salud Adherencia al tratamiento: Si ☐ NO ☐ Ingresos hospitalarios previos: Si ☐ NO ☐ Hábitos tóxicos: Si ☐ NO ☐ Nutrición-Metabólico Autónomo ☐ Dependiente ☐ Dieta equilibrada ☐ Disfagia ☐ SNG ☐ PEG ☐ Problemas digestivos: _____ Eliminación Normal ☐ Incontinencia ☐ Diarrea ☐ Estreñimiento ☐ Actividad-Ejercicio Activo ☐ Sedentario ☐ Movilidad: Autónomo ☐ Necesita ayuda ☐ Dependiente ☐ Sueño-Descanso Normal ☐ Alterado ☐ Ayudas para dormir ☐ Cognitivo-Perceptivo Consciente: Si ☐ NO ☐ Orientado: Si ☐ NO ☐ Autopercepción-Autoconcepto Conducta: No alterado ☐ Alterado ☐ Rol-Relaciones Mayor Vulnerable ☐ Violencia doméstica ☐ Ayuda domiciliaria ☐ Menor Vulnerable ☐ Sin Hogar ☐ Conducta suicida ☐ Riesgo Social ☐ Síndrome Diógenes ☐ Otros: _____ Sexualidad y reproducción Adaptación tolerancia al estrés Valores y creencias
☐ 00020 Riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca ☐ 00033 Deterioro de la ventilación espontánea	☐ 0414 Estado cardiopulmonar	☐ 6200 Cuidados de la emergencia ☐ 6140 Manejo de la parada cardiopulmonaria ☐ 6320 Reanimación ☐ 4095 Manejo del desfibrilador ☐ 3140 Manejo de la vía aérea. Tipo: _____	Valoración de Enfermería Percepción-Manejo de la Salud Adherencia al tratamiento: Si ☐ NO ☐ Ingresos hospitalarios previos: Si ☐ NO ☐ Hábitos tóxicos: Si ☐ NO ☐ Nutrición-Metabólico Autónomo ☐ Dependiente ☐ Dieta equilibrada ☐ Disfagia ☐ SNG ☐ PEG ☐ Problemas digestivos: _____ Eliminación Normal ☐ Incontinencia ☐ Diarrea ☐ Estreñimiento ☐ Actividad-Ejercicio Activo ☐ Sedentario ☐ Movilidad: Autónomo ☐ Necesita ayuda ☐ Dependiente ☐ Sueño-Descanso Normal ☐ Alterado ☐ Ayudas para dormir ☐ Cognitivo-Perceptivo Consciente: Si ☐ NO ☐ Orientado: Si ☐ NO ☐ Autopercepción-Autoconcepto Conducta: No alterado ☐ Alterado ☐ Rol-Relaciones Mayor Vulnerable ☐ Violencia doméstica ☐ Ayuda domiciliaria ☐ Menor Vulnerable ☐ Sin Hogar ☐ Conducta suicida ☐ Riesgo Social ☐ Síndrome Diógenes ☐ Otros: _____ Sexualidad y reproducción Adaptación tolerancia al estrés Valores y creencias

Se marcará lo que proceda



14.7 Bibliografía

1. Guía de actuación para la prevención y el control de brotes de infecciones respiratorias agudas en centros residenciales de personas vulnerables. Documento elaborado por la Ponencia de Alertas, Planes de Preparación y Respuesta. Aprobado por la Comisión de Salud Pública. (Consultado 12 agosto 2024)
2. La Covid-19 tras el fin de la Emergencia Sanitaria. Nuevo marco estratégico integrado en la vigilancia y control de las infecciones respiratorias agudas. Documento elaborado por la Ponencia de Alertas, Planes de Preparación y Respuesta. Aprobado por la Comisión de Salud Pública. (Consultado 12 agosto 2024)
3. Procedimiento para la extracción de muestras para PCR en Domicilio por el Equipo C0vid de 061. Gerencia de urgencias y emergencias del 061. (Consultado 12 agosto 2024)
4. Procedimiento para la extracción de muestras para PCR en Residencias de Mayores por el Equipo C0vid de 061. Gerencia de urgencias y emergencias del 061. (Consultado 12 agosto 2024)
5. Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19. Ministerio de Sanidad, Instituto de salud Carlos III. (actualizado 16 junio de 2020).
6. Toma y transporte de muestras para diagnóstico por PCR de SARS-coV-2. Ministerio de Sanidad. 15 de julio de 2021.
7. Manejo en atención primaria y domiciliaria del COVID-19. Ministerio de Sanidad. (Versión 18 de junio de 2020).
8. Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con COVID-19. Ministerio de Sanidad. (Versión 17 de junio de 2020).
9. Manejo domiciliario del COVID-19. Ministerio de Sanidad. 17 de marzo de 2020.
10. Protocolo SMS para el diagnóstico microbiológico y tratamiento antiviral de COVID-19 y gripe en pacientes adultos en Atención Primaria. Servicio Murciano de Salud. Diciembre 2024.



15. PROCEDIMIENTO TOMA DE MUESTRAS EN MPOX POR UNIDADES SVAE.

15.1 Definición

Todas las actividades realizadas para la recogida de las distintas muestras, determinadas por Salud Pública, que determinen el diagnóstico de MPOX, así como posibles traslados.

15.2 Objetivos

- Determinar si hay una infección por MPOX para adecuar tratamiento y medidas.
- Poder limitar la expansión de la infección si la hubiese.

15.3 Ámbito de Aplicación

El lugar de actuación puede ser:

- Residencias, centros sanitarios, etc.
- Domicilios
- Otros por determinar

Destino será valorado por CCU, in situ, otra unidad, Hospital de referencia o el más Cercano, u otros.

15.4 Materiales

Para todas las muestras

Datos del residente, facilitados por el CCU	Hoja de datos para el laboratorio
Pegatinas de códigos para laboratorio	Triple embalaje para la muestra
EPI	Mascarilla quirúrgica para paciente



Para muestras de vesículas

Hisopo más medio	Suero fisiológico 10 ml
Gasas estériles	Aguja estéril/ bisturí desechable
Contenedor de punzantes	Pinzas

Para muestras de serología

Tubo de extracción (tapón rojo)	Compresor
Sobres de clorhexidina	Gasas estériles
Campana con aguja para extracción	Contenedor de punzantes

Para muestras de exudado orofaríngeo

Hisopo más medio	Depresor lingual
------------------	------------------

Para muestras de exudado anal

Hisopo más medio	Paño estéril
------------------	--------------

15.5 Plan de Actuación

Los pacientes sospechosos de MPOX serán identificados por el SUAP, UME, y/o el médico directivo del CCU, ya sea de forma presencial o telefónica. Éstos se pondrán en contacto con la Enfermera de enlace del CCU, que a su vez contactará con el epidemiólogo de guardia. Este último decidirá si el caso reúne criterios y qué muestras se extraen. Se seguirá una de las dos vías expuestas a continuación, para determinar si procede la toma de muestras:

Vía 1: Caso con clínica compatible. Una persona con un cuadro clínico altamente sugestivo de infección por mpox:

- Exantema vesicular o pustular (especialmente si es umbilicado) en cualquier parte del cuerpo Y
- Fiebre (>38,5°C), dolor de cabeza intenso, mialgia, artralgia, dolor de espalda o linfadenopatía

El diagnóstico diferencial clínico debe incluir otras enfermedades exantemáticas como varicela, herpes virus, eczema herpeticum, enterovirus como coxsackie o echovirus),



sarampión, infecciones cutáneas bacterianas, sarna, sífilis, alergias asociadas a medicamentos y otras enfermedades dermatológicas.

Si hay una alta sospecha clínica debe realizarse un procedimiento de diagnóstico diferencial microbiológico Monkeypox (incluye PCR de Herpes simple 1/2, PCR Varicela-zóster y PCR de enterovirus Coxsackie además de mpox) mediante un exudado/aspirado de la lesión y utilizando un medio de transporte de virus en medios de conservación líquidos (tipo Amies o sin inactivantes), además deben conservarse refrigeradas hasta su envío a 4°C. Todas las muestras se envían en contenedores de bioseguridad y en condiciones de refrigeración. (circuito de toma y envío de muestras pendiente de establecerse).

Solo en caso de confirmación de la prueba se pondrían en marcha las medidas de control ante un caso y sus contactos por parte de las autoridades de Salud Pública. No es necesario comunicar a Salud Pública ante un caso confirmado, se capta a través del Sistema de Información Microbiológica.

Vía 2: Caso con clínica compatible descrito en la vía 1 y que cumple alguno de los siguientes criterios en los 21 días anteriores al inicio de síntomas:

- Ha tenido contacto estrecho con un caso confirmado de mpox.
- Ha mantenido relaciones en contextos sexuales de riesgo
- Tiene historia de viajes a zonas de África occidental o central en los que se ha identificado circulación del virus ([Ministerio de Sanidad - Áreas - Notas informativas en relación con incidentes y eventos sanitarios internacionales de salud pública - Enfermedades emergentes y reemergentes](#))

Declaración a los Servicios de SP:

De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas:

- En las Áreas de Salud de Cartagena (Cartagena, La Unión, Fuente el Álamo, Mazarrón) y Mar Menor (Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco) al Servicio de Salud Pública de Cartagena. Teléfono: 968326666
- En el Área Sanitaria de Lorca (Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras, Totana, Aledo) al Servicio de Salud Pública de Lorca. Teléfono: 968468300
- En el municipio de Murcia a los Servicios Municipales de Salud. Teléfono: 968247112
- En el resto del territorio de la Región al Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública. : Teléfono: 968362039

De lunes a viernes de 15:00 a 8:00 horas, sábados domingos y festivos 24h: 607 553 204

Al cumplir alguno de los criterios mencionados en la vía 2 lo convierten en un caso probable y las medidas de control ante casos y contactos se toman inmediatamente (sin esperar a la confirmación microbiológica).

La Enfermera de enlace del CCU, asignará la unidad SVAE para la recogida.





CIRCUITO MPX PARA 061



Se ha puesto en marcha el "protocolo para la detección y manejo de casos ante la alerta de VIRUELA DE LOS MONOS (Monkeypox). Este protocolo está consensuado con el SMS y Salud pública, y se han establecido los circuitos de actuación ante casos sospechosos en unidades 061.

Desde 061 se va a proceder de la siguiente manera, hasta nueva orden

Posible caso detectado
por unidad asistencial

Posible caso detectado
por CCU

PASAR PUESTO 25 ENFERMERÍA CCU

1

2

3

4

LAMADA A
EPIDEMIÓLOGO
DE GUARDIA (TLF:
07553204/8820)
Mañanas ver anexo SVAE

ENF-CCU
Enviará datos relevantes (nombre,
dirección, teléfono, síntomas,
Cuando han aparecido los
síntomas) al correo electrónico:
vigilancia.epidemiologica@cam.es

El Epidemiólogo de guardia, tras
confirmar la sospecha y en
consenso médico de guardia
indica toma de muestra.

El ENFERMER@ DEL PUESTO 96,
Gestionará petición y asignará
la unidad SVAE que va a
realizar la toma de muestra
También contactará con el
MICROBIÓLOGO DE GUARDIA DE
HUVA (83237) para establecer el
circuito de entrega de muestra.



RECOGIDA DE MUESTRAS:

Recogida de muestras orofaríngeas:

Enfermería realizará la toma de muestra orofaríngea según procedimientos establecidos en su unidad.

Recogida de muestras de vesículas:

Vesículas cerradas: Limpiaremos la superficie de la vesícula con una gasa humedecida en suero fisiológico estéril. Rasgaremos la vesícula con una aguja estéril o bisturí desechable. Pasaremos hisopo por dentro la vesícula y depositaremos dentro del medio.

Vesículas abiertas: limpiaremos con una gasa humedecida en suero fisiológico estéril, secaremos con ligeros toques y pasaremos hisopo por la base de la lesión y depositaremos dentro del medio.

Vesículas con costra: limpiaremos con una gasa humedecida en suero fisiológico estéril, secaremos con ligeros toques. Con una aguja o bisturí, levantaremos la costra y depositaremos en el medio.

También pasaremos el hisopo por el lecho de la lesión sin hacer sangre, depositamos en el medio junto con la costra.

Recogida de muestra anal:

El paciente se colocará en prono, sobre sus rodillas. El hisopo se introducirá unos 2 cm, recorriendo la pared anal interior.

En la hoja de datos especificaremos el tipo de muestra recogida.

En la parte de fuera de domicilio esperará el técnico con el triple embalaje para recepcionar la muestra y cerrar adecuadamente dicho embalaje.

Al finalizar el proceso de toma y depósito de muestra/as, retiraremos el EPI según Anexo II/III. Las muestras serán llevadas al Laboratorio de virología de HUVA, si no hay indicaciones de llevar a otro hospital.

Una vez realizada la toma de la muestra y depositada en el contenedor de triple embalaje, ésta se dejará en el laboratorio que nos indiquen la Enfermero Directivo del CCU, para custodia y refrigeración, después será cerrado el aviso por CCU.

15.6 Observaciones

Si por el estado de salud del paciente, precisase asistencia sanitaria, realizaríamos la evaluación inicial como el resto de los pacientes.



15.7 Historia de Cuidados de Enfermería (SVAE)

En la Historia de Cuidados de Enfermería Extrahospitalaria se deben registrar, como mínimo, los siguientes datos

V. REGISTRO DE ENFERMERÍA			
Etiquetas diagnóstico NANDA	Resultados NOC	Intervenciones NIC	
☐ 00257 Sd. Fragilidad del anciano ☐ 00103 Deterioro de la deglución ☐ 00179 Riesgo de nivel de glucemia inestable ☐ 00002 Desequilibrio nutricional: inferior a las necesidades corporales ☐ 00232 Obesidad ☐ 00233 Sobre peso ☐ 00134 Náuseas	☐ 0802 Signos Vitales ☐ 1912 Caídas ☐ 0208 Movilidad ☐ 2402 Función sensitiva ☐ 1913 Severidad de la lesión física ☐ 1010 Estado de deglución ☐ 2300 Nivel de glucemia ☐ 1404 Estado nutricional ☐ 1618 Control de náuseas y vómitos	☐ 6680 Monitorización de los signos vitales ☐ 4420 Acuerdo con el paciente ☐ 5510 Educación para la salud ☐ 7170 Facilitar la presencia de la familia ☐ 1080 Sondaje nasogástrico. Calibre: _____ ☐ 4035 Muestra de sangre capilar ☐ 2120 Manejo de la hiperglucemia ☐ 2130 Manejo de la hipoglucemia ☐ 1100 Manejo de la nutrición ☐ 1570 Manejo del vómito	☐ 4235 Flebotomía: vía canalizada. Tipo: _____ Calibre: _____ Localización: _____ ☐ 7820 Manejo de muestras. Tipo: _____ ☐ 1380 Aplicación de calor o frío ☐ 3900 Regulación de la temperatura ☐ 6610 Identificación de riesgos ☐ 6364 Triaje: centro de urgencias ☐ 7140 Apoyo a la familia ☐ 6650 Vigilancia ☐ 7680 Ayuda a la exploración ☐ 8020 Reunión multidisciplinar de cuidados ☐ 7910 Consulta ☐ 7726 Preceptor: estudiante
☐ 00016 Deterioro de la eliminación urinaria ☐ 00023 Retención urinaria ☐ 00011 Estreñimiento. ☐ 00013 Diarrea.	☐ 0501 Eliminación intestinal. ☐ 0503 Eliminación urinaria.	☐ 0590 Manejo de la eliminación urinaria ☐ 0580 Sondaje Vesical Calibre: _____ Débito: _____ ☐ 0620 Cuidados de la retención urinaria ☐ 1876 Cuidados del catéter urinario ☐ 0430 Control intestinal	Valoración de Enfermería Percepción-Manejo de la Salud Adherencia al tratamiento: Si ☐ No ☐ Ingresos hospitalarios previos: Si ☐ No ☐ Hábitos tóxicos: Si ☐ No ☐ Nutrición-Metabólico Autónomo ☐ Dependiente ☐ Dieta equilibrada ☐ Disfagia ☐ SNG ☐ PEG ☐ Problemas digestivos: _____ Eliminación Normal ☐ Incontinencia ☐ Diarrea ☐ Estreñimiento ☐ Actividad-Ejercicio Activo ☐ Sedentario ☐ Movilidad: Autónomo ☐ Necesita ayuda ☐ Dependiente ☐ Sueño-Descanso Normal ☐ Alterado ☐ Ayudas para dormir ☐ Cognitivo-Perceptivo Consciente: Si ☐ NO ☐ Orientado: Si ☐ NO ☐ Autopercepción-Autoconcepto Conducta: No alterado ☐ Alterado ☐ Rel-Relaciones Mayor Vulnerable ☐ Violencia doméstica ☐ Ayuda domiciliaria ☐ Menor Vulnerable ☐ Sin Hogar ☐ Conducta suicida ☐ Riesgo Social ☐ Síndrome Diógenes ☐ Otros: _____ Sexualidad y reproducción Adaptación tolerancia al estrés Valores y creencias
☐ 00030 Deterioro del intercambio de gases ☐ 00032 Patrón respiratorio ineficaz ☐ 00031 Limpieza ineficaz de vía aérea. ☐ 00039 Riesgo de aspiración.	☐ 0415 Estado respiratorio	☐ 3160 Aspiración de las vías aéreas ☐ 3320 Oxigenoterapia. FIO ₂ : _____ lts/min: _____ Tipo: _____ ☐ 3302 Manejo de la ventilación mecánica: no invasiva. Modo: _____ FIO ₂ : _____ PEEP: _____ Trigger: _____ Frec. Resp: _____	
☐ 00029 Disminución del gasto cardíaco ☐ 00267 Riesgo de tensión arterial inestable	☐ 0400 Efectividad de la bomba cardíaca. ☐ 0401 Estado circulatorio ☐ 2301 Respuesta a la medicación	☐ 4250 Manejo del shock. ☐ 4040 Cuidados cardíacos. ☐ ECG ☐ Monitor ☐ Cardioversión ☐ Desfibrilador Julios: _____ Choques: _____ ☐ 4162 Manejo de la hipertensión ☐ 4175 Manejo de la hipotensión ☐ 4092 Manejo del marcapasos: temporal Frec: _____ mVoltios: _____	
☐ 00051 Deterioro de la comunicación verbal ☐ 00128 Confusión aguda. ☐ 00129 Confusión crónica. ☐ 00146 Ansiedad.	☐ 0902 Comunicación ☐ 0909 Estado neurológico ☐ 1214 Nivel de agitación ☐ 1211 Nivel de ansiedad	☐ 2620 Monitorización neurológica. ☐ 5270 Apoyo emocional. ☐ 4929 Escucha activa	
☐ 00114 Síndrome de estrés del traslado	☐ 0210 Realización de transferencia ☐ 1311 Adaptación al traslado	☐ 8100 Derivación ☐ 7890 Transporte entre instalaciones ☐ 7710 Colaboración con el médico ☐ 7960 Intercambio de información de cuidados de salud	
☐ 00004 Riesgo de infección ☐ 00206 Riesgo de sangrado ☐ 00038 Riesgo de traumatismo físico ☐ 00312 Lesión por presión en el adulto ☐ 00044 Deterioro de la integridad tisular ☐ 00303 Riesgos de caídas en el adulto	☐ 1101 Integridad tisular: piel	☐ 4020 Disminución de la Hemorragia ☐ Torniquete. Hora: _____ ☐ Compresión ☐ 3660 Cuidados de la herida. ☐ 3620 Sutura ☐ 6610 Identificación de riesgos	
☐ 00132 Dolor agudo ☐ 00133 Dolor crónico	☐ 1605 Control del dolor	☐ 2300 Administración de Medicación. ☐ 1410 Manejo del dolor: agudo ☐ 1415 Manejo del dolor: crónico	
☐ 00020 Riesgo de disminución de la perfusión tisular cardíaca ☐ 00033 Deterioro de la ventilación espontánea	☐ 0414 Estado cardiopulmonar	☐ 6200 Cuidados de la emergencia ☐ 6140 Manejo de la parada cardiopulmonaria ☐ 6320 Reanimación ☐ 4095 Manejo del desfibrilador ☐ 3140 Manejo de la vía aérea. Tipo: _____	

Se marcará lo que proceda

15.8 Bibliografía

1. Manejo en atención primaria y domiciliaria del COVID-19. Ministerio de Sanidad. (Versión 18 de junio de 2020).
2. Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con COVID-19. Ministerio de Sanidad. (Versión 17 de junio de 2020).
3. Procedimiento de Microbiología Clínica. 24a. Diagnóstico microbiológico de las infecciones de transmisión sexual y otras infecciones genitales. SEIMC. <https://seimc.org/contenidos/documentoscientificos/procedimientosmicrobiologia/seimcprocedimiento24a.pdf>
4. Procedimiento de Microbiología Clínica. 1b. Recogida, transporte y procesamiento general de las muestras del laboratorio de microbiología.
5. <https://seimc.org/contenidos/documentoscientificos/procedimientosmicrobiologia/seimcprocedimientosmicrobiologia1b.pdf>
6. Toma y transporte de muestras para diagnóstico por PCR de SARS-coV-2. Ministerio de Sanidad. 15 de julio de 2021.
7. Protocolo para la detección precoz y manejo de casos de MPOX en España. Ministerio de Sanidad. Instituto Carlos III. Actualizado a 22 de agosto de 2024.
8. Evaluación rápida de Riesgo. Expansión del clado I del virus mpox en algunos países de África. Ministerio de Sanidad. Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias. 22 de agosto 2024.



ANEXO 1. Revisión visual de mochilas circulatorio y respiratorio.

MOCHILA CIRCULATORIO



CENTRAL SUPERIOR

TETRAS (10)
SOBRES GASAS ESTÉRILES (10)
TIJERAS VENDAJES

LATERAL DERECHO

CONTENEDOR RESIDUOS
PUNZANTES (1)

LATERAL IZQUIERDO

SUERO 500 ML GLUSADO 10% (1)
SUERO 100ML GLUCOSADO 5% (1)
SUERO 100 ML FISIOLÓGICO 0,9% (1)

CENTRAL INFERIOR

ESFINGOMANÓMETRO AUTOMÁTICO (1)
ESFINGOMANÓMETRO MANUAL (1)
FONENDOESCOPIO (1)
GLUCOMETER (TIRAS, LANCETAS, GASAS)
PULSIOXÍMETRO PORTÁTIL (1)
TERMÓMETRO LASER (1)



1

DIFUSOR SUBCUTÁNEO (1)
ATOMIZADOR INTRANASAL (1)
DEPRESORES LINGUALES (10)
TERMÓMETRO DIGITAL (1)
MAQUINILLA RASURAR DESECHABLE (1)
PILAS AA (4)
PILAS AA (2)
PILA CR2032 (1)

2

VENDA COHESIVA 10 CM (2)
VENDA COHESIVA 5 CM (1)
VENDA CREPE 10CM (1)
VENDA ALGODON 10CM (1)
APÓSITOS VARIADOS (4)





3

AGUJA 0,5x16/0,6x30/0,7x30/0,8x40 (5/c)
AGUJA 1,2x40 (TRANSFERENCIA) (5)

4

JERINGA 1, 10 Y 20 (2/c)
JERINGA 2 Y 5 ML (5/c)

5

PUNTOS DE APROXIMACIÓN (1 SOBRE)
ESPARADRAPO PAPEL (1)
POVIDONA IODADA 10ml (1)
FLAMMAZINE (1 TUBO)
LINITUL (1 SOBRE)
OTROS APÓSITOS (1/c)



6

CATÉTER VENOSO 14-16-24 G (3/c)
CATÉTER VENOSO 18-20-22 (5/c)

7

PISTOLA INTRAÓSEA ADULTO/ PDT(1/c)
ALARGADERA CON LLAVE 3 VÍAS (1)
TOALLITA ANTISÉPTICA CLORHEXIDINA (3)
JERINGA 10 ML (1)
SUERO 10ML (1)

8

COMPRESOR VENOSO (2)
APÓSITOS ADHESIVO FIJACIÓN CATÉTER (5)
VÁLVULA BIDIRECCIONAL (5)
TOALLITA ANTISÉPTICA CLORHEXIDINA (5)
GASA ESTÉRIL SOBRE 5 U (2)





- 9**
- TORNIQUETE (1)
MANTA TERMOAISLANTE (2)
- 10**
- PARACETAL IV 100ML (1)
REGULADOR DE FLUJO DIAL-A FLOW (1)
LLAVE TRES VÍAS (1)
- 11**
- SUERO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML (1)
SUERO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML (1)
SISTEMA PERFUSIÓN + LLAVE (2)



MOCHILA RESPIRATORIO



CENTRAL SUPERIOR

I-GEL N° 3, 4 Y 5 (1)
GEL LUBRICANTE (1)
TIJERAS VENDAJE (1)
PINZAS MAGILL (1)

LATERAL DERECHO

SUERO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML (1)
SUERO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML (1)

LATERAL IZQUIERDO

CÁMARA DE INHALACIÓN (1)

CENTRAL INFERIOR

AMBÚ ADULTO + MASCARILLA (1)
AMBÚ PEDIÁTRICO+ MASCARILLA (1)
FILTRO (1)



1

CÁNULAS OROFARÍNGEAS N°2, 3, 4 y 5 (1/c)

2

GAFAS NASALES ADULTO (2)
MASCARILLA ALTA CONCENTRACIÓN FILTRO (1)
GEL LUBRICANTE (1)
VENDA GASA ALGODÓN (1)





3

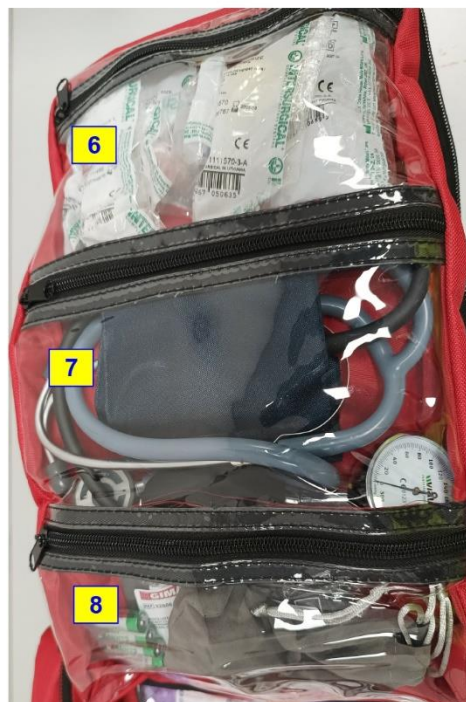
NEBULIZACION:
VASO PARA NEBULACIÓN (1)
SALBUTAMOL (1)
ATROVENT MONODOSIS (MIN 3)
BUDESÓNIDA MONODOSIS (MIN 3)
JERINGA 5 ML (1)
AGUJA TRANSFERENCIA (2)
SUERO 10 ML (1)

4

MASCARILLA VENTIMASK ADULTO (1)

5

MASCARILLA RESERVORIO ADULTO (1)



6

CÁNULAS OROFARÍNGEAS N°000, 00, 0, 1, 1,5 y 2 (1/c)

7

ESFINGOMANÓMETRO PEDIÁTRICO (1)
FONENDOSCOPIO PEDIÁTRICO (1)

8

MANGUITO PEDIÁTRICO PEQUEÑO (1)
PULSIOXÍMETRO PEDIÁTRICO (1)
PILAS AAA (2)





9

GAFAS NASALES PDT (1)
MASCARILLA VENTIMASK PDT (1)
MASCARILLA RESERVORIO PDT (1)
VENDA GASA ALGODÓN (1)

10

MASCARILLA LARÍNGEA PDT Nº 1 Y 1,5 (1/c)
JERINGA 10 ML (2)

11

MASCARILLA LARÍNGEA PDT Nº 2 Y 2,5 (1/c)
JERINGA 10 ML (2)



ANEXO 2. Fichas de Guía farmacológica 061

CLORURO MÓRFICO

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	PRESENTACIÓN	VÍA	SUEROS
MORFINA	CLORURO MÓRFICO	1% 10MG AMP 1 ML	IM, IV, PERF IV, SC	SF, SG5%

Indicaciones: Tratamiento del dolor intenso. Tratamiento del dolor postoperatorio inmediato. Tratamiento del dolor crónico maligno. Dolor asociado a infarto de miocardio. Disnea asociada a insuficiencia ventricular izquierda y edema pulmonar. Ansiedad ligada a procedimientos quirúrgicos.

Dosis adulto: *Dinicio:* **SC/IM:** 5 - 20 mg cada 4 h, generalmente 10 mg de manera inicial, según necesidades y la respuesta del paciente. **IV:** 2-10 mg diluir 10 mg en 9 ml de SF (1 mg/ml) infundir a ritmo de 2-3 mg/min. Si el paciente tomaba morfina, administrar 1/10 parte de la dosis que se le estaba administrando. Puede repetirse la dosis cada 20 min hasta una *D máxima:* 20-25 mg.

En pacientes con IAM se recomienda la administración de 2 - 15 mg pudiendo administrarse dosis en aumento (1 - 3 mg) cada 5 min. En el caso de administración por PERFIV continua el ritmo inicial recomendado en adultos es de 0,8-10 mg/h, incrementándose posteriormente en función de la respuesta del paciente; una dosis de carga de 15 mg o más puede ser administrada inicialmente para alivio previo del dolor y posteriormente iniciar una perfusión intravenosa continua. *D Mantenimiento:* **PERF IV** 15-60 µgr/kg/h.; **preparación:** diluir 10 mg (1 ampolla) en 50 ml de SF o SG5% (=0,2 mg/ml = 200 µgr/ml, y de estos, se perfunden, con bomba al siguiente ritmo:

Tabla Morfina sódico adulto: *D mantenimiento:* diluir 10 mg (1 ampollas) en 50 ml de SF o SG5% (=0,2 mg/ml = 200 µgr/ml, y de estos, se perfunden, con bomba al siguiente ritmo

D/P	50 Kg	60 Kg	70 Kg	80 Kg	90 Kg	100Kg
15 µgr/kg/h	3,75 ml/h	4,5	5,25	6	6,75	7,5
25 µgr/kg/h	6,25	7,5	8,75	10	11,25	12,5
35 µgr/kg/h	8,75	10,5	12,25	14	15,75	17,5
45 µgr/kg/h	11,25	13,5	15,75	18	20,25	22,5
55 µgr/kg/h	13,75	16,5	19,25	22	24,75	27,5
60 µgr/kg/h	16,25	19,5	22,75	26	29,25	32,5 ml/h

Dosis pediátrica: *Dinicio:* **SC/IM:** 0,1 - 0,2 mg/kg cada 4 horas según necesidades, *D máxima:* 15 mg en 24 h. **IV:** 0,05 - 0,1 mg/kg administrados muy lentamente, cada 10-20 minutos sin superar los 15 mg en 24 h. *D mantenimiento:* 0,01-0,03 mg/kg/h. En caso de pacientes con dolor crónico intenso se recomiendan **PERF IV:** 0,04- 0,07 mg/kg/h.

Tabla Morfina Pediátrica: *D inicio:* 10 mg + 9 ml SF o SG5 % Vol total:10ml (1 ml =1 mg)

D/P	5 kg	10 kg	20 kg	30 kg	40 kg
0,1 mg/kg	0,5 ml	1	2	3	4
0,15 mg/kg	0,75	1,5	3	4,5	6
0,2 mg/kg	1	2	4	6	8 ml

Tabla Morfina Pediátrica: *D mantenimiento:* 10 mg + 99 ml SF o SG5 %. Vol total: 100ml (1 ml =0,1 mg)

D/P	5 kg	10 kg	20 kg	30 kg	40 kg
0,01 mg/kg/h	0,5 ml/h	1	2	3	4
0,02 mg/kg/h	1	2	4	6	8
0,03 mg/kg/h	1,5	3	6	9	12
0,04 mg/kg/h	2	4	8	12	16
0,05 mg/kg/h	2,5	6	12	18	24 ml/h

Tabla Morfina Pediátrica: *D mantenimiento:* 10 mg + 499 ml SF o SG5 %. Vol total: 500 ml (1 ml =0,02 mg)

D/P	5 kg	10 kg	20 kg	30 kg	40 kg
0,01 mg/kg/h	2,5 ml/h	5	10	15	20
0,02 mg/kg/h	5	10	20	30	40
0,03 mg/kg/h	7,5	15	30	45	60
0,04 mg/kg/h	10	20	40	60	80
0,05 mg/kg/h	12,5	30	60	90	120 ml/h



Normas de administración: Únicamente debe ser administrado por vía intravenosa, intratecal y epidural y debe estar disponible en todo momento un antagonista opiáceo así como los dispositivos necesarios para la administración de oxígeno y control de la respiración. De manera adicional, cuando se administra por vía epidural e intratecal los pacientes deben ser monitorizados durante, como mínimo 24 h, ya que puede producirse depresión respiratoria. En caso de que tenga que efectuarse una dilución se realizará con agua estéril para inyección o con SF.

Contraindicaciones: Pacientes con alergia a la morfina u otros opiáceos. Pacientes con depresión respiratoria o enfermedad respiratoria obstructiva grave. En caso de infección en el lugar de la inyección y en pacientes con alteraciones graves de la coagulación, la administración por vía epidural o intratecal está contraindicada. Interacciones: Hay una serie de medicamentos con los que en caso de emplearlos conjuntamente debe reducirse la dosis de estos: antihipertensivos, antimuscarínicos, antidiarréicos antiperistálticos, IMAO. Existe otro grupo de medicamentos que se caracteriza por aumentar los efectos de Morfina: medicamentos que producen depresión del SNC, bloqueantes neuromusculares, analgésicos agonistas de los opiáceos, pentazocina, nalbufina y butorfanol.

Factor riesgo embarazo: Categoría C.

Reacciones adversas: Trastornos gastrointestinales: náuseas, vómitos, estreñimiento, somnolencia, desorientación, sudoración, euforia.

Precauciones: Deberá realizarse un especial control clínico en presencia de presión intracraneal aumentada, lesión cerebral, asma crónica, hipotensión, hipotiroidismo, taquicardia supraventricular, hipertrofia prostática o estenosis uretral, disfunción de la vesícula biliar, enfermedad inflamatoria intestinal grave o historial de drogodependencia. Se aconseja precaución al administrarlo en pacientes muy jóvenes, personas de edad avanzada, muy debilitados o con insuficiencia renal o hepática, que pueden ser más sensibles a los efectos especialmente la depresión respiratoria.

Ajuste dosis IR/IH: IR: ClCr: 10-50 ml/min: 75% de la dosis. ClCr < 10 ml/min: 50% de la dosis.

Antídotos/sobredosis: Mantener una vía respiratoria e instaurar respiración controlada o asistida. Administrar naloxona (de 0,4 a 2 mg) en una dosis única, preferiblemente intravenosa. Se puede repetir a intervalos de dos a tres minutos. Administrar líquidos intravenosos y/o vasopresores, utilizando otras medidas de apoyo según las necesidades.

Estabilidad: Debe ser usado inmediatamente tras su apertura. Una vez abierto el envase, desechar la porción no utilizada de la solución.

Conservación: Proteger de la luz.

DICLOFENACO

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	PRESENTACIÓN	VÍA	SUEROS
DICLOFENACO	DICLOFENACO EFG	75 MG AMP 3 ML	IM	SF, SG5%,

Indicaciones: Dolores agudos e intensos debido a formas inflamatorias y degenerativas. Crisis aguda de gota. Cólico renal. Dolores postraumáticos y postoperatorios.

Dosis adulto: *Dinicio:* IM: 75 mg /12 h, (no más de 2-3 días).

Dosis pediatria: No se recomienda su uso. En caso de utilización, *Dinicio:* IM: 1-3 mg/kg/día repartidos en 2-4 dosis. *Dmáxima:* 150mg/día

Contraindicaciones: Hipersensibilidad conocida al diclofenaco. Porfiria hepática. Enfermedad gastrointestinal activa. Insuficiencia hepática grave e insuficiencia renal grave.

Normas de administración: Administración por vía IM profunda en el glúteo (cuadrante superior externo).

Interacciones: Aumenta el efecto de los anticoagulantes orales, hipoglucemiantes orales, triamtereno, otros AINE, cefalosporinas, litio, metotrexato, penicilamina y probenecid.

Factor riesgo embarazo: Categoría B. Tercer trimestre: Categoría D.

Reacciones adversas: Gastrointestinales: Náuseas, vómitos, dolor abdominal, dispepsia, distensión abdominal, flatulencia, úlcus péptico, sangrado o perforación gastrointestinal. Hepatotóxico. Renales: azoemia, nefritis, insuficiencia renal aguda, síndrome nefrótico, edemas periféricos (sobre todo en insuficiencia cardíaca) Neurológicos: confusión, cefalea y vértigo.

Precauciones: Patología gastrointestinal. Coagulopatías. Insuficiencia renal. No recomendado en enfermos con retención de líquidos.

Antídotos/sobredosis: Aspiración y lavado gástrico, administración de carbón adsorbente, vigilancia y mantenimiento de constantes vitales, tratamiento sintomático de irritación gastrointestinal, hipotensión, depresión respiratoria y convulsiones, con monitorización de funciones renal y hepática y detección en heces de posible hemorragia gastrointestinal.

Conservación: Proteger de la luz.



FENTANILO

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	PRESENTACIÓN	VÍA	SUEROS
FENTANILO	FENTANEST	150 µg AMP 3 ML	IM, IV, PERF I	SF, SG5%

Indicaciones: Analgésico narcótico complementario en anestesia general o local. Premedicación analgésica para inducción de la anestesia y como adyuvante en el mantenimiento de la anestesia general y local.

Dosis adulto: **Analgésia:** Dinicio: 1-3 µg/kg. Titulando la dosis: inicialmente 50 µg, valorar a los 3 min: si es necesario dar la ½ de la dosis restante. Valorar a los 3 min: si es necesario dar la dosis restante. D.mantenimiento: **PERF IV:** 1-4 µg/kg/h.

Tabla Fentanilo adulto:

Dinicio: 1-3 µg/kg. Diluir 1 amp 3 ml (150 µg) en 12 ml de SF o SG5%; Vol total 15 ml (1 ml = 10 µg): Titulando la dosis: inicialmente ½ dosis, valorar a los 3 min: si es necesario dar la ½ de la dosis restante, valorar a los 3 min: si es necesario dar la dosis restante.

D/P	50 kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	100 kg
1 µg /kg 0,1 ml/kg	5 ml	6	7	8	9	10
2 µg /kg 0,2 ml/kg	10	12	14	16	18	20
3 µg /kg 0,3 ml/kg	15	18	21	24	27	30 ml

Tabla Fentanilo adulto:

D.mantenimiento: **PERF IV:** 1-4 µg/kg/h. Diluir 1 amp 3 ml (150 µg) en 97 ml de SF o SG5%; Vol total 100 ml (1 ml = 1,5 µg):

D/P	50 kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	100 kg
1 µg /kg/h 0,66 ml/h	33 ml/h	39,6	46,2	52,8	59,4	66
2 µg /kg /h 1,33 ml/h	66,5	79,8	93,1	106,4	119,7	133
3 µg /kg/h 2 ml/h	100	120	140	160	180	200
4 µg /kg /h 2,66 ml/h	133	159,6	186,2	212,8	239,4	266 ml/h

Dosis pediatria: **Analgésia:** Dinicio: 1-2 µg/kg. D.mantenimiento: 1-3 µg/kg/h.

Tabla Fentanilo Pediatría:

Dinicio: 1-2 µg/kg. Diluir 1 ml de la amp (50 µg) en 9ml de SF o SG5%; Vol total 10ml. (1 ml = 5 µg)

D/P	5 kg	10 kg	20 kg	30 kg	40 kg
1 µg /kg 0,2 ml/kg	1 ml	2	4	6	8
2 µg /kg 0,4 ml/kg	2l	4	8	12	16 ml

Tabla Fentanilo Pediatría:

D.mantenimiento: **PERF IV:** 1-3 µg/kg/h. Diluir 2ml de 1amp (100 µg) en 98 ml de SF o SG5%; Vol total 100 ml (1 ml = 1 µg):

D/P	5 kg	10 kg	20 kg	30 kg	40 kg
1 µg /kg/h 1 ml/kg/h	5 ml/h	10	20	30	40
2 µg /kg /h 2 ml/kg/h	10	20	40	60	80
3 µg /kg/h 3 ml/kg/h	15	30	60	90	120 ml/h

Normas de administración: Inyección intravenosa lenta. Inyección lenta y diluida, en pacientes con TCE o lesiones cerebrales previas.

Contraindicaciones: Traumatismo craneoencefálico, aumento de la presión intracraneal y/o coma. Niños menores de 2 años.

Interacciones: Debe evitarse el uso simultáneo de derivados del ácido barbitúrico. No se recomienda el uso simultáneo de buprenorfina, nalbupina o pentazocina, antagonizan parcialmente el efecto analgésico del fentanilo. El uso simultáneo de otros depresores del SNC podría producir efectos depresores aditivos y podrían darse casos de hipoventilación, hipotensión, sedación profunda o coma. La epinefrina no debe ser nunca utilizada como agente vasoactivo con el fentanilo, porque puede dar lugar a hipotensión. Los IMAO incrementan el efecto de los analgésicos narcóticos, especialmente en pacientes con IC.

Factor riesgo embarazo: Categoría C.

Reacciones adversas: Somnolencia, sedación, cefalea, mareos, náuseas, vómitos, estreñimiento, sudoración, prurito, reacciones cutáneas en el punto de aplicación.

Precauciones: Pueden provocar hipotensión, especialmente en pacientes con hipovolemia. Deben adoptarse las medidas adecuadas para mantener una presión arterial estable. Pueden aparecer movimientos clónicos no epilépticos. Precaución en IR e IH.

Antídotos/sobredosis: Mantener una vía respiratoria e instaurar respiración controlada o asistida. Administrar naloxona (de 0,4 a 2 mg) en una dosis única, preferiblemente intravenosa. Se puede repetir a intervalos de dos a tres minutos. Administrar líquidos intravenosos y/o vasopresores, utilizando otras medidas de apoyo según las necesidades.

Estabilidad: Diluido 14 días a temperatura ambiente.

Conservación: Proteger de la luz.



KETOROLACO

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	PRESENTACIÓN	VÍA	SUEROS
KETOROLACO	KETOROLACO EFG	30 MG AMP 1ML	IM, IV, PERFIV	SF, SG5%, RL

Indicaciones: Tratamiento a corto plazo del dolor moderado a severo. Tratamiento del dolor asociado al cólico nefrítico. Se podrá utilizar junto con analgésicos opiáceos cuando las D máximas recomendadas no sean suficientes, o cuando se pretenda reducir los requerimientos de opiáceos.

Dosis adulto: Inicio: **IM o IV:** 10 mg (30 mg en caso de dolor intenso) seguidas de 10-30 mg/4-6 h D máxima: 90 mg/día en adultos o 60 mg/día en ancianos. **Cólico nefrítico** se recomienda una dosis única de 30 mg por vía IM o IV.

Dosis pediatría: No se ha establecido su eficacia y seguridad en niños y adolescentes menores de 16 años.

Normas de administración: Puede administrarse como bolo directo en inyección de no menos de 15 seg. Es compatible con SF, SG5%, RL solución de Plasmalyte. Es compatible con aminofilina, lidocaína, morfina, meperidina, dopamina, insulina y heparina cuando se mezclan frascos o bolsas de infusión estándar. No debe mezclarse en la misma jeringa ketorolaco con morfina, meperidina, prometacina o hidroxicina ya que puede producirse precipitación del Ketorolaco. IM administración lenta y profunda.

Contraindicaciones: No debe asociarse con otros AINE ni con AAS, incluyendo inhibidores selectivos de la COX-2, puede producir reacciones alérgicas graves, incluyendo shock anafiláctico y broncoespasmo En pacientes con síndrome completo o parcial de Pólipos nasales. Angioedema. Espasmo bronquial. Asma. Insuficiencia renal moderada o severa e ICC grave.

Interacciones: Debe evitarse el uso simultáneo con otros AINE y AAS. El alcohol potencia su toxicidad. Potenciación de los efectos de los anticoagulantes, como los dicumarínicos.

Factor riesgo embarazo: Categoría C: 1º y 2º trimestre. Categoría D: 3º trimestre.

Reacciones adversas: Gastrointestinal: (1-10%): pirosis, náuseas, vómitos, diarrea, calambres abdominales, dispepsia, flatulencia, hemorragia gastrointestinal, úlcera gástrica o intestinal con o sin hemorragia o perforación. Insuficiencia Renal Aguda.

Precauciones: Debe utilizarse a las dosis e indicaciones recomendadas. La variación de estos parámetros puede aumentar el riesgo de toxicidad gastrointestinal grave, existiendo un mayor riesgo en ancianos o pacientes debilitados. Utilizar con precaución en pacientes con historial de úlcera gástrica, úlcera duodenal o intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa o con enfermedad de Crohn.

Ajuste dosis IR/IH: **IR:** Moderada o grave: Uso no recomendado. Leve: Administrar el 50% de la dosis recomendada. **IH:** Usar con precaución, puede causar elevación de enzimas hepáticas.

Antídotos/sobredosis: Se aplicará a los pacientes un tratamiento sintomático y de soporte. No hay antídotos específicos y la diálisis apenas permite eliminarlo.

Estabilidad: Diluido: 48 h a temperatura ambiente.

Conservación: Proteger de la luz.

MEPERIDINA, PETIDINA, DOLANTINA

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	PRESENTACIÓN	VÍA	SUEROS
DOLANTINA	PETIDINA, CLORHIDRATO (MEPERIDINA)	100 MG AMP 2 ML	IM, SC, IV, PERFIV	SF, SG10%

Indicaciones: Tratamiento del dolor severo, dolor postquirúrgico, neuralgias, de espasmos de la musculatura lisa (vías biliares, aparato genitourinario, etc.).

Dosis adulto: **Dolores severos:** Inicio: **IM o SC:** 25-100 mg cada 4 horas. **IV:** 25-50 mg cada 4 horas, **IV lenta** (se diluirá el contenido de la ampolla en 10 ml de SF O SG10%). **Ancianos:** La dosis inicial no debe exceder los 25 mg, pudiendo ser necesario reducir la dosis total diaria en caso de administraciones repetidas. Los ancianos pueden ser más sensibles a los efectos del hidrocóloro de petidina, especialmente a sus efectos depresores centrales.

Dosis pediatría: Sólo está indicado su uso como medicación preanestésica. Está contraindicado en niños menores de 6 meses. Inicio: **IM:** 1-2 mg/kg cada 4 horas.

Normas de administración: En la administración intramuscular o subcutánea no se precisa dilución. En la administración intravenosa lenta (1-2 minutos), se diluirá el contenido de la ampolla en 10 ml de SF O SG10%.

Contraindicaciones: Alergia a opioides. Niños menores de 6 meses. IR o IH grave. Depresión respiratoria grave. Coma. HIC. Feocromocitoma. Intoxicación etílica aguda y delirium tremens. Estados convulsivos. Uso concurrente de inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAOs). Contraindicado en IR/IH grave.

Interacciones: Potencian la toxicidad de la petidina: aciclovir, cimetidina, clorpromazina, antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos, antidiarréicos, agentes antiperistálticos (tales como loperamida y caolín), antiepilépticos incluidos fenobarbital y fenitoína, ritonavir y atropina. Potenciación mutua con alcohol etílico.

Factor riesgo embarazo: Categoría B. Categoría D: durante el 3º trimestre o próximo al parto.

Reacciones adversas: Sedación, apnea, hipotensión, náuseas, vómitos, miosis (a dosis altas midriasis), convulsiones, mioclonías, temblor, espasmo del músculo liso con estreñimiento, retención de orina, visión borrosa y prolongación del parto.

Ajuste de dosis IR/IH: **IR/IH:** leve a moderada, reducir la dosis. Contraindicada en grave.

Precauciones: Ancianos, EPOC, asma, enfisema pulmonar, hipovolemicos, TCE, alcoholismo crónico, TSV, hipertrofia prostática, pacientes con trastornos del tracto biliar, IH, IR, glaucoma.

Antídotos/sobredosis: Naloxona.



METAMIZOL

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	PRESENTACIÓN	VÍA	SUEROS
METAMIZOL MAGNÉSICO	METAMIZOL EFG	2 G AMP 5 ML	IM, IV, PERF IV	SF, SG 5%

Indicaciones: Dolor agudo post-operatorio o post-traumático. Dolor de tipo cólico. Dolor de origen tumoral. Fiebre alta que no responda a otros antitérmicos.

Dosis adulto: **IM o IV:** *D inicio:* Una ampolla por vía intramuscular profunda o intravenosa lenta (3 min), *D mantenimiento:* repetir cada 8 h. *D máxima:* 6 gr (3 ampolla) cada 24 h. La solución debe calentarse a la temperatura corporal antes de la inyección. En la indicación de dolor oncológico se utilizará ½ - 1 ampolla cada 6-8 horas por vía oral. **PERF IV:** Diluir la dosis prescrita en 50-100 ml de SF o SG5% y administrar en 30-60 min.

Dosis pediatría: **IM:** *D inicio:* En lactantes a partir del tercer mes de vida o de más de 5 kg de peso corporal y menores de un año, se administrará de 6,4 mg a 17 mg /kg, exclusivamente por vía intramuscular. En lactantes y niños, estas dosis únicas se pueden dar hasta 4 veces al día. En caso de fiebre en niños, generalmente es suficiente una dosis de 11 mg/kg. No está recomendado en neonatos o lactantes menores de tres meses. **IV:** Se puede utilizar intravenoso a partir del año de vida a dosis de: 6,4 - 17mg/kg cada 6 horas.

Tabla Metamizol Pediatría:

1 ml de solución inyectable contiene 400 mg de metamizol magnésico.

Edad (peso)	Solución inyectable
3-11 meses (5-8 kg)	0,1 - 0,3 ml
1-3 años (9-15 kg)	0,3 - 0,7 ml
4-6 años (16-23 kg)	0,4 - 1,1 ml
7-9 años (24-30 kg)	0,5 - 1,3 ml
10-12 años (31-45 kg)	0,7 - 2 ml
13-14 años (46-53 kg)	1,1 - 2,4 ml

Normas de administración: La administración parenteral de metamizol se debe realizar con el paciente tumbado. Debe utilizarse con precaución en pacientes con tensión arterial sistólica por debajo de 100 mm Hg. Debe disponerse de un equipo adecuado para el tratamiento de casos raros de choque. Para reducir al mínimo el riesgo de una reacción de hipotensión y para garantizar que la inyección se pueda interrumpir al primer signo de una reacción anafiláctica o anafilactoide, la inyección intravenosa administrada muy lentamente, sin exceder 1ml/ min.

Contraindicaciones: Alergia a metamizol u otras pirazolonas. Pacientes con síndrome conocido de asma por analgésicos. Pacientes con broncoespasmo u otras formas de reacción anafilactoide en respuesta a los salicilatos, paracetamol u otros analgésicos. Pacientes con porfiria hepática intermitente aguda. Pacientes con deficiencia genética de glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa (riesgo de hemólisis). Pacientes con alteraciones de la función de la médula ósea o enfermedades del sistema hematopoyético.

Interacciones: Metamizol puede causar una disminución de la concentración sérica de ciclosporinas. Junto con el alcohol, pueden potenciarse los efectos tanto de éste, como del fármaco. El uso concomitante con clorpromazina puede provocar hipotermia grave. Potencia la acción de los anticoagulantes. La eficacia de los antihipertensivos y diuréticos puede verse afectada por las pirazolonas. Potencia a dosis altas los efectos de algunos depresores del SNC. Reducción mutua de sus acciones con barbitúricos y fenilbutazona.

Factor riesgo embarazo: Categoría C.

Reacciones adversas: Puede producir sofocos, palpitaciones, hipotensión. Se han descrito casos de agranulocitosis. Riesgo de anafilaxia grave de 1/5.000.

Precauciones: Hipotensos o situación de inestabilidad hemodinámica. Asma o antecedentes de hipersensibilidad.

Antídotos/sobredosis: No hay antídoto específico. En cuanto al tratamiento, además de las medidas de soporte y lavado gástrico, carbón activado, puede emplearse la diálisis, puesto que el metamizol y sus metabolitos son hidrosolubles. Si hay convulsiones se empleará el Diazepam y si aparece metahemoglobinemia se administrará ácido ascórbico o azul de metileno.

Conservación: Proteger de la luz.



PARACETAMOL

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	PRESENTACIÓN	VÍA
PARACETAMOL	DOLOCATIL INFANTIL PERFALGAN	100 MG/ML SOLUCIÓN 10MG/ML AMP 100 ML	O PERFIV

Indicaciones: Tratamiento sintomático de la fiebre y dolor de intensidad leve a moderada.

Dosis adulto: **PERF IV:** *Dinicio:* Adultos > 50 kg: 1 gr en 15 minutos cada 4-6 horas. *Dmáxima:* 4 gr/día o 60mg/kg. Pacientes con alcoholismo crónico: 3 gr/día.

Dosis pediatría: **O:** La dosis diaria recomendada de paracetamol es aproximadamente de 60 mg/kg/día, que se reparte en 4 o 6 tomas diarias. 15 mg/kg en 4 tomas o 10 mg/kg en 6 tomas. *Dmáxima:* 80 mg/kg al día en niños con un peso menor de 37 kg.

Tabla paracetamol Pediatría: 15mg/kg cada 6 horas

Edad (peso)	Solución oral
0-3 meses (hasta 4 kg)	0,6 ml (60 mg)
4-11 meses (hasta 8 kg)	1,2 ml (120 mg)
12-23 meses (hasta 10,5 kg)	1,6 ml (160mg)
2-3 años (hasta 13 kg)	2,0 ml (200mg)
4-5 años (hasta 18,5 kg)	2,8 ml (280 mg)
6-8 años (hasta 24 kg)	3,6 ml (360 mg)
9-10 años (hasta 32 kg)	4,8 ml (480 mg)

Normas de administración: PERF IV durante al menos 15 min. En pacientes con ≤10 kg de peso, no perfundir directamente desde el vial/bolsa. El volumen de paracetamol a administrar se diluirá hasta 1/10 en una solución de SF o SG 5%. El intervalo mínimo entre cada administración debe ser de 4 h. No administrar más de 4 dosis/24 h.

Contraindicaciones: Pacientes con hipersensibilidad a paracetamol o a clorhidrato de propacetamol (profármaco del paracetamol). Insuficiencia hepatocelular grave.

Interacciones: Anticonvulsivantes (fenitoína, fenobarbital, metilfenobarbital, primidona): disminución de la biodisponibilidad del paracetamol así como potenciación de la hepatotoxicidad a sobredosis, debido a la inducción del metabolismo hepático.

Factor riesgo embarazo: Categoría B.

Reacciones adversas: Las reacciones adversas son raras o muy raras: malestar general, hipotensión, hipersensibilidad.

Precauciones: Insuficiencia hepatocelular, Insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina < 30 ml/min). Alcoholismo crónico, malnutrición crónica deshidratación.

Ajuste dosis IR/IH: **IR:** ClCr ≤30 ml/min: aumentar el intervalo mínimo entre cada administración a 6 h.

Antídotos/sobredosis: Tratamiento sintomático. Administración del antídoto, N-acetilcisteína, por vía IV u O, si es posible antes de que hayan transcurrido 10 h. Sin embargo, la NAC puede aportar algún grado de protección incluso después de 10 h, pero en estos casos, se administra un tratamiento prolongado. Pauta habitual de NAC (IV 150 mgr/kg (en 15 min.) + 50 mgr/kg en 4 h + 100 mgr/kg en 16 h.



TRAMADOL

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	PRESENTACIÓN	VÍA	SUEROS
TRAMADOL	TRAMADOL EFG	100 MG AMP 2 ML	IM, SC, IV, PERFIV	SF, SG5%

Indicaciones: Tratamiento del dolor de moderado a grave, agudo o crónico tal como el dolor quirúrgico, traumático u oncológico.

Dosis adulto: Dolores severos: IM o IV: D.inicio: 100 mg. **D.mantenimiento:** 50 mg/20 min durante una hora. **D.máxima:** 250 mg en total.

Dolores moderados: IM o IV: D.inicio: 50-100 mg en la primera hora. **D.mantenimiento:** 50-100 mg/6-8 h. **D.máxima:** 400 mg/24 h.

Dosis pediatria: niños hasta 12 años: **IM o IV: D.inicio:** 1,5 mg/kg. **D.mantenimiento:** repetir dosis cada 8 horas. **D.máxima:** 8 mg/kg/24 h o 400 mg/24 h. Niños mayores 12 años igual que adultos.

Tabla Tramadol Pediatría:

D.inicio: No precisa dilución (1ml=50mg)

D/P	5 kg	10 kg	20 kg	30 kg	40 kg
1 a 1,5 mg/kg	0,1-0,15 ml	0,2-0,3	0,4-0,6	0,6-0,9	0,8-1,2 ml

Normas de administración: Administrar en bolo lento (2-3 min) o en infusión a través de dispositivos de analgesia controlados por el paciente, con una velocidad de 12-24 mg/h. También por vía intramuscular o subcutánea.

Contraindicaciones: Alergia a opiodes. Depresión respiratoria y EPOC.

Interacciones: Anticoagulantes orales: potenciación de la acción anticoagulante. Antidepresivos ISRS (citalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina) y IRNS (duloxetina, venlafaxina): posible aparición de síndrome serotoninérgico. El riesgo de convulsiones asociado al tramadol puede verse potenciado por los antidepresivos. Fármacos que puedan disminuir el umbral convulsivo: depresores del SNC (alcohol, anestésicos, antidepresivos, relajantes musculares, narcóticos, fenotiazinas, hipnóticos, tranquilizantes), fármacos serotoninérgicos (ISRS, IRNS, antidepresivos tricíclicos, IMAO y triptanes), otros opiodes y neurolepticos. La asociación con cualquiera de estos fármacos puede precipitar ataques convulsivos. Usar con precaución.

Factor riesgo embarazo: Categoría C.

Reacciones adversas: Frecuentes: náuseas somnolencia y vértigos. Ocasionalmente: cefaleas, estreñimiento, vómitos, exceso de sudoración, sequedad de boca, confusión y mareo. Raramente: alteraciones de la regulación cardiovascular, especialmente en administración IV y en pacientes estresados físicamente, palpitaciones, taquicardia, hipotensión ortostática o síncope, arcadas, vómitos secos, irritaciones gastrointestinales, reacciones cutáneas, prurito, urticaria, convulsiones.

Ajuste de dosis IR/IH: IR: ClCr < 30 ml/min: debe incrementarse el intervalo posológico a 12 h. No se recomienda el uso en pacientes con ClCr < 10 ml/min. **IH:** el intervalo posológico debe incrementarse a 12 h.

Precauciones: Hipertensión. Hipotiroidismo. Asma. Insuficiencia hepática. Insuficiencia renal. Arritmias. Hipertrofia prostática. Convulsiones. Aumento de presión intracraneal. Ancianos.

Antídotos/sobredosis: Deben establecerse medidas de soporte como el mantenimiento de la función respiratoria y función cardiovascular; puede utilizarse naloxona para invertir la depresión respiratoria. Las convulsiones pueden ser controladas con diazepam. El tratamiento sólo con hemodiálisis o hemofiltración no es adecuado.





07/01/2025 10:23:10

CELDRAÑ GIL, FRANCISCO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-6f062e00-cc08-3202-8139-005056934e7

Información de Contacto

Este protocolo está sujeto a revisiones y actualizaciones periódicas con el fin de garantizar su eficacia y adaptabilidad. Para enviar sugerencias, propuestas de mejora o realizar consultas relacionadas con su contenido, puede utilizar el siguiente canal de contacto: [svae.061.sms.carm.es](sms:svae.061.sms.carm.es)

